

Hoitotyön taidot ja toiminnot

Hanna Rautava-Nurmi • Airi Westergård
Tarja Henttonen • Mirja Ojala • Sinikka Vuorinen

Hanna Rautava-Nurmi • Airi Westergård
Tarja Henttonen • Mirja Ojala • Sinikka Vuorinen

Hoitotyön taidot ja toiminnot

Tiedustelut

Sanoma Pro Oy, Helsinki

puh. 020 391 000

sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi

www.sanomapro.fi

Kustantaja: Sanoma Pro Oy

ISBN 978-952-63-5894-9

Tämä e-kirja vastaa sisällöltään vuonna 2020 ilmestynyttä samannimistä kirjaa (ISBN 978-952-63-5810-9).

Toimitus: Niko Haarala, Varpu Mitikka

Ulkoasu ja kansi: Sanoma Pro Oy, Veera Alanko

Taitto: Antero Airos

Kuvitus: Eduard Müller, Seija Rusanen

Kuvatoimitus: Nina Tuittu

© Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård, Tarja Henttonen,
Mirja Ojala, Sinikka Vuorinen ja Sanoma Pro Oy

Kopiointiehdot

Tämä teos on oppikirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61).

Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai muu digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan.

Kopioisto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia. Tarkistakaa, mitkä valokopiointi- ja digiluvat ovat kohdallanne voimassa. Lisätietoja luvista www.kopioisto.fi

Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty.

Ota käyttöön Arttu!

Lataa sovelluskaupasta ilmainen Arttu-sovellus, jolla voit avata kirjan videot, äänet ja verkkosisällöt. Arttu toimii Android- ja iOS-puhelimilla sekä -tableteilla.

Lisätietoa osoitteesta
<https://www.sanomapro.fi/arttu/>.

Tähän kirjaan liittyvät Arttu-sisällöt on merkitty  -logolla.



Sisällys

Lukijalle	9	Turvallisuuden periaate	28
1. Hoitotyön historia, hoitotiede ja ammatillinen kasvu	10	Kokonaishoidon periaate	29
1.1 Suomalaisen hoito-työn kehittyminen	11	Terveyskeskeisyyden periaate	29
Maallikkosairaanhoitajat ja diakonissat	11	Omatoimisuuden periaate	29
Sairaanhoitajakoulutus	11	Hoidon jatkuvuuden periaate	30
Florence Nightingale	12	3. Ihmiselämän ja hoitotyön monimuotoisuus	32
1.2 Hoitotieteen keskeiset käsitteet	12	3.1 Elämänvaiheisiin liittyvät osatekijät	33
Ihminen	13	Ihminen seksuaalisena olentona	34
Terveys	13	3.2 Vuorovaikutus – hyvän auttamistyön perusta	37
Ympäristö	13	Hoitosuhte	37
Hoitotyö	14	3.3 Monimuotoisuuden ymmärtäminen hoitotyössä	38
1.3 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen	15	Sairastumisen aiheuttamat muutokset	38
Ammatillinen kasvu	15	Vieraskielinen potilas ja vuorovaikutus	39
Reflektio	15	3.4 Vuorovaikutusta auttavia menetelmiä	39
Reflektiomenetelmiä	16	3.5 Monikulttuurinen hoitotyö	40
Reflektiomalli hoitotilanteiden puntarointiin	17	Kulttuurikompetenssi	42
1.4 Hoitotyön opiskelu ja tutkimukset ammattikorkeakouluissa	18	Kulttuurisen erilaisuuden kohtaaminen hoitotyössä	43
Hoitohenkilökunnan täydennyskoulutus	20	Kulttuurisesti ainutlaatuinen potilas	45
Hoitotieteen opiskelu yliopistossa	20	4. Hoitotyön prosessi ja näyttöön perustuva dokumentointi	48
2. Hoitotyön arvot, periaatteet ja lainsäädäntö	22	4.1 Kirjaamista ja tiedonhallintaa ohjaa lainsäädäntö	49
2.1 Sairaanhoitajan eettiset ohjeet	23	1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)	50
I Sairaanhoitajan tehtävä	23	2. Laki sosiaali- ja terveyden-huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010)	50
II Sairaanhoitaja ja potilas	23	3. Sosiaali- ja terveys-ministeriön asetus potilas asiakirjoista (2009/298)	50
III Sairaanhoitajan työ ja ammattitaito	24	4. Terveystietolaki (2010/1326)	52
IV Sairaanhoitaja ja työtoverit	24	5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/ 1994)	53
V Sairaanhoitaja ja yhteiskunta	24	4.2 Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen	53
VI Sairaanhoitaja ja ammattikunta	24	4.3 Kirjaamisen perusta: hoitotyön prosessi	54
2.2 Hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset	25	Hoidon tarve (SHTaL)	56
Ihmisarvo	25	Hoidon tavoitteet (SHTaL)	57
Ihmiskäsitys	26	Suunnitellut toiminnot (SHToL)	57
2.3 Hoitotyön periaatteet	26		
Kunnioittamisen periaate	27		
Yksilöllisyyden periaate	27		
Itsemääräämisoikeuden periaate	27		
Yksityisyyden periaate	28		
Perhekeskeisyyden periaate	28		

Hoidon toteutus (SHToL)	58	Tartuntaa välittävä tekijä	107
Hoidon arviointi (SHTuL)	58	Tartuntaportti	107
4.4 Hoitoisuus ja hoitoisuusluokitukset	59	Tartunnan kohde ja kohteen vastustuskyky	107
4.5 Hoitotyön raportointi	60	7.2 Hoitoon liittyvät infektiot ja niiden torjunta	109
5. Terveyskäyttäytyminen	62	7.3 Käsihygieniä	110
5.1 Terveysteen vaikuttavat elintavat	63	Käsien peseminen	110
Ravitseminen	64	Käsien desinfiointi eli käsihuuhteen käyttö	112
Liikunta	65	Suojakäsineiden käyttö	113
Päihteiden käyttö	66	Ihon ja kynsien hoitaminen	116
5.2 Terveyttä edistävä ohjaus	69	Korujen ja kellon käyttäminen	116
5.3 Julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä	71	7.4 Henkilöhygieniä	116
5.4 Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja kolmas sektori	73	7.5 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi	118
Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu	74	Puhdistus	119
5.5 Terveysteden edistämisen ammattilaiset	74	Desinfiointi	119
5.6 Sairaaloitten toimintayksiköt	77	Sterilointi	121
6. Ihmisen aistit ja niiden toiminta	80	7.6 Välinehuoltokeskus	121
6.1 Aistien toiminta	81	7.7 Ympäristön hygieniä	122
Kuuloaisti	81	Jätehuolto	123
Kuulokojeen huoltaminen	83	7.8 Infektioiden torjunnan organisaatio	123
Sisäkorvaistute	83	Moniresistentit mikrobit	124
Näköaisti	85	7.9 Infektion vuoksi eristäminen	125
Haju- ja makuaisti	91	Eristysluokat ja varotoimet	126
Tuntoaisti	92	Eristyshoidon toteuttaminen	126
Tasapainoaisti	93	Suojaeristuksen toteuttaminen	128
6.2 Kipu	94	7.10 Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistaminen	129
Kipu ja kulttuuri	95	Steriiliin pöydän tekeminen	129
Kivun arviointi	95	Toimenpidealueen ihon desinfiointi	130
Kivun mittaaminen ja hoito	99	8. Lääkehoito	132
6.3 Tajunnan tason seuranta	101	8.1 Lääkehoidon keskeiset käsitteet	133
7. Aseptiikka hoitotyössä	104	8.2 Turvallinen lääkehoito	134
7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät	105	8.3 Lääkehoito hoitolaitoksessa	135
Tartunnan aiheuttajat	105	Lääkkeiden toimittaminen	135
Tartunnan lähde	106	Lääkkeiden säilytys	136
Tartuntatapa	106	Lääkkeen määrääminen	137
Tartuntatie	106	Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin	138
		Lääkkeen antaminen potilaalle	141
		8.4 Lääkkeen vaikutuksen seuranta	141

8.5 Lääkkeiden vaikutusmekanismit	143	9.6 Jalkojen hoito	199
8.6 Lääkkeen vaikuttavuuden seuranta	144	9.7 Hoitajan ergonomia	202
8.7 Lääkehoidosta poikkeaminen	146	Ergonomiset avustusmenetelmät	203
8.8 Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat	147	9.8 Liikkumisessa avustaminen	203
Lääkkeiden antaminen suun kautta	147	Potilaan liikkumisen avustamisen apuvälineet	204
Lääkkeiden antaminen ruiskeena eli injektiona	149	Vuodepotilaan liikkumisessa avustaminen	206
Laskimonsisäinen eli intravenoosinen lääkitys	162	Aktiiviset liikeharjoitukset	208
Lääkkeiden antaminen peräsuoleen eli rektaalisesti	164	Passiiviset liikeharjoitukset	209
Lääkkeiden antaminen hengitysteihin intrapulmonaalisesti eli inhalaationa	164	Asentohoito	210
Lääkkeiden antaminen iholle eli perkutaanisesti tai transdermaalisesti	165	Aivoverenkiertohäiriöpotilaan asentohoito	212
Lääkkeiden antaminen emättimen kautta eli vaginaalisesti	166	Potilaan istumaharjoituksista huolehtiminen	213
Lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta	166	Potilaan seisomaharjoituksista huolehtiminen	216
8.9 Lääkkeiden annosteluun liittyvät apuvälineet	168	Potilaan kävelyn avustaminen	217
8.10 Lääkehoidon ohjaus	169	Päivittäisten toimintojen apuvälineet	221
9. Päivittäiset toiminnot	172	9.9 Aktiviteettia edistävä toiminta	221
9.1 Ihon perushoito	173	Viriketoiminta	222
Terve iho	173	Leikki	222
9.2 Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen	174	Toiminnallinen kuntoutus ja fysioterapia	223
Potilasvuode ja sen ympäristö	175	10. Sairaalan ihon ja haavojen hoito	224
9.3 Unen ja levon tarve	178	10.1 Ihon kunnon seuranta	225
Uni- ja valvetilan seuranta	178	Sairas iho	226
Uneen ja lepoon liittyvät ongelmat	182	10.2 Haava ja haavapotilaan hoito	226
Unta edistävä toiminta	183	Akuutti haava	228
9.4 Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen	187	Krooninen haava	229
Vuodepesu	189	Infektoituneen haavan hoito	232
Hiusten pesu	191	10.3 Painehaavan ehkäisy ja hoito	233
Parranajo	192	10.4 Sidonta	238
Potilaan avustaminen suihkussa	192	Sidostyypit	238
Pukeutumisessa avustaminen	193	Haavasidos	239
9.5 Suun ja hampaiden hoito	195	Haavasidosten poisto haavasidosta vaihdettaessa	240
Kuiva suu	195	10.5 Haavapotilaan ohjaus	240
Hampaiden hoito ja potilaan ohjaus	195	11. Ravitseminen	242
Hampaiden hoidossa avustaminen	197	11.1 Ravitsemustila	244
Hammasproteesien puhdistaminen	198	11.2 Ravitsemuskartoitus	245
Suun limakalvojen muutokset	198	Biokemialliset määritykset	246
		Antropometriset mittaukset	246
		Kliinisten oireiden havainnointi	247
		11.3 Ravitsemukseen liittyvä ohjaus	249

11.4 Ruokailu sairaalassa	250	13.6 Laskimoverinäytteen ottaminen	316
Erityisruokavaliot	252		
Ruokailun järjestäminen	252	14. Hengitys	318
Aliravitseminen	254		
11.5 Ravinnottaolo	257	14.1 Hengityselimistön rakenne ja toiminta	319
11.6 Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta	257	14.2 Hengityksen seuranta	320
11.7 Ravitseminen mahalaukkuavanteen kautta	264	Hengitystaajuus	320
11.8 Suonensisäinen ravitseminen	265	Hengitystapa	321
11.9 Verensokerin tarkkailu	266	Hengityksen rytmi ja syvyys	321
		Hengityssäätimet	321
12. Erittäminen	270	Eritteet, haju ja ihon väri	322
12.1 Virtsautaminen	271	14.3 Hengityksen helpottaminen	324
Virtsaelimistön rakenne ja toiminta	271	Asentohoito	324
Virtsan tarkkailu	272	Hengitysharjoitukset ja keuhkojen tyhjennys	325
Virtsan kemialliset perustutkimukset	274	Positiiviseen paineeseen puhalluttaminen	326
Potilaan ohjaus ja avustaminen virtsaamisessa	277	14.4 Mittaukset	327
Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito	279	PEF-seuranta	327
Kestokatetrihoidon toteuttaminen	282	Happikylläisyyden seuranta	328
Kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi	287	14.5 Hapen antaminen	329
Virtsa-avanne ja rakkoavanne	287	Happipullot	333
Virtsatietulehduspotilaan hoito	288	Kotihappihoito	334
12.2 Ulostaminen	291	Hapenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus	335
Ummetuspotilaan hoito	293	14.6 Liman imeminen	336
Ripuloivan potilaan hoito	296	Ylähengitysteiden imeminen	337
Avannepotilaan hoito	297	14.7 Hengityksen hoito invasiivisilla välineillä	339
12.3 Pahoinvointi ja oksentelu	300	Larynxmaski	339
		Intubaatio	339
13. Nestetasapaino	304	Henkitorviavanne eli trakeostooma	340
13.1 Nestetasapainon säätely	305	14.8 Hengitysvajauspotilaan hoito	343
Elimistön vesimäärä	305	14.9 Hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus	347
Elimistön suola- eli elektrolyytitasapaino	306		
Elimistön happo-emästatapaino	307	15. Verenkierto	350
13.2 Nestetasapainon seuranta ja arviointi	309	15.1 Verenkiertoelimistön toiminta	351
13.3 Nestetasapainon laskeminen	311	15.2 Verenkierron seuranta	352
Nestelista	312	Sydämen sykkeen seuranta ja mittaus	355
13.4 Nesteytyksestä huolehtiminen	314	Sydämen rytmin seuranta	356
13.5 Kuivuminen ja ylinesteytyminen	315	Verenpaineen mittaus ja seuranta	360
		Ihon värin, lämmön ja kosteuden seuranta	365
		15.3 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito ja apuvälineet	366

15.4 Potilaan ohjaus verenkierron ylläpitämiseksi	367	18 Hoidon ja jatkohoidon koordinointi	414
15.5 Kehon lämpötasa-painosta huolehtiminen	369	18.1 Hoitotyön jatko-hoidon suunnitelman laatiminen	415
15.6 Kehon lämpötilan mittaaminen	370	18.2 Jatkohoidon ja kontrollikäyntien järjestäminen	416
15.7 Kuumeisen potilaan hoitotyö	372	18.3 Jatkohoitoon liittyvä ohjaus	418
15.8 Alilämpöisen potilaan lämpötilan ylläpito	373	Kirjallisuus	420
15.9 Peruselintoimintojen arviointi ja seuranta	373	Hakemisto	431
16. Turvallisuus	376		
16.1 Turvallisen ympäristön järjestäminen	377		
Potilaan henkilökohtainen omaisuus	378		
16.2 Potilaan liikkumisen rajoittaminen ja seuranta	379		
16.3 Tapaturmariskin huomioiminen	382		
16.4 Tapaturmariskin vähentäminen	382		
17. Ihmisen voimavarojen tukeminen	386		
17.1 Ihmisen heikentyneet voimavarat	387		
Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan	387		
17.2 Potilaan voimavarojen tukeminen	388		
Elinympäristö	393		
Eläimet yksinäisyyden ehkäisijöinä	394		
Muistelu ja muistot	396		
17.3 Potilaan toimintakyvyn ja selviytymisen ylläpitäminen	397		
Puhekyvyn ongelmat ja kommunikaatio	398		
Ihmissuhteet ja läheisyys	400		
Potilaan kohtaaminen	401		
17.4 Saattohoito	402		
Potilaan toiveiden toteuttaminen kuoleman lähestyessä	403		
Kuoleman merkkien toteaminen	406		
Kuolevan potilaan läheisten tukeminen ja ohjaus	408		
Vainajasta huolehtiminen	409		
Omaisien neuvominen kuoleman jälkeen	412		

Lukijalle

Uudistettu Hoitotyön taidot ja toiminnot antaa lukijalle perustiedot potilaslähtöisestä, turvallisesta ja näyttöön perustuvasta hoitotyöstä. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi ammattikorkeakouluissa opiskeleville sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoille, mutta sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös sosiaali- ja terveystieteiden toisen asteen koulutuksessa sekä käsikirjana. Lisäksi kirjaa voivat hyödyntää sosiaali- ja terveystieteiden opettajat opetustyössään ja hoitotyön ammatillaiset hoitotyön opiskelijoiden ohjaamisessa.

Hoitotyöntekijästä käytetään tässä kirjassa nimitystä "hoitaja" kuvaamaan potilasta kohtaavaa työntekijää. Nimityksellä "potilas" taas tarkoitetaan terveydenhuollon palveluja käyttävää aktiivista, omaan hoitoonsa osallistuvaa tasavertaista toimijaa.

Kirjan tavoitteena on luoda osaamisen perusta opiskelijan hoitotyön taidoille ja toiminnoille. Sisällön keskeiset teemat ovat potilaan tarpeista lähtevä hoitotyö ja terveyden edistämisen periaate. Kirjassa tuodaan esille ammatillisen osaamisen keskeiset ydinsisällöt ja ydinosaaminen, hoitotieteen keskeiset käsitteet, hoitotyön arvot ja periaatteet, vuorovaikutus ja monikulttuurisuus, terveyskäyttäytyminen sekä keskeiset kliniset hoitotyön taidot ja toiminnot. Kirja sisältää runsaasti turvalliseen käytännön hoitotyöhön opastavia kuvitettuja toimintaohjeita.

Kirja mukailee suomalaista hoitotyön tarve- ja toimintoluokitusta (FinCC-luokitus), ja se on osittain jäsennelty luokituksen komponenttien mukaan. Hoitotyön prosessi ja systemaattinen kirjaaminen tulevat opiskelijalle tutuiksi kirjan hoitosuunnitelmaesimerkeissä, joissa hoitotyön prosessi on kuvattu rakenteellisesti kirjaamisen mukaisesti. Tässä painoksessa on vielä käytetty luokitusta FinCC 3.0, koska uusi luokitus FinCC 4.0 julkistettiin 16.12.2019 ja päivitettiin vielä huhtikuussa 2020 eli tämän painoksen valmistuttua.

Vaikka kirja antaa perustiedot hoitotyössä tarvittavista taidoista ja toiminnoista, lukijan on aina selvitettävä eri organisaatioiden omat toimintaohjeet kulloisestakin asiasta ja päivitettävä tietojansa ammatillan lähdekirjallisuudesta. Lukuihin on koottu aihetta käsittelevää kirjallisuutta, hoitosuosituksia, tutkimuksia ja internetlinkkejä kannustamaan lukijaa etsimään lisätietoa muista lähteistä ja siten syventämään tietojansa. Kirjan toivotaan antavan lukijalle välineitä potilaan tarpeiden tunnistamiseen, potilaan hyvän hoidon edistämiseen, keskusteluun hoitotyön ydinkysymyksistä, hoitajan ja opiskelijan oman toiminnan kriittiseen arviointiin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Kaikilla kirjoittajilla on pitkäaikainen kokemus hoitotyön opetuksesta.

Kirjan 6., uudistetun painoksen sisältö on keskeisiltä osiltaan aiempia painoksia vastaava. Sisältö, esimerkiksi kivunhoito ja ravitsemussuositukset, on päivitetty vastaamaan ajantasaisia suosituksia ja käytäntöjä. Lisäksi joitakin sisältöjä, kuten hoitoelvytys, on poistettu. Aihekokonaisuuksia on myös järjestetty uudella tavalla, minkä myötä rakenne on hieman muuttunut aiemmasta.

Opiskelija voi nyt testata osaamisensa, sillä uutena ominaisuutena lukujen loppuun on lisätty digitaalista Arttu-lisäsisältöä. Lukujen sisällön kertaavat monivalinta- ja väittämätehtävät avautuvat älypuheliin Arttu-sovelluksella lukujen lopussa olevasta kovalinkistä.

Tammikuussa 2019

Tekijät

Kirjoittajat

Hanna Rautava-Nurmi, TtM, ESH, SH
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, leikkaus-
anestesiahoitotyö
Airi Westergård, TtM, ESH, SH
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kirurginen
hoitotyö ja tehohoitotyö

Tarja Henttonen, TtM, ESH, SH
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kirurginen
hoitotyö ja syöpätautien hoitotyö
Mirja Ojala, KM, SHO, ESH, SH
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sisätautihoi-
totyö
Sinikka Vuorinen, KM, SHO, ESH, SH
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, syöpätautien
hoitotyö

1

Hoitotyön historia, hoitotiede ja ammattillinen kasvu

Tässä luvussa

- Suomalaisen hoitotyön kehittyminen: Sairaanhoidajakoulutuksen historia ja Florence Nightingale
- Hoitotieteen keskeiset käsitteet: Ihminen, terveys, ympäristö, hoitotyö
- Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
- Hoitotyön opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa



Tärkein opetus, joka sairaanhoitajille voidaan antaa, on opettaa heille, mitä on tarkkailtava, miten on tarkkailtava, mitkä merkit viittaavat tilan paranemiseen ja mitkä tilan huonontumiseen ja mitkä ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Tämän kaiken pitäisi olla sairaanhoitajan koulutuksen olennainen osa. (Florence Nightingale)

Hoitotyöntekijän ammatillinen kasvu edellyttää oman ammattikunnan kehityksen ja historian tuntemusta, sillä historian tuntemuksen avulla voidaan ymmärtää nykyaikaa ja ennakoida tulevaa. Hoidon historia ulottuu aikaan ennen ajanlaskumme alkua, sillä ihmiskunnan varhaisimpia sosiaalisia tehtäviä on ollut läheisistä huolehtiminen heidän sairastuessaan tai vammautuessaan. Näin on kehittynyt käytännön tietoa ja taitoa sairauksien hoidosta, ja nämä tiedot ja taidot ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Sairaanhoidon historiaan ovat vaikuttaneet kansojen sivistystaso, kulttuuri, esiintyvät sairaudet, uskonnot ja sodat sekä tieteen ja tekniikan kehitys.

➔ Haho, A. 2006. Hoitamisen olemus. Hoitotyön historiasta, teoriasta ja tulkinnasta hoitamista kuvaviin teoreettisiin väittämiin. Väitöskirja. Oulun yliopisto.



Sairaanhoitajan tehtäviä eri aikakausina hoitaneita:

- tietäjänaiset
- papittaret
- alkuseurakuntien diakonissat
- seurakuntien neitseet ja lesket
- benediktiiniläismunkit
- luostareissa eläneet naiset
- parturi-haavurit
- ristiritarit
- begiininaiset
- fransiskaaneljet
- maallikkohoitajat.

1.1 Suomalaisen hoitotyön kehittyminen

Maallikkosairaanhoitajat ja diakonissat

Suomalaisen hoitotyön edelläkävijöitä olivat maallikkosairaanhoitajat ja diakonissat. Maallikkosairaanhoitajat eivät saaneet hoitotyön koulutusta, mutta he edustivat merkittävää perinnettä hoidon antajina. He olivat välttämättömiä, jotta sairaista voitiin huolehtia kodeissa ja sairaaloissa siltä osin kuin se ei kuulunut lääketieteelliseen toimintaan.

Diakonissat olivat ensimmäiset Suomessa sairaanhoitoon koulutetut naiset. Helsingin Diakonissalaitos perustettiin 1867 everstinna Aurora Karamzinin aloitteesta ja hänen taloudellisella tuellaan. Laitoksen perustamisen jälkeen Suomeen perustettiin 1800-luvulla vielä kolme muuta diakonissalaitosta: Viipuriin, Sortavalaan ja Ouluun. Diakoninen ajattelu perustuu kristilliseen rakkauteen. Helsingin Diakonissalaitoksessa hoidettiin sairaita ja turvattomia lapsia.

Helsingin Diakonilaitoksessa alettiin kouluttaa diakonissoja keskieurooppalaisen mallin mukaan. Heitä koulutettiin sairaiden ja kärsivien auttajiksi, ja he saivat opintojensa alusta alkaen sairaanhoidon opetusta. Koulutuksen lääketieteellinen perusta oli laaja, ja opetusta annettiin ainakin anatomiasa, fysiologiassa, ensiavussa, dieettiopissa ja tarttuvien tautien hoidossa. Opiskelijoille opetettiin myös sairaanhoidon periaatteita ja ammatin etiikkaa. Teoriaopetuksen ohella harjoiteltiin myös käytäntöä. Monien vaiheiden kautta diakonissalaitosten koulutusta antavista yksiköistä on syntynyt Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa ympäri Suomea muun muassa sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.

Sairaanhoitajakoulutus

Vuonna 1879 Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten (vuodesta 1920 alkaen Suomen Punainen Risti) päätti jatkuvasta sairaanhoitajien kouluttamisesta omaan tarpeeseensa. Vapaaherratar Sophie Mannerheim, joka

nimitettiin vuonna 1904 kirurgisen sairaalan ylihoitajaksi, vaikutti merkittävästi koulutuksen kehittämiseen. Hän oli opiskellut sairaanhoitajaksi Englannissa St. Thomasin sairaalan Nightingale-koulussa 1899–1902.

Läänin sairaaloissa koulutettiin vuodesta 1883 lähtien sairaanhoitajattaria. 1920-luvun alkuvuosina syntyi Suomen terveyssisarlaitos. Terveyssisaren työssä korostuivat sairauksien ehkäisy, terveydenhoidollinen valistustyö, ohjaus ja opetus. Vapaat kansalaisjärjestöt olivat terveysisartyon aloittajia. Vuonna 1928 valtioneuvoston päätöksellä annettiin laki sairaanhoitajakoulutuksesta. Valtio piti yllä sairaanhoitajakouluja, ja silloinen koulutus kesti yhteensä kolme vuotta. Koulutukseen sisältyi erikoistumisjakso.

Vuonna 1957 tuli voimaan päätös, jossa perus- ja erikoistumiskoulutus erotettiin toisistaan. Sairaanhoitajatutkinto suoritettiin sairaanhoitajakoulussa kahden ja puolen vuoden aikana. Jatko-opinnoilla oli mahdollista suorittaa kliinisen sairaanhoidon tai terveydenhoidon erikoissairaanhoitajan tutkinto.

Seuraavaksi sairaanhoitajakoulutus muuttui vuonna 1987. Sairaanhoitajaksi haluavalla oli mahdollisuus hakeutua peruskoulun jälkeen terveydenhuollon peruslinjan yleisjaksolle. Tästä oli mahdollista jatkaa opintoja koulu- tai opistoasteen erikoistumislinjalle. Opistoasteella oli neljä erilaista sairaanhoitajan koulutussuuntaa sekä terveydenhoitajan ja kättilön koulutussuunnat. Terveysalan ammatillisessa koulutuksessa aloitettiin vuonna 1991 ammattikorkeakoulukokeilu. Nykyään sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan ainoastaan ammattikorkeakouluissa.

Florence Nightingale

Vuonna 1820 syntynyt Florence Nightingalea voidaan pitää nykyaikaisen sairaanhoidon luoja. Florence Nightingale opiskeli lääketiedettä ja hoitotyötä Manner-Euroopassa ja toimi lontoolaisessa yläluokan naisten sairaalassa hoitotyön ohjaajana. Vuonna 1854 hän sai Englannin sotaministeriltä määräyksen lähteä Krimiin järjestämään brittiso-

tilaiden sairaanhoitoa. Hän sai mukaansa 38 hoitajaa. Krimillä sairaalat olivat erittäin huonossa kunnossa, ja Nightingale ryhtyi uudistamaan sairaaloita huolimatta armeijan alkuvaiheen vastustuksesta. Hänen onnistui perustaa pesula ja keittiöitä ja hankkia hoidossa käytettäviä välineitä. Puoli vuotta Krimille tulonsa jälkeen hän oli saanut potilaiden kuolleisuuden vähenemään sairaaloissa 42,7 prosentista 2,2 prosenttiin. Krimin ajoilta on peräisin Florence Nightingaleen liitetty kutsumanimi *The Lady with the Lamp*, joka johtui siitä, että hänen kerrotaan kulkeneen öisin sairaalassa tutustumassa sairaalan oloihin ja valvomassa potilaiden hoitoa lamppunsa valossa. Hän kulki osastoilla öisin, koska hän oli päivisin kiireinen laatiessaan tilastoja sairaaloiden tilanteesta.

Nightingale kiinnitti erityistä huomiota siihen, millainen vaikutus ympäristöllä on ihmisen terveyteen. Hän laati Krimillä tilastoja ja graafisia esityksiä hoitotyön vaikuttavuudesta ja vakuutti niiden avulla Britannian hallituksen hoidon hyödyllisyydestä. Vuonna 1860 Nightingale perusti koulun sairaanhoitajille (*Nightingale Training School for Nurses*) ja teki sairaanhoitajan ammatista kunnioitetun ammatin keskiluokkaiselle naiselle.

Florence Nightingale on kirjoittanut sairaanhoitoa koskevan kirjan, joka on suomennettu nimellä *Sairaanhoidosta*. Kirjan sanoma elää edelleen, vaikka iso joukko hänen painottamia asioita on valitettavasti jäänyt nykyisin vähäisemmälle huomiolle. Hoitotyön ydinsisältö ei kuitenkaan ole muuttunut vuosisatojen saatossa. Sairaanhoitajan perustehtävä on edelleen ihmisen perustarpeiden tyydyttämisestä huolehtiminen.

1.2 Hoitotieteen keskeiset käsitteet

Hoitamisen tavoitteina ovat ihmisten ja yhteisöjen terveys sekä terveyden ylläpitäminen ja edistäminen ihmisten omassa elämäntilanteessa ja heidän olemassa olevien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Hoitotyö voi olla auttamista perustarpeiden tyydyttämiseksi, ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksellista tukemista, ihmisen

kehitykseen ja kasvuun vaikuttamista sekä sairauksien hoitoa.

Potilaan yksilöllinen hoito on keskeinen hoitotyön periaate, ja hoitaja ottaa potilaan yksilöllisyyden huomioon toteuttaessaan hoitoa. Hoito on ollut yksilöllistä, jos potilaan kliininen ja henkilökohmainen tilanne on huomioitu hoidossa ja potilas on osallistunut hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

➔ Korhonen, T., Holopainen, A., Kejonen, P., Meretoja, R., Eriksson, E. & Korhonen, A. 2015. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva hoitotyö 13 (1), 44–51.

Ihminen

Ihmistä tarkastellaan hoitotyössä paitsi potilaina tai asiakkaana myös ihmisenä. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja ansaitsee yksilöllisen huomion ja hoidon. Potilasta on kunnioitettava tavalla, joka turvaa itsenäisen ja vastuullisen päätöksenteon häntä koskevista asioista. Potilaan velvollisuus on puolestaan toimia saamansa informaation mukaisesti yhteistyössä hoitajan kanssa ja kantaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja itsehoidostaan. Se, millaisena ihmistä hoitotyössä ja -tieteessä pidetään, vaikuttaa siihen, miten ihmisenä olemisen päämäärä ja tarkoitus ymmärretään. Hoitotyössä tulee korostua pyrkimys inhimilliseen arvokkuuteen, humanisuuteen ja yksilön kunnioittamiseen. Hoitotyössä ihminen on psykofyysinen, tiedostava ja sosiaalinen kokonaisuus sekä perheensä ja yhteisönsä jäsen. Terveystieteessä hän taas on palvelujen käyttäjä ja vastaanottaja.

Terveys

Terveys tarkoittaa ihmisen hyvinvoinnin tilaa, johon kuuluu hänen oma kokemuksensa terveydestään ja sairaudestaan. Terveystieteen tutkimuksen mukaan, ettei ole olemassa absoluuttista terveyttä. Sairaus ja terveys ovat sopimuksenvaraisia ja muuttuvia käsitteitä. Se, mikä katsotaan sairaudeksi tai terveydeksi, riippuu kulttuurin arvoista, yhteiskunnan resursseista ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Terveyttä saatetaan pitää jonkinlai-

sena selviönä, jonka arvo huomataan vasta sairastumisen jälkeen. Terveystieteen liitetään toimintakyky, kyky toteuttaa itseään ja hyvinolontunne. Toimintakyky on yksilön kokemaa vapauden- ja riippumattomuuden tunnetta. Kun ihminen kykenee huolehtimaan itsestään ja läheisistään, hän pystyy hallitsemaan voimavarojaan ja kokee elämän mielekkääksi. Hoitotyössä terveyttä pidetään ihmisen voimavarana.

Yksilön hyvinvointi on ihmisen kykyä käyttää sisäisiä voimavarojaan. Ihmisen sisäiset voimavarat vaikuttavat siihen, millä tavalla hän kokee esimerkiksi terveyteen liittyvät muutokset elämässään. Kun ihmisen terveys heikkenee, myös hänen voimavarojensa vähenevät. Ihminen altistuu koko elämänsä ajan erilaisille kuormittaville tekijöille (fysisille, psyykkisille, biologisille tekijöille), joiden kohtaamiseen hän käyttää voimavarojaan. Voimavaroja vähentävät monet biologis-fysiologiset ongelmat, kuten kipu, pahoinvointi, hengitysvaikeudet, verenkierron häiriöt tai levon puute. Näiden vaivojen poistaminen tai lievittyminen taas lisää voimavaroja.

Ympäristö

Ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten ulkoisia ja sisäisiä ympäristöjä, joihin myös hoitotyön ympäristö kuuluu. Sisäinen ympäristö tarkoittaa kehityksellistä tilaa, ihmisen tietoisuutta, elintoimintoja ja emotionaalisia ja hengellisiä tai henkisiä tekijöitä. Ulkoinen ympäristö taas tarkoittaa kaikkea ihmisen ulkopuolella olevaa, johon sisältyvät omat ja perheen toiminnot sekä taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Potilaalla on oma taustansa ja elämänsähistoriansa myös sairaalassa ollessaan. Potilaan tausta ja historia vaikuttavat siihen, miten potilaan hoidossa pystytään etenemään. Hoitajan on tunnettava potilaan kotiolot, kun suunnitellaan potilaan jatkohoitoa kotona sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Oma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää, ja erityisen merkittäviksi ne nousevat silloin, kun ihmisen toimintakyky on tavalla tai toisella heikentynyt. Potilaan hoitoympäristön tarkastelussa hoitaja tunnistaa ja tiedostaa potilaan

sairauden tuomat vaatimukset ja rajoitukset. Hoitoympäristö koostuu fyysisestä hoitoympäristöstä, henkilökunnasta ja sen toiminnasta, ilmapiiristä sekä hoitotyön käytännöistä.

Ihminen voi kokea ympäristönsä eri tavoin eri rooleissa. Hoitotyötä tehdessään hoitaja katselee ympäristöä ammatillisesti, mutta potilaana ollessaan hän saattaa kokea sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvin erilaiseksi. Ympäristön merkityksen tiedostaminen hoitajan toiminnan ja potilaan hoidon näkökulmasta on hoitotyössä välttämätöntä. Ympäristön hyvin tunteva hoitaja kykenee tunnistamaan tapoja, joilla hän voi lisätä toimintansa turvallisuutta ja tehokkuutta.

➔ Elo, S. Saarnio, R. & Isola, A. 2013. Hoitajien näkemyksiä muistisairaana fyysisestä hoitoympäristöstä. *Tutkiva hoitotyö* 11 (3), 17–25.

Hoitotyö

Hoitotyön määritelmä on vuosien mittaan laajentunut kuvaamaan yhä selvemmin hoitajan rooleja ja tehtäviä. Hoitotyö on saavuttanut tunnustusta professiona, eli sen katsotaan pohjautuvan hyvin määriteltyn teoria pohjaan, asiantuntijuuteen, jatkuvaan tutkimukseen, autonomiaan ja siihen, että hoitotyön ammattilaiset asettavat standardeja työlleen.

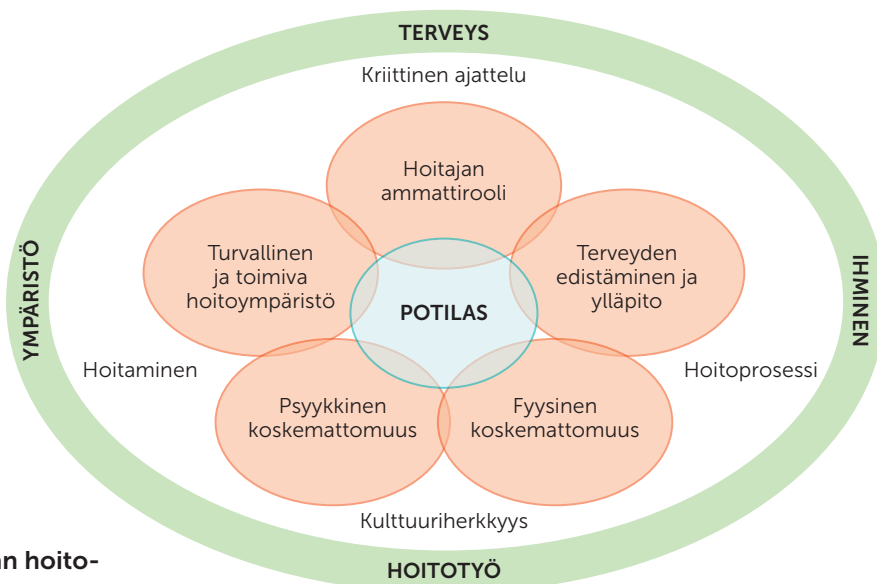
Hoitotyön päätarkoituksena on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia, säilyttää terveyttä ja auttaa tai tukea ihmisiä sopeutumaan eri tilanteisiin. Hoitaja käyttää teorian tietämystään ja käytännön taitojaan hoitaessaan potilaita ja pyrkiessään hoitotyön tavoitteisiin. Hoitajan tehtävänä on tunnistaa potilaan ongelmat, auttaa ja tukea häntä hänen ongelmissaan ja pyrkiä vähentämään tai poistamaan sairauden aikaansaamaa kipua, pelkoa, häpeää ja muita mahdollisia haittoja. Kun ihminen sairastuu, myös hänen läheisensä kokevat tilanteen pelottavaksi ja ahdistavaksi. Hoitotyössä on totuttu tukemaan sairastunutta, mutta aivan liian usein hänen omaisensa tai läheisensä jäävät ilman tarvitsemaansa tukea. Sairaanhoidajan yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin olla yhteydessä potilaan omaisiin tai läheisiin etenkin silloin, kun potilas itse ei siihen kykene.

➔ Tutustu seuraaviin lähteisiin, jotka tutkivat hoitotyön historiaa:

Sajaniemi, P. 2017. Sairaanhoidajattarena Suomessa vuosina 1933–1940. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos.

University of Pennsylvania School of Nursing:
<http://www.nursing.upenn.edu/history>

UK Centre for the History of Nursing and Midwifery: <http://www.nursing.manchester.ac.uk/ukchnm/>



Kuva 1.1 Potilaan hoitotyön keskeiset käsitteet

1.3 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

Ammatillinen kasvu

Yhteiskunnassa ja työelämässä korostuvat entistä enemmän **tiedonhallintataidot**, kun tarjolla oleva tietomäärä kasvaa ja tarvitaan asiantuntemusta niin yleisillä kuin yksittäisillä tiedon alueilla. Työntekijöiltä odotetaan itseohjautuvuutta, kehittyneitä ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä ja luovuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Ammatillinen kasvu alkaa itsetuntemuksesta ja kehittyy yksilön omien kykyjen kautta palautetta antavassa vuorovaikutuksessa. Hoitajan ammatillinen kasvu tarkoittaa omien mahdollisuuksien ja rajojen tunnistamista. Kasvu koetaan itseluottamuksen vahvistumisena, ammattitaidon kehittymisenä ja sitoutumisena jatkuvaan kehitykseen. Palautte, arviointi, omaan työhön liittyvän uuden tiedon hankinta ja oma toiminta tukevat ammatillista kasvua, jonka edellytyksenä on halu kehittyä. Työkokemusta, harrastuksia ja kiinnostusta oppimiseen voidaan hyödyntää ammatillisen kasvun perustana. Ammatillisen kasvun tavoitteena on parantaa suoritusta ja osaamista.

Ammatillista kasvua tuetaan opintojen aikana eri tavoin. Käytännön harjoittelussa opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta työtehtävistä. He saavat palautetta hoitajilta ja potilailta, mikä on merkityksellistä niin ammatillisen kuin yksilöllisen kasvun kannalta. Jotta työntekijä voisi kehittää omaa työtään potilaan parhaaksi, hänen on oltava tietoinen omaksumistaan tietorakenteista, työskentelytavoistaan sekä siitä, miksi hän toimii niin kuin toimii. Tieto muuttuu tällöin aktiiviseksi tietämisen prosessiksi ja työntekijä pystyy tarkastelemaan eli reflektoimaan toimintaansa ja osaamisensa tasoa.

Hoitotyössä potilaan hoidon kokonaisuutta opetellaan hahmottamaan **hoitosuunnitelman** avulla. Potilaan hoitosuunnitelma ohjaa työskentelyä missä tahansa tehtävässä, jossa edetään tietyn prosessin mukaan. Uuden oppimisessa ja tie-

don luotettavuuden arvioinnissa oppija tarvitsee vertaistukea ja opettajan ohjausta.

Hoitajaksi kasvamisessa on kysymys itsensä ymmärtämisestä ja näkemisestä uudella tavalla. **Hoitajan identiteetti** on hänen käsityksensä itsestään ammattilaisena eli siitä, mikä hänelle ammatissa toimiessa on tärkeää ja miten hän toimii ammatinsa keskeisissä tehtävissä. Myös sairaanhoitajien ammattikunta määrittää itsensä yhteisönä, kun siihen kuuluvat vastaavat kysymykseen siitä, keitä he ovat ammattikuntana, mikä merkitys heillä on yhteiskunnassa, miten heitä arvostetaan ja mikä on heidän yhteiskunnallinen asemansa.

Reflektio

Reflektoinnilla tarkoitetaan ihmisen tavoitteellista pohdintaa ja puntarointia, jossa hän peilaa oppimaansa aikaisempaan kokemusmaailmaansa. Reflektio ymmärretään yleensä aktiiviseksi tutkimus- ja paljastusprosessiksi, jonka lopputulos voi olla yllättäväkin. Reflektiiviseen ajatteluun liittyvät yleensä epäilevä, hämmästelevä ja päätöksentekoa pitkittävä asenne ja uusia näkökulmia etsivä ja tutkiva mieli.

Ammatillisen kasvun rakennusaineina ovat **kriittinen reflektio** ja **itseohjautuvuuteen** perustuva oppiminen. Oppija tarvitsee koulutuksensa ajan ohjausta, jotta hän voisi kasvaa ammatillisesti ja itsenäisenä oppijana ja ihmisenä. Oppiminen tapahtuu vasta sitten, kun ihminen antaa kokemalleen merkityksen ja tulkitsee kokemustaan. Koetulle ei voida antaa merkitystä ennen kuin kokemusta on tarkasteltu ja reflektoitu. Reflektointi tarkoittaa sen päättämistä, mitä kokemuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa, mitä sille tulee tehdä ja miten siihen tulee reagoida. Reflektio auttaa ymmärtämään asioiden syitä ja seurauksia, mikä luo uuden ammatillisen identiteetin vaiheen ja auttaa kasvamaan ammatissa. Reflektio on oppimisen yhteydessä älyllistä, asenteita ja tunnetilaa koskevaa toimintaa, jossa yksilö tutkii tietojaan ja kokemuksiaan uuden ymmärtämisen tason saavuttamiseksi. Kokemusten läpikäynti ja arviointi voivat auttaa löytämään ja luomaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Kokemuksia voi

reflektoida esimerkiksi palauttamalla niitä mieleen ja kuvailemalla niitä uudelleen sekä käymällä läpi kokemuksiin liittyneitä ja oppimiseen vaikuttavia kielteisiä ja myönteisiä tunteita ja arvioimalla niitä uudelleen. Vuorovaikutuksen avulla oppijan ajatteluprosessit ja uskomukset tulevat näkyviin, jolloin niiden perusteluja on mahdollista arvioida ja kyseenalaistaa ja niistä voi saada palautetta. Reflektiota edistäviä keinoja opetuksessa ovat esimerkiksi opiskelijan itsearviointit, ryhmäpohdinnat ja palautekeskustelut.

Reflektion avulla voidaan oikaista ihmisen uskomuksiin sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisutilanteissa tehtyjä virheitä. Kriittinen reflektio on niiden ennako-oletusten arvostelua, joille ihmisen omat uskomukset rakentuvat. Se on ennako-oletusten pätevyyden kyseenalaistamista.

Kognitiivisesta näkökulmasta reflektio toimintana on myös omien uskomusten, perusteiden ja oikeutuksien arviointia ja niiden olettamusten rationaalista tutkimista, joilla ihminen perustelee uskomuksiaan. Oppimisen edellytyksenä on, että oppija itse ymmärtää, mitä hän kulloinkin ymmärtää tai osaa (tai ei ymmärrä tai ei osaa) opittavasta asiasta. Tämä ymmärrys myös edistää merkityksellisen tiedon hakua ja merkityksellisten kysymysten asettamista. Jos oppija ei ymmärrä, miksi

tietty asia pitää muistaa tai osata, opitulla ei välttämättä ole kovin merkittävää siirtovaikutusta eli opittua ei käytetä hyväksi uusissa tilanteissa. Esimerkiksi koetilanteessa hyvin muistettua tietoa ei välttämättä aina käytetä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa.

Reflektiomenetelmiä

Refleктоiva kirjoittaminen on omien uskomusten ja kokemusten referointia. Lähtökohtana on koettujen kokemusten ja tapahtumien ja niiden aikaansaamien seuraamusten analysointi. Reflektivassa kirjoittamisessa on selkeät kriteerit, jotka ohjaavat kirjoittamista. Tärkein kriteereistä on kriittisen ajattelun herääminen ja esille tuominen. Ajatuksia ja kokemuksia tulee tarkastella ja peilata aikaisemmin opittuun teoriaan ja malleihin. Näytöön perustuvan tiedon yhdistäminen käytännön tilanteisiin kehittää reflektointitaitoa.

Hoitotyön koulutuksessa reflektiosta puhutaan lähinnä **käytännön harjoittelun** yhteydessä. Käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen opiskelijat voivat pohtia kokemaansa ja oppimaansa sekä punnita, peilata ja jakaa harjoittelussa esiin tulleita oppimiskokemuksia toisten opiskelijoiden ja opet-



Esimerkki reflektoinnista

Opiskelija on ollut mukana hoitotilanteessa, jossa hänen ratkottavakseen on tullut jokin vaikea tilanne. Jälkeenpäin hän on pohtinut tilannetta, joka on jäänyt hänelle erityisesti mieleen. Opiskelija palauttaa mieleensä kyseisen tilanteen ja miettii, minkälaisia tuntemuksia hänessä heräsi ja mikä tilanteessa oli hyvää ja mikä huonoa. Hän miettii, miten hän toimii, jos samankaltainen tilanne tulee eteen tulevaisuudessa, ja olisiko ollut jotain muuta tapaa ratkaista tilanne.



Kirjoittaminen on refleктоivaa, kun kirjoittaja

- ymmärtää keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä
- pystyy kirjoittamaan kokemistaan asioista ja kuvaamaan käytännön toimintaa
- on saavuttanut kognitiiviset kyvyt, kuten kyvyn kriittiseen ajatteluun
- pystyy kirjoittamaan keskusteluista hoitotilanteissa ja arvioimaan omia tuntemuksiaan
- osaa yhdistää silloiseen toimintaansa aikaisemmin oppimansa.

tajan kanssa. Reflektiossa tulevat esille harjoittelun sisältö ja prosessi sekä vuorovaikutus- ja kliinisten taitojen onnistuminen. Reflektion tarkoituksena on ohjata erittelemään kokemaansa, arvioimaan, mistä mahdolliset väärät ennakkoluulot olivat muodostuneet, ja suuntaamaan avoimin mielin uusiin harjoitteluympäristöihin.

Harjoittelukokemukseen vaikuttaa hyvin merkittävästi opiskelijan ohjaajaksi nimetty hoitaja. Alkuvaiheen opiskelijat toimivat mielellään saamansa mallin mukaisesti, mutta kun osaamista on enemmän, lisääntyy halu toimia itsenäisesti ja vastuullisesti. Hoitajat tarvitsevat pedagogisia taitoja työssään ja myös opiskelijoiden ohjauksessa. Harjoittelua ohjaava opettaja on avainasemassa tuke-
massa opiskelijaa ja neuvottelemassa, miten oppimista voidaan tukea parhaiten.

Reflektiomalli hoitotilanteiden puntarointiin

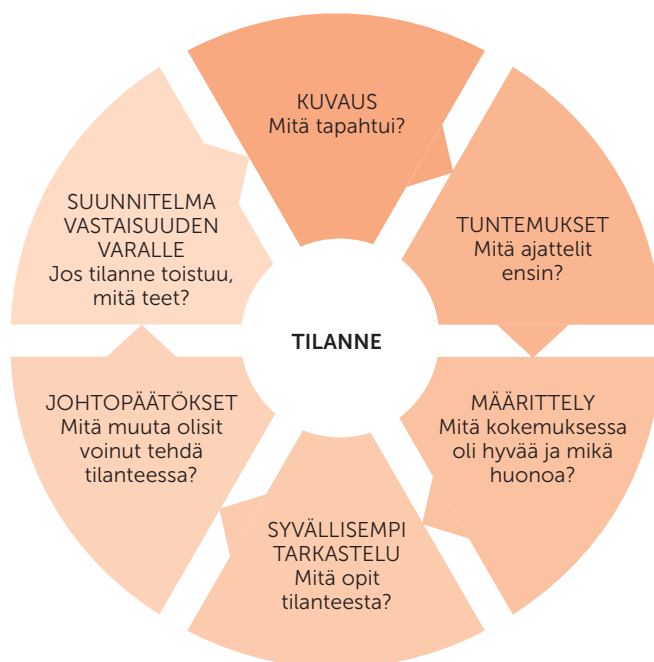
Kriittinen reflektio aktivoi oppijaa ennen muuta kyseenalaistamaan aikaisemmin oppimiaan asioita ja ennako-oletuksiaan, muuttamaan näkökulmiaan ja luomaan uusia merkityksiä. Se kuitenkin edellyttää pysähtymistä, jolloin uudelleenarviointiin on sekä fyysinen että psyykinen mahdolli-

suus. Ammatillisen kasvun kannalta tämä on ehdottoman välttämätöntä.

Ammatillinen kasvu on siis jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä, sitoutumista työhön sekä ammatillisen identiteetin ja työpersoonan reflektiivistä uudelleen määrittelyä. Se on sekä yksilön ajattelun, suorituksen, reflektion ja persoonallisuuden kehittymistä että työnhallintataitojen laajenemista ja syvenemistä. Yksilön kasvua ohjaavat eettiset valinnat, henkinen kasvu, tunteet, toiminta ja reflektio. **Opettajaa** tarvitaan suuntaamaan ja ohjaamaan oppimista osoittamalla sille tavoitteet ja arvioimalla niiden toteutumista, sillä kukaan ei ole luonnostaan itseohjautuva.

➔ Ora-Hyytiäinen, E. 2004. Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Opiskelijan tietoisuus tekemistään havainnoista, niiden tulkinnoista ja niistä syntyneistä merkityksistä on tärkeää. Opiskelijan tulee kyetä yhdistämään teoreettinen oppiaines käytännön työhön siten, että hän voi perustella tavoitteellista toimintaansa. Kokemus taas muuttuu oppimiseksi tietoisien ja kriittisen reflektion avulla. Opettajan ohjaus kohdistuu opiskelijan käytännön harjoittelussa vahvasti tietoisuuden lisäämiseen ja teoreettisen oppiaineen yhdistämiseen käytännön hoitotyöhön.



Kuva 1.2 Tavoitteellisen pohdinnan kehä

1.4. Hoitotyön opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ammatillista kehittymistä voidaan tarkastella seuraavien osa-alueiden pohjalta: teoreettinen ja käytännön osaaminen, ohjaus-, opetus- ja vuorovaikutusosaaminen, kriittinen ja reflektiivinen osaaminen, ryhmätyö- ja johtamisosaaminen sekä eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Suomalaisen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä on viimeisen viidentoista vuoden aikana kehitetty. Toisen asteen koulutusalojen yhdistäminen, ammattilukioiden perustaminen, ammattikorkeakoulujen tuleminen entisten opistojen tilalle ja yliopistojen ammatillis-painotteisten alojen vahvistuminen ovat esimerkkejä kehityksen suunnasta. Kuvassa 1.3 hahmotellaan nykyistä koulutusjärjestelmää.

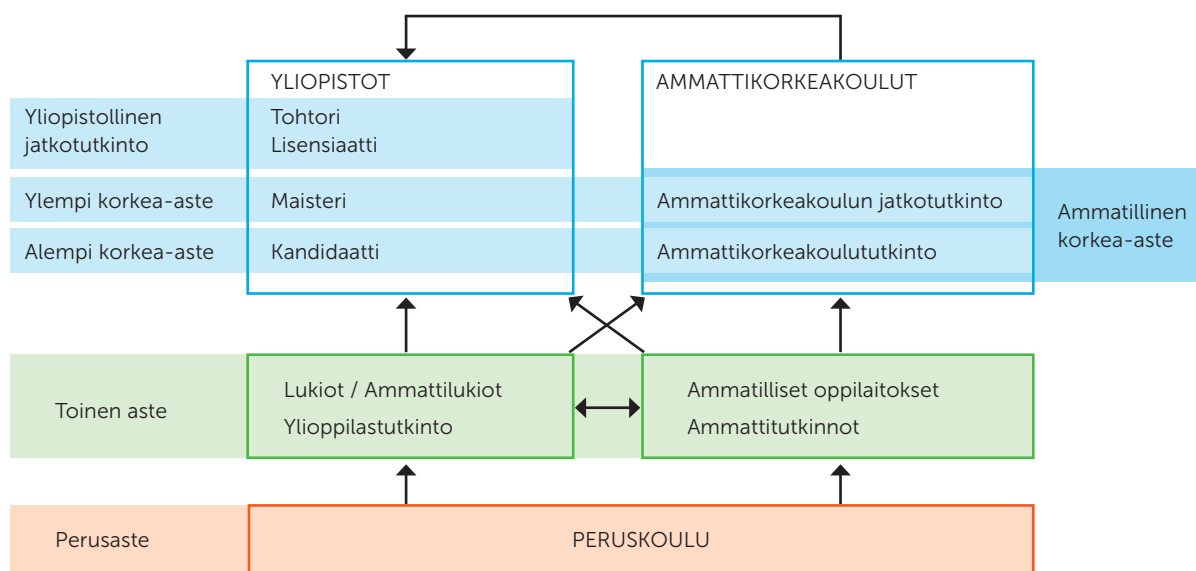
Duaalimalli merkitsee sitä, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat rinnakkaisia, vaihtoehtoisia ja sisällöltään eriytyneitä koulutusväyliä.

Ammattikorkeakouluissa järjestetään

- ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
- ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
- ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta
- avointa ammattikorkeakouluopetusta
- ammatillista opettajankoulutusta.

Kyseessä on kahden koulutusväylän toisiaan täydentävä, omaa koulutusvastuuta toteuttava ja toisiinsa nähden ei-hierarkkinen rakenne.

Ammattikorkeakoulussa suoritettu **perustutkinto** johtaa korkeakoulututkintoon ja käytännön ammattitaitoon. Ammattikorkeakoulututkinnon



Kuva 1.3 Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän rakenne eli niin sanottu duaalimalli



Opintojen tavoitteena ovat

- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
- syvällinen kuva alasta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja asemasta työelämässä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
- työelämässä vaadittavat hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.



Sairaanhoitajan ammatillisen asiantuntemuksen osaamisalueet:

- ammattieettinen toiminta ja vastuu potilaan oikeuksien toteutumisesta
- terveyden edistäminen
- hoitotyön päätöksenteko
- ohjaus ja opetus
- yhteistyö
- tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen
- monikulttuurinen hoitotyö
- yhteiskunnallinen toiminta
- kliininen hoitotyö
- lääkehoito.

laajuus on perustutkinnoissa 210–270 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 3–4 vuoden opintoja. Sairaanhoitajan asiantuntemus perustuu sosiaali- ja terveysalan yhteisiin lähtökohtiin, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, hoitotieteelliseen ja monitieteelliseen tietoperustaan sekä käytännölliseen osaamiseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60–90 pistettä, ja sen suorittaminen kestää kokopäiväisesti opiskelemalla vuodesta puoleentoista vuoteen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on koulutuksen kautta tai muuten hankitun osaamisen lisääminen, syventäminen, kehittäminen ja pitäminen ajan tasalla. Täydennyskoulutus on lyhyt- tai pitkäkestoista. Pitkäkestoiset koulutukset toteutetaan ammatillisina erikoistumisopintoina, joiden laajuus on 30–60 opintopistettä. Ammattikorkeakoulujen tarjoama muu täydennyskoulutus korvanee erikoistumisopinnot tulevaisuudessa rahoitusmallin muuttumisen vuoksi. Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on korkea-asteella uusi työelämälähtöinen ja joustava koulutusmuoto, jossa painopiste on työpaikalla oppimisessa. Se edellyttää työyhteisön ja työnantajan vahvaa sitoutumista koulutukseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät **avoimta ammattikorkeakouluopetusta**, ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Pääosa opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista toteutetaan erillisinä, jolloin opiskelijaryhmä koos-

tuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hoitotyön ammattitutkinnon omaaville on luotu erityispätevyyksiä, jotka ovat työelämän kannalta tarpeellisia laajoja osaamiskokonaisuuksia. Näissä laajennetaan, syvennetään ja kohdistetaan ammatillista osaamista.

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Ammatillisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksena on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan. Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu muun muassa kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattpedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Hoitohenkilökunnan täydennyskoulutus

Hoitohenkilökunnan **ammattitaidon** ja osaamisen kehittäminen on tärkeää, koska hyvä ammattitaito on edellytys laadukkaalle työssä suoriutumiselle. Terveystenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus itse huolehtia ammattitaitonsa riittävydestä. Terveystenhuollon täydennyskoulutus eroaa muusta ammatillisesta täydennyskoulutuksesta siihen liittyvän lainsäädännön takia. Terveystenhuollon täydennyskoulutusta ohjaavat laki ja asetus terveystenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994), työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja erikoissairaanhoidolaki (1062/1989).

Lain mukaan terveystenhuollon ammattihenkilöllä on eettinen velvollisuus käyttää koulutuksensa oppimiaan toimintatapoja. Hän on velvollinen pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin, työskentelipä hän millä toimialalla tai sektorilla hyvänsä. Laki koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia, joiden tulee siis luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä ja pitää yllä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea terveystenhuollon toimintayksiköiden toimintaa ja sen kehittämistä terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Täydennyskoulutuksen määrä riippuu työntekijän peruskoulutuksesta ja työn vaativuudesta, toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista. Vähimmäismääriä koulutukselle ei ole säädetty, mutta lähtökohtana pidetään keskimäärin 3–10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa. Myös työterveyshuollon ammattihenkilöstöllä ja asiantuntijoilla tulee olla riittävällä täydennyskoulutuksella ylläpidetyt tiedot ja taidot.

Terveyskeskus ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voivat järjestää täydennyskoulutuksen omalla toimintanaan tai hankkia sen toiselta terveyskeskukselta, sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä tai muulta täydennyskoulutuksen järjestäjältä. Koulutusta on järjestettävä kaikille terveystenhuollon toimintayksiköissä työskenteleville. Terveystenhuollon toimintayksiköiden tulee seurata täydennyskoulutuksen toteutumista, siihen osallistumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Sairaanhoitopiirin tulee huolehtia vastualueeseen kuuluvien kuntayhtymien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, sairaanhoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksessa ja sairaanhoitoon kuuluvan tutkimus- ja kehittämis-toiminnan järjestämisessä.

Lainsäädännön mukaan työnantajan tulee siis huolehtia siitä, että terveystenhuoltohenkilöstö osallistuu heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen henkilön peruskoulutuksen pituuden, työn vaativuuden ja toimenkuvan mukaan. Sen, onko henkilö vakituisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa, ei pidä vaikuttaa täydennyskoulutukseen pääsemiseen.

Hoitotieteen opiskelu yliopistossa

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua opiskelemaan yliopistoon. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi **terveys-**

den kandidaatin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä), ja **maisterin** tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto (vähintään 120 opintopistettä). Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa opetus-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Koulutuksen tehtävänä on tuottaa hoitotieteellisesti perusteltua osaamista yksilön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen ja hoitamiseen. Terveystieteiden kandidaateilla ja maistereilla on valmiudet tieteellisesti perusteltuun, luovaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaan toimintaan terveysalan eri tehtävissä. Maisterin tutkintoon kuuluva opettajankoulutus antaa lisäksi muodollisen pätevyyden toimia opettajana sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa opilaitoksissa. Terveystieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden hakeutua **terveys-tieteiden lisensiaatin ja tohtorin** jatkotutkintoihin johtavaan koulutukseen. Tieteellisen jatkokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.



Haavisto, E. 2017. Terveystieteiden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen akateemisena kumppanuutena. *Tutkiva hoitotyö* 15 (2), 41–42.

2

Hoitotyön arvot, periaatteet ja lainsäädäntö

Tässä luvussa

- Arvot
- Lainsäädäntöä
- Ihmiskäsitykset
- Hoitotyön periaatteet
- Sairaanhoitajan eettiset ohjeet
- Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet



Hoitotyön ammattietiikka ja eettiset ammattisäännöt ovat periaatteita, joihin hoitotyön ammattilaiset yksilöinä ja yhteisöinä sitoutuvat. **Ammattietiikka** määrittelee yleisesti, millainen toiminta on ammatinharjoittamisessa eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa. Monilla muillakin ammattiryhmillä on omat eettiset ohjeensa, ja ammattijärjestöt määrittelevät oman ammattikuntansa eettiset sitoumukset. Ammatillisella tasolla eettisyys merkitsee kykyä pohtia ja jatkuvasti kyseenalaistaa omaa ammatillista toimintaa, päätöksentekoa ja sen perusteita. Hoitotyön etiikka käsittelee kysymyksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ihmisten yhdenvertaisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista, oikeudenmukaisuudesta ja hyväksyttävästä käyttäytymisestä.

Keskeisimpiin hoitajan toimintaa ohjaaviin periaatteisiin kuuluu **hoidon inhimillisuus**. Hyvä tahto, ihmisystävällisyys, humanisuus, lempeys ja empatia ovat inhimillisyyden läheisiä käsitteitä. Nämä ominaisuudet kuvastuvat ihmisten välisissä kohtaamisissa. Potilaiden ja heidän omaistensa tulee kokea terveysalan ammattilaiset ystävällisinä, heidän arvomaailmaansa kunnioittavina ja kuuntelevina kanssakulkijoina.

→ Tutustu teokseen *Etiikka hoitotyössä* (Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2015. Sanoma Pro Oy, Helsinki).

Hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet:

- ihmisarvon kunnioittamisen periaate
- hyvän tekemisen ja pahan välttämisen periaate
- oikeudenmukaisuuden periaate
- perusteltavuuden periaate.

Lähteet: ETENE 2000, 2008, Beauchamp & Childress 2001, Thompson ym. 2006

2.1 Sairaanhoidajan eettiset ohjeet

Suomen sairaanhoitajaliitto on julkaissut sairaanhoitajille seuraavat eettiset ohjeet:

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kättilöiden ja ensihoitajien (AMK) eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet.

I Sairaanhoidajan tehtävä

Sairaanhoidajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoidaja auttaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoidaja palvelee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voimavarojaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua.

II Sairaanhoidaja ja potilas

Sairaanhoidaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoidaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat. Sairaanhoidaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoidaja pitää salassa potilaan antamat luottamukselliset tiedot ja harkitsee, milloin keskustele niistä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Sairaanhoidaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän tilanteeseen. Sairaanhoidajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Sairaanhoidaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin

yksilöllisen hoitotarpeen mukaan riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.

III Sairaanhoidajan työ ja ammattitaito

Tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti. Hän arvioi omaa ja muiden pätevyyttä ottaessaan itselleen tehtäviä ja jakaessaan niitä muille. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Samassa hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä siitä, että hoitotyön laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti.

IV Sairaanhoidaja ja työtoverit

Sairaanhoidajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittämisessä. Sairaanhoidajat kunnioittavat oman ammattiryhmänsä ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He pyrkivät hyvään yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Sairaanhoidajat valvovat, etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti.

➔ Perehdy myös sairaanhoidajan kollegiaalisuusohjeisiin Sairaanhoidajaliiton sivuilla www.sairaanhoidajaliitto.fi.

V Sairaanhoidaja ja yhteiskunta

Sairaanhoidajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sairaanhoidaja toimii yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten kanssa ja vahvistaa heidän osallistumistaan potilaan hoitoon. Hän antaa terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoidaja

tekee yhteistyötä vapaaehtois-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Sairaanhoidajien kansainvälinen työ on ammatillisen tiedon ja taidon vastavuoroista välittämistä sekä osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Sairaanhoidajat kantavat vastuuta ihmiskunnan terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti sekä edistävät samanarvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta.

VI Sairaanhoidaja ja ammattikunta

Sairaanhoidajakunta huolehtii siitä, että ammattikunnan jäsenet hoitavat arvokkaasti yhteiskunnallisen tehtävänsä. Ammattikunta tukee jäsentensä moraalista ja eettistä kehitystä sekä valvoo, että sairaanhoidajalla säilyy ihmisläheinen auttamistehtävä. Sairaanhoidajat vastaavat ammattikuntana jäsentensä hyvinvoinnista. Heidän ammattijärjestönsä toimii aktiivisesti oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten työolojen varmistamiseksi jäsenistölle. Sairaanhoidajakunta vastaa oman alansa asiantuntijuudesta. Sairaanhoidajat huolehtivat ammatin sisällön syventämisestä, koulutuksen kehittämisestä sekä tieteellisyyden edistämisestä. Sairaanhoidajakunnan asiantuntijuuden kasvun tulisi näkyä väestön hyvän olon edistymisenä.

➔ Suomen Sairaanhoidajaliitto:
www.sairaanhoidajaliitto.fi
Eettiset ohjeet englanniksi:
Ethical Guidelines of Nursing www.icn.ch

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan ja tuntea ammattitoimintaansa koskevat lait ja määräykset sekä eettiset ohjeet. Seuraavassa laatikossa on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavaa lainsäädäntöä.

➔ Ajantasaista terveydenhuoltoa ja ammattihenkilöstöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja julkaisuja löydät muun muassa seuraavilta sivustoilta:
www.finlex.fi, www.stm.fi, www.valvira.fi,
www.avi.fi, www.etene.fi



Perus- ja ihmisoikeudet (2002/639)
Ihmisoikeuksien julistus: www.ohchr.org
Suomen perustuslaki (1999/731)
Kansanterveyslaki (1972/66)
Erikoissairaanhoitolaki (1989/1062)
Terveystieteiden laki (1326/2010)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)
Itsemääräämisoikeuslaki (hallituksen esitys (HE) laiksi/2014)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980)
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/55)

2.2 Hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset

Varsinaisia vahvoja arvoja – **totuus, kauneus ja hyvyys** – kutsutaan platonisiksi arvoiksi, koska jo Platon oivalsi ihmisen tarkastelevan todellisuutta niiden kautta. Terveystieteiden huollossa nämä arvot ovat keskeisiä. Totuutta pidetään käyttöarvoltaan vahvana, koska se puhuttelee ihmistä ja on inhimillisesti syvästi merkityksellistä. Terveystieteiden huollossa totuus voidaan yhdistää tieteelliseen tietoon ja totuudellisuuteen potilas-hoitajasuhteessa. Kauneutta on vanhastaan pidetty taiteellisenä arvona, mutta nykyään myös terveydenhuollossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi hoitoympäristön kauneuteen. Hyvyyden arvolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tuotetaan jotain hyvää ihmiselle ja

ympäristölle. Terveystieteiden huollossa hyvä on ihmisen kärsimyksen minimointia.

Eettiset arvot ohjaavat hoitopäätöksiä ja valintoja, joita hoitaja tekee yhdessä potilaan kanssa potilaan parhaaksi. Esteettiset arvot kuvastuvat esimerkiksi siinä, miten aidosti ja lämpimästi hoitaja kohtaa potilaan. Tiedolliset arvot näkyvät hoitajan toiminnassa siten, että hän toimii vastuullisesti, rehellisesti ja huolellisesti ja kehittää itseään ihmisenä ja hoitajana jatkuvasti. Taloudelliset arvot puolestaan ohjaavat hoitajaa valitsemaan taroituksenmukaiset hoitomenetelmät ja hoitovälineet. Uskonnollisia arvoja ovat lähimmäisen rakkaus, toivo, pyhyys, laupeus ja usko Jumalaan tai korkeimpaan voimaan. Jokaisella potilaalla on oikeus omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin, ja hoitotyössä tulee kunnioittaa ja puolustaa niitä.

Ihmisarvo

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä. Ihmisarvo on **ihmisoikeuksien perusta**, ja sen tarkoituksena on taata jokaiselle ihmiselle arvokas elämä. Jokainen ihminen ansaitsee henkilökohtaisen kunnioituksen ja arvostuksen sekä ystävällisen ja inhimillisen kohtelun riippumatta siitä, minkälaisia mielipiteitä tai arvoja hänellä on. Ihmistä ei saa kohdella esineenä, eikä toista ihmistä saa käyttää hyväkseen, sillä ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä tulee kunnioittaa ja suojella.

Hoitaminen perustuu ihmisarvon kunnioittamiselle, ja se on muistettava kaikissa olosuhteissa. Potilasta tulee suojella, kunnioittaa ja kohdella yksilönä, käytettiinpö hoidossa minkälaista hoitotekniikkaa tahansa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee ennen kaikkea potilaan henkilökohtaisen mielipiteen ja tahdon toteuttamista ja kunnioittamista. Tässä korostuvat potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilöstön vuorovaikutus ja kohtaantuminen. Kohtaantumisella tarkoitetaan muun muassa herkkyyttä tunnistaa toisen ihmisen tarpeita ja kykyä ymmärtää syvällisesti hänen tilannettaan.

Ihmiskäsitys

Ihmiskäsitys eli **ihmiskuva** on yksilön tai yhteisön näkemys siitä, millainen ihminen on ja mikä on ihmisen olemus ja asema suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Eri tieteenaloilla on erilaisia ihmiskäsityksiä. Ihmiskäsitys ohjaa tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa. Siihen sisältyy tulkinta ihmisen arvosta, elämän tarkoituksesta ja hyvän ja pahan olemuksesta. Suomalaista hoitotyötä ohjaavat humanistinen, holistinen ja kristillinen ihmiskäsitys.

Humanistisessa ihmiskäsityksessä korostetaan ihmisyyttä, yksilön ainutlaatuisuutta, yksilön elämän merkityksellisyyttä ja laatua sekä yksilön valinnanvapautta. Humanistinen ihmiskäsitys näkyy terveydenhuollossa siten, että yksilöllä on oikeus päättää itseensä kohdistuvasta hoidosta ja näin ollen saada tietoa hoitovaihtoehdoista. Humanismin mukaan yksilön tulee myös ottaa itse vastuuta omasta hoidostaan ja terveydestään. Hoitosuhteen lähtökohtana on, että ihminen on tajunnallinen olento ja ainutkertainen yksilö.

Holistinen ihmiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Näitä ei ole mahdollista erottaa toisistaan, mutta ihmisiä voidaan tarkastella niiden avulla eri näkökulmista. Ihmisen psyykkiseen ulottuvuuteen kuuluvat kognitiiviset rakenteet ja persoonallisuus. Niihin sisältyvät ajattelu, taito käsitellä tietoa, muisti, tahto ja tunne. Ihminen elää suhteessa luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, jolloin hän elää sekä yksilönä että erilaisten ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Ihminen kasvaa ja kehittyy sosiaalisesti yhdessä toisten ihmisten kanssa ja omaksuu yhteisönsä käyttäytymissäännöt ja tavat. Perhe, ympäristö ja vuorovaikutus toisiin ihmisiin ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta.

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on jakamaton kokonaisuus, ja siinä pidetään tärkeänä lähimmäisen hengellistä ja henkistä auttamista. Kristillisessä ihmiskäsityksessä korostuvat Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus. Kun sairaanhoitaja arvostaa ihmistä, aset-

tuu tämän kuuntelijaksi ja ottaa vastaan tämän hädän, hän osoittaa, että jokainen ihminen on hänelle tärkeä. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen elämä ei ole yhdentekevää, vaan Jumala on läsnä ja hänen hyvyytensä ulottuu kaikkialle.

Hoitotyössä ihmiskäsityksellä on keskeinen merkitys. Se ohjaa terveydenhuollon henkilöstön asennoitumista ja suhtautumista potilaaseen ja antaa perustan hoitotyön eettiselle päätöksenteolle. Hoitotyössä korostuva holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys pitää potilasta ainutkertaisena, tuntevana, kokevana, omia valintoja tekevänä, aktiivisena ja vastuullisena ihmisenä. Hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta eettistä ajattelua ja moraalista käytöstä.

 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta:
www.etene.fi

2.3 Hoitotyön periaatteet

Hoitotyön periaatteet perustuvat hoidon perusarvoihin ja hoitotyössä omaksuttuun ihmiskäsitykseen. Hoitotyön periaatteiden toteuttamiseen vaikuttavat myös hoitokulttuurin arvot, ja ne ovat konkreettisia toimintaohjeita, kuten esimerkiksi potilasturvallisuusohjeet. Hoitotyön periaatteet auttavat hoitajaa toimimaan oikein erilaisissa hoitotilanteissa ja löytämään keinoja hoitotyön käytännön ongelmien ratkaisuun. Hoitotyön arvot ja periaatteet toimivat hoitotyön laadun perusteina. Työyhteisöt laativat kirjallisesti omia toiminta-ajatuksia ohjaamaan oman hoitoyksikönsä toimintaa.

 Eloranta, S. & Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2014. Toteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. *Hoitotiede* 26 (1), 65–73.
Numminen, O. 2010. *Nursing Ethics Education in Finland from the Perspective of Codes of Ethics*. Väitöskirja. Turun yliopisto.



Potilaslähtöisen hoitotyön keskeisiä periaatteita:

- kunnioittaminen
- yksilöllisyys
- itsemääräämisoikeus
- yksityisyys
- perhekeskeisyys
- turvallisuus
- kokonaihoidon periaate
- terveyskeskeisyys
- omatoimisuus
- hoidon jatkuvuus.

Kunnioittamisen periaate

Ihmisarvon kunnioittaminen on yksi hoitotyön perusarvoista. Potilaan kunnioittaminen merkitsee potilaan omien arvojen, persoonan, vakaumuksen, valinnanvapauden, oikeuksien ja elämäkokemuksen kunnioittamista. Potilaan ihmisarvoa kunnioitetaan hänen iästään, uskonnostaan, etnisestä taustastaan, lähtökohdistaan, yhteiskunnallisesta asemastaan, terveydentilastaan tai tavoistaan riippumatta. Potilaan kunnioittamiseen kuuluvat inhimillinen kohtelu, yksityisyydensuoja, luottamuksellisuus, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys. Ihmisarvon kunnioittamiseen taas kuuluvat tiedonsaanti ja yksilön vaikuttamismahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Kaikilla ihmisillä on sama arvo ja samat oikeudet, eikä yksikään ihminen ole merkittävämpi suhteessa muihin. Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy myös potilaan omaisten ja läheisten kohtaamisessa.

Yksilöllisyyden periaate

Yksilöllisyyden periaatteen mukaan jokainen potilas on ainutkertainen ja arvokas ihminen, joka tarvitsee tarpeitaan vastaavaa hoitoa. On tärkeää, että hoidon tavoitteet vastaavat potilaan käsityksiä hoidosta ja että hän osallistuu aktiivisesti omaan hoi-

toonsa. **Omahoitajan** nimeäminen potilaalle edistää yksilöllisen hoidon toteutumista, sillä potilaan henkilökohtaiset erityistarpeet ja toiveet huomioidaan tällöin hoidon eri vaiheissa entistä syvällisemmin. Yksilöllisyyden huomioon ottaminen hoitotyössä tukee potilaan identiteettiä. Hoitotieteellisten tutkimusten mukaan hoitajat nimeävät tärkeäksi yksilöllistä hoitoa edistäväksi tekijäksi potilaan kuuntelemisen ja hänen kanssaan keskustelemisen. Hoitajan tulee olla keskusteluissa aloitteellinen ja kannustava. Vuorovaikutuksen laatuun ja sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Hoitajien sitoutuminen eettisiin arvoihin, kuten potilaan kunnioittamiseen ja eettisesti oikeisiin toimintatapoihin, edistää potilaan yksilöllistä hoitoa.

Itsemääräämisoikeuden periaate

Itsemääräämisoikeudella eli autonomialla tarkoitetaan potilaan oikeutta osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja päätöksentekoon oman elämäkatsomuksensa sekä ajatus- ja arvomaailmansa mukaisesti. Potilaan tulee saada tietoa ymmärrettävällä tavalla muun muassa sairaudesta, hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitoon liittyvistä mahdollisista riskitekijöistä ja komplikaatioista. Potilaan on saatava myös selvitys siitä, mitä seurauksia hänelle voi aiheutua, jos hoitoa ei anneta.

Potilaan omaa tahtoa ja toiveita on kunnioitettava. Potilaalla on oikeus tehdä omaa hoitoaan koskevia päätöksiä aina, kun se on mahdollista, vaikka ne olisivat ristiriidassa hoitohenkilökunnan näkemysten kanssa. Potilas saa siis tehdä omalta kantaltaan huonojakin päätöksiä. Täysivaltaisena hän saa esimerkiksi kieltäytyä elintärkeästä hoidosta tai jättää sen kesken. Tällaisessa tilanteessa potilasta ei saa hylätä vaan on tärkeä säilyttää kontakti häneen ja varmistaa, että hän on todella ymmärtänyt tekojensa seuraukset. Tällöin olisi hyvä pyrkiä löytämään yhteisymmärryksessä sellainen hoito, jonka potilas hyväksyy.

Itsemääräämisoikeutta noudatetaan myös tilanteissa, joissa potilas ei enää itse kykene ilmaisemaan hoitoa koskevaa tahtoaan. Potilaan tahto voi

ilmetä kirjallisesta **hoitotestamentista**, tai hän on voinut ilmaista sen suullisesti. Potilaalla on oikeus hoidon aikana tai hoidon jälkeen tarkistaa potilasasiakirjoihin tallennetut tiedot (ks. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6 §). Toisinaan päätöksiä saatetaan tehdä potilaan puolesta. Tällaisessa tilanteessa hän ei jostain syystä kykene itse ymmärtämään päätöstensä seuraamuksia. Suomen lainsäädännössä säädetään tilanteista, joissa potilaan vapautta tehdä päätöksiä ja toimia voidaan rajoittaa. Niitä käsitellään esimerkiksi mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa ja laissa kehitysvammaisten erityishuollosta.

🔄 Naukkarinen, E.-L. 2008. Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa. Väitöskirja. Kuopion yliopisto.

Kanerva, A.-M. 2006. Puutteita päiväkirurgisen potilaan tietoisien suostumuksen toteutumisessa. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Yksityisyyden periaate

Yksityisyydellä tarkoitetaan jokaisen potilaan henkilökohtaista tilaa, johon vaikuttavat vuorovaikutus ja fyysinen ympäristö. Potilaalla tulisi olla vapaus yksinoloon tai yhdessäoloon muiden kanssa. Potilaan yksityisyys on henkilökohtaista koskemattomuutta, loukkaamattomuutta ja vahingoittamattomuutta. Yksityisyyteen liittyvät **vaitiolovelvollisuus** ja **salassapitovelvollisuus**. Potilasta koskevat asiat pidetään vain häntä hoitavan henkilöstön tiedossa ja luottamukselliset tiedot pidetään salassa. Vaitiolovelvollisuuden ja salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja johtaa rangaistukseen.

Hoitajan tulee varata asianmukainen tila ja riittävästi aikaa, kun hän haluaa keskustella potilaan kanssa luottamuksellisesti. Tarpeen mukaan potilaalle järjestetään ääni- ja näkösuoja ja oma henkilökohtainen alue. Erilaisten näkösuojien käyttäminen tulee olla mahdollisuus esimerkiksi potilashuoneissa, varsinkin jos potilas joutuu paljastamaan itseään, omaa kehoaan tai henkilökohtaisia asioitaan. Jotkut potilaat kokevat yksityisyyttä loukkaavaksi myös sen, että hoitohenkilökunta koskee heidän henkilökohtaisiin tavaroihinsa ilman lupaa.

Perhekeskeisyyden periaate

Perhekeskeisyyden periaate korostaa perheen huomioimista potilaan hoidossa. Jokaisen potilaan kohdalla tulee miettiä, miten merkityksellistä potilaan perheen huomioiminen on. Tavoitteena on lisätä potilaan ja hänen perheensä hyvinvointia ottamalla hänet ja hänen omaisensa ja läheisensä mukaan hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen, jos hän niin haluaa. Hoitajan on tärkeää rohkaista ja tukea potilaan omaisia ja läheisiä, koska yksittäisen perheenjäsenen sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Erityisesti lasten hoitotyössä korostuu omahoitajan merkitys. Perhekeskeisessä hoitotyössä hoitaja kohtaa potilaan avoimesti, inhimillisesti, luontevasti ja rehellisesti ja on saatavilla tarvittaessa. Hän on perheelle sekä lapsipotilaille tuki, keskustelukumppani ja epäselväksi jääneiden asioiden tulkitsija. Hoitotyö on laadukasta, kun se on potilas- ja perhelähtöistä ja potilas ja hänen läheisensä kohdataan hoitotyössä heille sopivalla yksilöllisellä tavalla.

🔄 Tutustu seuraavia aiheita koskeviin Best practice -JBI-suosituksiin:

- omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa
 - sairaaloiden vierailuaikakäytäntöjen vaikutus lapsi- ja aikuispotilaisiin sekä heidän vieraisiinsa.
- www.hotus.fi

Turvallisuuden periaate

Kaikilla potilailla on oikeus kokea hoitonsa sisäisesti ja ulkoisesti turvalliseksi. Tällöin potilas tietää saavansa parhaan mahdollisen hoidon, luottaa hoitoonsa ja hoitohenkilöstöön ja kokee hoitoympäristönsä turvalliseksi. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan turvallista ja luottamuksellista hoitosuhdetta, läsnäoloa, lohduttamista, toivon ylläpitämistä, yhteyttä omaisiin ja läheisiin sekä lapsipotilailla sylissäpitoa. Potilaan sisäistä turvallisuuden tunnetta lisää se, että hän tietää pystyvänsä vaikuttaa omaan hoitoonsa. Ulkoisella turvallisuudella taas tarkoitetaan hoitoympäristön, -toiminnan, -menetelmien ja -välineiden turvallisuutta.



Potilasturvallisuuden sisältävät

- hoitotyöntekijän antaman hoidon turvallisuus
 - a) tekninen osaaminen (hoitomenetelmät, hoitotyö)
 - b) ei-tekninen osaaminen (inhimilliset tekijät, tiimityö)
- lääkeshoidon turvallisuus
- laiteturvallisuus ja fyysinen ympäristö.

On tärkeää järjestää potilaalle turvallinen hoitoympäristö ja minimoida ympäristöön liittyvät vaaratekijät. Hoitohenkilöstön tulee huolehtia hoidon turvallisuudesta, hoitovälineistä ja hoitomenetelmistä. Turvallisuus on myös erilaisten odottamattomien tilanteiden hallintaa sekä infektioiden ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa. Potilasturvallisuuden kuuluvat myös turvallisen ja asianmukaisen hoitopaikan valinta ja hoitoon liittyvät toimenpiteet. Turvallisuutta on käsitelty tarkemmin luvussa 18.

Kokonaishoidon periaate

Kokonaishoidon periaatteella tarkoitetaan potilaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista. Kokonaishoidolla taataan potilaan hoidon kannalta tärkeiden tarpeiden tyydyttäminen ja kiinnitetään huomiota potilaan ilmaiseisiin subjektiivisiin tarpeisiin. Potilaiden kokonaishoitaminen edistää myös sairaanhoitajan työmotivaatiota. Tarvittaessa potilasta hoidetaan moniammatillisessa työryhmässä ja yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, millä taataan potilaalle laaja-alaiset ja laadukkaat palvelut. Moniammatillisessa yhteistyössä hoitoon otetaan tarvittaessa mukaan potilaan lisäksi hänen läheisensä ja perheensä ja huomioidaan potilaan elinympäristö. Potilasta hoidetaan ja autetaan aina tunteen olonsa mahdollisimman hyväksi.

Terveyskeskeisyyden periaate

Kun keskitytään sairauden sijasta terveyteen, mahdollistetaan potilaan täysivaltainen osallistuminen ja voimavarojen käyttö ja otetaan huomioon terveyden moniulotteisuus. Terveyskeskeisyyden periaate merkitsee hoitotyössä yksilön terveyden ylläpitämistä ja kehittämistä, ja se on myös potilaan paranemisen edistämistä ja terveyden palauttamista. Terveyttä edistävässä ja sairauksia ehkäisevässä hoidossa hyödynnetään potilaan omia voimavaroja, jolloin kuntouttava työote toteutuu. Potilaalle opetetaan tietoja ja taitoja, joilla hän voi pitää yllä ja kohentaa terveydentilaansa. Tällöin potilas tulee tietoisemmaksi paranemisensa merkeistä, mikä vaikuttaa myönteisesti hänen mielialaansa ja terveydentilaansa. Potilaan ohjauksen tulee pohjautua tieteellisesti tutkittuun tietoon tai vankkaan kliiniseen kokemukseen. Hoitajalla on velvollisuus pitää yllä ja kehittää ohjaustaitojaan, joihin kuuluvat erilaisten ohjausmenetelmien asianmukainen käyttö ja taito luoda luottamussuhde potilaaseen ja pitää sitä yllä. Terveys koetaan aina yksilöllisesti, ja kokemukset siitä vaihtelevat elämäntilanteittain ja -vaiheittain. Myös eri kulttuureissa ja eri yhteisöissä terveys koetaan erilaiseksi.

➔ Valkama, K. 2012. Asiakkuuden dilemma. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Omatoimisuuden periaate

Omatoimisuuden periaatteella tarkoitetaan potilaan oman tekemisen tukemista puolesta tekemisen sijaan. Hoitajien tulee ohjaamalla, rohkaisemalla ja kannustamalla tukea potilaan omatoimisuutta. Potilasta ohjataan omien voimavarojen käytössä ja hänelle annetaan riittävästi aikaa suoriutua esimerkiksi päivittäisistä toimistaan. Potilaan omien voimavarojen tukeminen, käyttäminen, ylläpitäminen ja mahdollisesti lisääminen esimerkiksi erilaisten apuvälineiden ja kodin muutostöiden avulla ovat osa kuntouttavaa työotetta. Kuntouttava työote vaatii hoitajalta riittävästi aikaa potilaan tukemiseen ja ammattitaitoa huomata tilanteet, joissa potilaan oma suoriutuminen on riittämätöntä.

➔ Brunou, S. 2009. Sairaanhoidajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Hoitaja kokee työssään eettisiä ongelmia, jotka usein liittyvät erilaisiin tilanteisiin, joissa on tehtävä arvoperustaisia valintoja. Eettiset periaatteet voivat olla joskus ristiriidassa keskenään, tai niiden noudattaminen samanaikaisesti saattaa olla vaikeaa. Eettiset ongelmat ovat monitasoisia ja liittyvät usein potilaisiin ja hoitotyöntekijään. Potilaan oikeuksien toteutumisessa voi olla puutteita, ja hoitohenkilökunta ei aina toimi ammattietikan mukaisesti.

Ihmisyysen kuuluu luontainen tarve toimia itsenäisesti, ja itsensä toteuttaminen on kaikille ihmisille tärkeää. Usein sairaus tai vamma heikentää potilaan omatoimisuutta ja lisää riippuvuutta hoitohenkilökunnasta. Hoidon tavoitteena on saada potilas riippumattomaksi ulkopuolisesta avusta ja vastuulliseksi omasta hoidostaan. Potilaan omatoimisuus ja kuntouttava työote eivät kuitenkaan saa olla hoidon itsetarkoitus, koska on tilanteita, joissa potilas kaipaa hoivaa ja huolenpitoa ja asioiden tekemistä hänen puolestaan.

Hoidon jatkuvuuden periaate

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen tarkoittaa potilashoidossa sitä, että potilaan tiedot välittyvät muuttumattomina henkilöltä toiselle, työvuorosta ja yksiköstä toiseen. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa hoidon jatkuvuus turvataan työvuorojen vaihtuessa kirjallisella tai suullisella tiedottamisella. Potilaan hoitoon osallistuvien tulee tietää potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman sisältö, joka on laadittu yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Potilaan hoitoon ja vointiin liittyvät huomiot ja hoitomääräykset kirjataan potilaan yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, millä varmistetaan tiedon jatkuvuus.

Potilaan kotiutuessa hänelle annetaan selkeät suulliset ja kirjalliset jatkohoito-ohjeet ja riittävästi opetusta ja ohjausta kotona selviytymiseen. Potilaan perhettä ja omaisia ohjataan ja tuetaan aina tarpeen mukaan kotiutustilanteessa potilaan lu-

valla. On tärkeää, että kotiutumisen jälkeen potilas voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä häntä hoitaneeseen yksikköön. Potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen jatkohoitoon osallistuvien tulee saada selkeät suulliset ja kirjalliset jatkohoito-ohjeet potilaan hoidosta. Potilaan hoidolle asetettujen tavoitteiden tulee myös välittyä sairaalasta avoterveydenhuoltoon ja toisin päin. Hoitotietojen tulee kulkea hoitoketjussa potilaan mukana, ja tärkeää on myös se, että potilas on itse tietoinen hoidon tavoitteista.

Erityisesti lapsipotilaiden, tajuttomien ja sekavien henkilöiden kohdalla hoitohenkilökunnan vastuu ja velvollisuus hoidon jatkuvuudesta korostuu. Hoidon jatkuvuus turvataan myös käyttämällä hoitajan lähetettä tai hoitotyön yhteenvetoa.

➔ Tutustu seuraavaan Duodecim-lehden artikkeliin: Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Risto Raivio. 2017. Duodecim 133: 1563–1569.

3

Ihmiselämän ja hoitotyön monimuotoisuus

Tässä luvussa

- Elämänkaari
- Seksuaalisuus
- Vuorovaikutus
- Monimuotoisuus
- Monikulttuurinen hoitotyö



3.1 Elämänvaiheisiin liittyvät osatekijät

Elämänkaarella tarkoitetaan ihmisen kehitystä hedelmöityksestä kuolemaan. Kehityksessä on yleisiä piirteitä, mutta kuitenkin jokaisen yksilön kehitys on ainutkertainen. Elämänkaari jaetaan lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Näissä elämänvaiheissa on alavaiheita, joiden rajat ovat liukuvia. **Elämänkululla** puolestaan tarkoitetaan ihmisen sosiaalisia rooleja eri elämänvaiheissa, kuten opiskelija-, työ- ja perhe-elämässä. Elämään liittyy valintoja, joita seuraava lopputulos on yksi monista mahdollisuuksista. Nämä ilmentävät ihmiselämän **monimuotoisuutta** eli sitä, mitä kaikkea ihminen elämässään saattaa kokea ja tuntea. Ihmisen kasvu ja kehitys yksilöksi on moniulotteinen tapahtuma. Hyvä ympäristö ja toimivat sosiaaliset olosuhteet tukevat yksilön kehitystä ja auttavat häntä selviytymään elämässä.

Ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella neljällä ulottuvuudella: **fyysis-biologisella, psykososiaalisella, sosioekologisella ja yksilöllisellä ulottuvuudella**. Fyysis-biologisista tekijöistä biologinen perimä ohjaa fyysistä kasvua ja vaikuttaa psyykkisten ominaisuuksien kehityssuuntaan ja mahdollisuuksiin. Toinen fyysis-biologinen tekijä on ympäristö. Poikkeuksellisen heikot ja virikkeettömät ympäristöt, joissa ihminen kokee ajoittain aliravitsemusta, turvattomuutta ja uhkaa, ovat erittäin huonoja ympäristöjä kehittämään esimerkiksi koulussa tarvittavia oppimisvalmiuksia. Vastaavasti turvalliset ja samalla virikkeelliset, varata vasten kehityksen tukemiseen suunnatut ympäristöt ovat omiaan kehittämään ajattelun taitoja ja sitä myötä myös oppimisen valmiuksia.

Psykososiaalisista tekijöistä merkittävimmät ovat yksilön sisäiset psyykkiset prosessit ja ihmisen vuorovaikutussuhteet toisiin ihmisiin. Lapsi ei kasva eikä häntä voi kasvattaa vain rationaalisesti yksilöksi, vaan hän kasvaa myös inhimilliseksi yksilöksi, joka on yhteydessä toisiin tunteiden kautta. Tunteet toimivat usein kehityksen motivoivana, liikkeellepanevana ja ylläpitävänä voimana. Kasvua voidaan pitää psyykkisenä sisäisenä tapahtumana mutta myös vuorovaikutustapah-

tumana, jossa eri osapuolet vaikuttavat toistensa kehitykseen.

Minäkuvan muuttumiseen liittyy usein vaille naisuuden ja rikkinäisyyden tunteita. Ehjää kuvaa itsestä voi olla vaikea hahmottaa, ja ihminen voi tuntea itsensä rumaksi ja jopa luotaantyöntäväksi. Omaa kehoa kohtaan kohdennetut tunteet voivat olla hyvinkin negatiivisia, ja muutos voi omassa mielessä olla paljon suurempi kuin mitä ulkopuoliset näkevät. Usein ihminen joutuu tekemään surutyötä hyväksyäkseen muuttuneen kehonsa ja käymään läpi siihen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Osa tottuu uuteen minäkuvaansa nopeasti, kun taas joillakuilla se voi viedä paljon aikaa. Minäkuvan muuttuminen voi myös rajoittaa sosiaalista elämää ja harrastuksia. Ulkoiset merkit sairaudesta näkyvät muille, mikä voi tuntua pahalta. Sisäisen minäkuvan muutos voi myös aiheuttaa rikkinäisyyden tunteen, jos muutos kehossa on sellainen, joka ei näy muille. Tällöin ulkopuoliset saattavat vähätellä muutosta, eivätkä he välttämättä ymmärrä sen merkitystä sairastuneelle. Ulkoisen minäkuvan muutos taas tarkoittaa tilannetta, jossa muutos näkyy niin itselle kuin muillekin. Osan näistä muutoksista pystyy peittämään esimerkiksi vaatteilla ja osan ei. Läheisten rooli on tukea, kannustaa ja rohkaista. Olisi tärkeää kyetä puhumaan muutoksista läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Usein tunteiden salliminen, saatu tuki ja muut yksilölliset keinot auttavat eheyttämään minäkuvaa. Vaikeissa ja pitkittyneissä tilanteissa asiantuntija-apu on tarpeen.

Sosioekologiset tekijät ovat vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön välillä. Näitä tekijöitä ovat ihmissuhteet ja yksilön havainnot ja kokemukset. Ihminen tarvitsee toisten ihmisten kohtaamista kokeakseen yhteenkuuluvuutta. Yksilön perustarpeisiin kuuluu lisäksi omien juurien ja elinympäristön historian tunteminen. Ympäristöllä on suuri vaikutus siihen, millainen kuva yksilölle itsestään muodostuu. Ympäristöön liittyviä sosioekologisia tekijöitä ovat esimerkiksi kulttuuri, yhteisöt ja erilaiset sosiaaliset verkostot.

Yksilön kehitykseen liittyy myös yksilöllisiä tekijöitä. Ulkoisten ja sisäisten tekijöiden tuottamat elämänkriisit asettavat ihmisen monien kysymysten eteen. Kysymysten, pohdinnan ja elämäntapa-

Taulukko 22.1 Ihmisen kehitysvaiheet, kehitystehtävät ja kehitykselliset saavutukset E. Eriksonin kehitysteoriassa

Kehitysvaihe	Kehitystehtävä	Kehitykselliset saavutukset
Sikiö	fyysinen kypsyminen, fyysiset tekijät	
Vauvaikä	epäluottamus, turvattomuudentunne → perusturvallisuus	toivo
Varhaislapsuus	häpeä, epävarmuudentunne → itsenäistyminen (kävely,puhe)	tahto
Lapsuus	syllisyydentunne → aloitteellisuus (yliminä)	määrätietoisuus
Kouluikä	alemmuudentunne → ahkeruus	osaavuus
Nuoruus	epäselvyys, roolihaajonta → itsenäistyminen (identiteetti)	uskollisuus
Varhainen aikuisuus	läheisyys – eristäytyminen	urakehitys, harrastukset, ihmissuhteet, rakkaus
Keski-ikä	mielenterveys, tasapaino → luovuus – lamaantuminen	uusi sukupolvi; huolenpito
Vanhuus	minän eheys – epätoivo	viisaus

kemusten myötä ihminen oppii tuntemaan itseään. Oman elämän näkeminen, tiedostaminen ja oman itsensä kohtaaminen ovat haasteellisia prosesseja, jotka mahdollistuvat sekä myönteisissä elämäntapahtumissa että raskaiden elämäntapahtumien myötä. Psykologi ja psykoanalyttikko E. Erikson kehitti niin sanotun psykososiaalisen kehitysteorian, jossa hän kuvasi ihmisen kehityksen tietyiksi toisiaan seuraaviksi kehitysvaiheiksi, elämäntapahtumiksi, ja niihin liittyviksi kehityskriiseiksi, ongelmiksi tai tehtäviksi. **Kehityskriisi on kehitysvaihe**, jossa tietyn tapahtuman ratkaisu tuottaa ihmiselle uuden ja laajemman käsityksen itsestään. Kehityskriisit kuuluvat normaaliin kehitykseen, ja ne olisi ratkaistava tietyn vaiheen aikana. Kehityskriisi on elämäntapahtuman taitekohta, jossa ihmiseltä vaaditaan sopeutumista ja muuntumista. Aiempien kehitysvaiheiden onnistunut käsittely auttaa myöhemmissä kehityskriiseissä, jolloin yksilö voi kokea tyytyväisyyttä ja onnistumista.

Ihminen ei aina kykene ratkaisemaan eteen tulleita haasteita. Synä voivat olla esimerkiksi sairaus tai toimintakyvyn tai ympäristön rajoitukset. Kehityskriisien vaikutukset voivat kasautua ja seurauksena voi olla työttömyyden ja taloudellisten vaikeuksien kierre ja läheisten ihmissuhteiden rikkoutuminen.

Ihminen seksuaalisena olentona

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmistä koko elämän ajan. Hoitotyön haasteena on huomioida seksuaalisuuden ominaispiirteet yksilön sille antamien merkitysten mukaisesti. Seksuaalisuus on myös läsnä ihmisen ikääntyessä, ihmisen sairastuttua ja hänen saatuaan pysyviä vammoja. Elämäntapahtu-



WHO:n seksuaalisuuden määritelmä (2006):

- biologinen sukupuoli
- sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli
- seksuaalinen suuntautuminen
- hellyyden, kosketuksen ja intiimiyden perustarpeet, joita ilmaistaan tuntein, teoin ja ajatuksin
- käyttäytyminen, uskomukset ja asenteet
- lisääntyminen ja parinmuodostus
- seksuaaliset toiminnot.

milla on tosin vaikutusta yksilön seksuaalisuuden ilmenemiseen ja ilmaisemisen mahdollisuuksiin. Seksuaalisuus on merkittävä voimavara.

Kehitysvammaisen ihmisen perustarpeiden tyydyttämisen esteenä saattaa olla hyvin monia asioita, mutta nämä eivät poista sitä tosiasiaa, että vammaisellakin on oikeus seksuaalisuuteen. Kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalisuudessa ja siihen liittyvissä tunteissa voidaan kohdata monia käytännön ongelmia. Esimerkiksi fyysisen hellyyden osoittamisessa rajojen ymmärtäminen saattaa olla vaikeaa. Toisaalta kehitysvammaisten voi olla hankalaa uskoa omaan viehätysvoimaansa, ja huono itsetunto tai itsetunnon lasku ja selkeytymätön sukupuoli-identiteetti saattavat estää heitä nauttimasta seksuaalisesta elämästä. Pahimmillaan tämä voi johtaa kokonaan seksuaalisuuden kieltämiseen ja tunteeseen siitä, että seksuaalisuus ei kuulu minulle itselleni ollenkaan.

➡ "Vamma itsessään on harvoin esteenä sukupuolisuuden toteuttamiselle; niin vaikeaa vammaa ei juuri ole, että se täysin estäisi seksuaalisuudesta nauttimisen."

Ilmonen, Tuisku. 1997. Vammaisuus, pitkäaikais-sairaus ja seksuaalisuus. Teoksessa H. Nikkola & A. Niinistö (toim.) Halu rakastaa. Julkaisusarja C:7:1997. Pro nursing ry, Turku.

Ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin huomioimisen merkitys korostuu väestön ikääntymisen myötä. Tietoa tarvitaan kehon toiminnasta, seksuaalireaktioista ja mielihyvän kokemisesta, itsetyydytyksestä, rentoutumisesta ja fantasioista. Ikääntyvät tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa muuttuvan kehonsa ymmärtämiseen, koska he joutuvat luomaan uuden kuvan seksuaalisesta minuudestaan. Ikääntyvä kokee menetyksiä, mutta hänen on mahdollista saada tilalle uusia asioita ja kokemuksia.

Seksuaalisen kyvyn ja halun väheneminen on yleinen vanhenemiseen liittyvä muutos, mutta samanaikaisesti seksuaalisuus voi kypsyä ja jalostua kokemusten myötä.

Pitkää parisuhdetta saattavat rasittaa seksuaali-elämään kohdistuvat erilaiset odotukset ja tarpeet. Oma tai puolison sairastuminen muuttaa yleensä tilapäisesti seksuaalista aktiivisuutta, mutta joskus

saadut vammat voivat merkitä seksuaalisen aktiivisuuden loppumista. Kumppanin sairaus voi myös johtaa hoivasuhteen muodostumiseen ja seksuaalielämän kuihtumiseen, mutta suhde voi olla myös antoisa, jolloin kosketus, läheisyys, hellyys ja toisen arvostaminen tuottavat edelleen mielihyvää.

Sairastuminen aiheuttaa muutoksia seksuaalisuudessa ja parisuhteessa varsinkin silloin, kun oma keho muuttuu. Puolison suhtautuminen ja puolisoiden välinen vuorovaikutus vaikuttavat siihen, miten sairastunut kokee oman kehollisuutensa ja seksuaalisuutensa. Puolison suhtautumisella on merkitystä sairastuneen henkilön myönteiseen tai kielteiseen kokemukseen itsestään edelleen seksuaalisena olentona.

➡ Seksuaalinen tasa-arvo. www.seta.fi

Kontula, O. 2013. Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2013 (3). Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos

Santalahti, T. 2018. Opettajan opas – Nuorten seksuaalisuus ja seksuaaliterveys. Duodecim, Koulun terveystietokirjasto. Saatavilla osoitteesta www.koulunterveyskirjasto.fi

Seksuaalisuudesta selkokielellä. Sete-ke-projektin (Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti) verkkosivut. www.sete.fi

Hyvönen, T. 2010. Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus. Hoitajien näkemys kehitysvammaisten seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Rovaniemen AMK. Saatavilla osoitteesta www.theseus.fi

➡ Declaration of sexual rights www.worldsexology.org
Sexual and reproductive health www.who.int/reproductivehealth

Seksuaaliterveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä. Seksuaaliterveyden perustana on myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen, seksuaalioikeuksien kunnioittaminen, tiedonsaanti ja seksuaaliterveyspalvelut. Potilaan seksuaalisuuden huomiointi on ammatillista hoitotyötä, jonka edellytyksenä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde potilaan ja hoitajan välillä. Hyvä lähtökohta potilaan

seksuaalisuuden kohtaamisessa on, että hoitaja hyväksyy oman seksuaalisuutensa. Potilaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään huomioimalla hänen tarpeensa ja lähtökohtansa. Seksuaaliterveys on ihmisen kykyä nauttia seksuaalisuudestaan ja toteuttaa sitä ilman sukupuolitautien, ei-toivotun raskauden, painostuksen, väkivallan ja syrjinnän riskiä ja jokaisen seksuaalioikeuksia kunnioittaen.

Seksuaaliterveyteen liittyvän ohjauksen antamisen tulee olla osa hoitajan ammattitaitoa. Kulttuurilla ja uskonnolla on merkitystä siinä, miten seksuaalisuudesta puhutaan ja miten asioita ilmaistaan. Hoitotyön arvot ja normit ovat potilaan seksuaalisuuden huomioimisen perustana. Ihmisen seksuaalisuus on perusarvo, jota suojellaan myös lainsäädännöllä. Hoitajan on tutkittava omaa toimintaansa tiedostaakseen kokemuksensa, asenteensa ja toimintansa rajat voidakseen tukea potilaan seksuaalisuutta. Hoitajan taito kuunnella potilasta ja vastata hänen kysymyksiinsä edistää luottamuksen syntymistä hoitosuhteessa. Hoitajan on tärkeää selvittää sairauden ja hoitotoimenpiteen vaikutukset potilaan seksuaaliseen toimintakykyyn ja tukea hänen identiteettiään.

Tutkimustulosten pohjalta on luotu potilasohjaukseen malli, jossa potilaan kanssa keskustellaan sairauden ja hoitojen mahdollisista vaikutuksista parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Ohjauksella voidaan auttaa potilaita ennakoimaan tulevia muutoksia ja mahdollisesti selviytymään niistä ehkä helpommin. Seksuaalineuvontaa voidaan toteuttaa PLISSIT-mallin avulla.

PLISSIT-mallia voidaan käyttää ohjauksen antamisessa samassa ikäryhmässä oleville, samaa sairautta sairastaville tai samassa tilanteessa oleville.

Neuvontatilanteessa työntekijän tulee kiinnittää huomio myös fyysisiin kysymyksiin, kuten kipuun, elintoimintoihin, hormonaalisiin poikkeavuuksiin sekä sukupuolielinten ja verenkiertoelimistön toimintaan. Seksuaalineuvonnan lähtökohta on ammattilaisen omien asenteiden ja seksuaalisuutta kohtaan tuntemiensa arvojen tunnistaminen. Oman persoonan käyttö työvälineenä mahdollistuu, kun hoitaja tuntee itseään myös sek-



PLISSIT-malli:

- Seksuaalineuvonnan sallimisessa ja siihen luvan antamisessa asiakas hyväksytään ainutkertaisena seksuaalisena olentona, hänen huoliaan kuunnellaan ja häntä tuetaan ilmaisemaan seksuaalisuuttaan positiivisesti ja vastuullisesti.
- Rajatun tiedon antamisessa asiakas saa tietoa erityisistä seksuaalikysymyksistä, kuten ikääntymisen vaikutuksista seksuaalisuuteen, itsetyydytyksestä ja erilaisista tavoista toteuttaa seksuaalisuutta. Edellä lueteltuja neuvoja voi antaa jokainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva.
- Erityisohjeiden antaminen ja intensiivinen terapia edellyttävät työntekijältä perehtyneisyyttä seksuaalisten ongelmien hoitoon.

suaalisena olentona. Hoitajan käyttämät sanat kertovat siitä, millä tavalla hän hahmottaa seksuaalisuutta sen eri ilmenemismuodoissa. Hoitotyössä tulisi löytää itselle luontevin käyttösanasto. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen tapahtuu potilaan esiin nostamien asioiden pohjalta tai tehtäessä selvitystä hänen yleisilastaan. Seksuaalineuvonnan painopisteenä tulee olla ihmisen itsearvostuksen tukeminen.

Hoito henkilökunnan tulisi pohtia, millaista ohjausta potilas missäkin vaiheessa sairauttaan ja hoitoaan saa. Ohjaustilanteessa on tärkeää turvata potilaan itsemääräämisoikeus ja yksityisyys. Ohjauksessa tuleekin korostaa positiivisiksi koettuja asioita seksuaalisuudessa ja keskustelua apuvälineiden ja valmisteiden antamista mahdollisuuksista.

3.2 Vuorovaikutus – hyvän auttamistyön perusta

Vuorovaikutuksen perustaidot opitaan jo varhain lapsuudessa, mutta oppiminen jatkuu läpi elämän. Potilaan tai työtoverin sukupuoli, kieli, kansallisuus, elämänkatsomus ja vakaumus eivät saa vaikuttaa haitallisesti kanssakäymiseen. Potilaan kokemus sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen aktiivisuus vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja ehkäisevät eristäytymisen ja yksinäisyyden kokemuksia. Vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa on aina ainutlaatuinen, eettinen ja kulttuurisidonnainen tapahtuma.

Tilanteissa, joissa eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat tai eri kulttuuria edustavat ihmiset kohtaavat, on kysymyksessä myös kieleen liittyvien sanallisten ja sanattomien viestien kohtaaminen. Hoitotyössä potilasta ohjataan moniin uusiin toimintoihin, jolloin **kieli** on tärkeä työväline. Viestin perille menoon tarvitaan ihmissuhdetaitoja.

Tunteet ovat hyvin tärkeitä viestinnässä. Jos ihmiset eivät ymmärrä toistensa tunteita, viestikin menee tavallista huonommin perille. Parhaimmillaan kahden ihmisen välinen kanssakäyminen perustuu aitoon ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa osapuolilla on itsemääräämisoikeus ja keskinäinen kunnioitus. Jos omien tunteiden ilmaiseminen on vaikeaa, vielä vaikeampaa on toisten tunteiden kuuntelu ja ymmärtäminen. Tunteiden kuuntelulla tarkoitetaan sitä, että toista ihmistä yritetään tosissaan ymmärtää. Toisen ihmisen kuuntelun vastakohta on neuvojen antaminen.

Hoitosuhde

Hoitotyössä on tärkeää tulla toimeen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on erilaiset arvot ja maailmankuva kuin itsellä. Potilasta tulee pitää yksilönä mutta myös kulttuurisen ja uskonnollisen ryhmänsä edustajana. Esimerkiksi potilasohjauksessa lähtökohtana pidetään potilaan arvoja, asenteita ja normeja yhteisesti sovittujen sääntöjen rajoissa. Elei-

siin, ilmeisiin, asentoon sekä etäisyyteen ja katsekontaktiin on syytä kiinnittää huomiota, koska ne paljastavat enemmän kuin sanat. Hoitosuhde on vuorovaikutussuhde, jossa olemisella, tekemisellä ja sanomisella on vaikutusta toiseen ihmiseen.

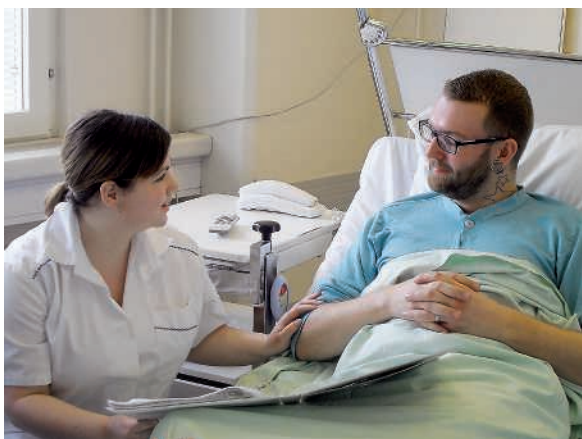
Viestintä on hoitosuhteen väline, jolla on tarkoitus saada aikaan muutosta. Hoitajan ja potilaan välisessä hoitosuhteessa erityistä on havainnointi ja se, miten potilas tulee tiedostetuksi ihmisenä. Hoitosuhde on ammatillinen ja päättyy, kun potilaan hoidon tarve lakkaa. Hoitajan suhdetta potilaaseen kutsutaan hoitosuhteeksi kaikissa hoitamiseen liittyvissä yhteyksissä. Hoitosuhde on myös huolenpitosuhde, koska siinä toimitaan toisen puolesta. Hoitosuhteeseen liittyviä käsitteitä ovat luottamus, vastuu, aitous, rohkeus, myötätunto, empatia, sääli, riippuvuus ja vallankäyttö.

Hoitosuhteet ovat aina myös riippuvuussuhteita, ja vallankäyttö liittyy kaikkiin riippuvuussuhteisiin. Riippuvuussuhteet voivat olla joko haitallisia tai rakentavia. Rakentavassa suhteessa hoitaja pyrkii edistämään ja tukemaan potilaan kasvua, kehitystä, itsenäisyyttä ja omaehtoisuutta. Hoitajan toiminta täyttää ammatillisen toiminnan vaatimukset, kun se perustuu tiedellisiin tosiasioihin ja on eettisten periaatteiden mukaista. Hoitosuhteen tarkoitus ja toimintamuodot sovitaan hoitosuhteen alussa. Sovituina aikoina työskentely auttaa potilasta jäsentämään aikaa, lisää turvallisuudentunnetta ja antaa potilaalle mahdollisuuden itse vaikuttaa tilanteisiin ja ajankäyttöön.

Hoitosuhteeseen kuuluu **ohjaus**, jota hoitaja antaa potilaalle. Ohjaajan persoonallisuus, minäkuva ja ihmiskäsitys säätelevät ohjaajan toimintaa. Ohjaustehtäväänsä motivoituneella hoitajalla on ohjauksessa tarvittavat valmiudet. Hän toimii yhteistyössä potilaan kanssa tavoitteenaan saada potilas itse ratkaisemaan omia ongelmiaan ja pohtimaan keinoja niiden ratkaisemiseksi. Sekä hoitajan että potilaan on luotettava ja uskottava ihmisen kykyyn ja voimaan toipua ja myös tahdottava sitä. Hoitosuhteessa korostuu dialogisuus, jolla tarkoitetaan potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta ja jonka tavoitteena on tiedostava ja toimintakykyinen ihminen.

Hoitajalla on ammattitaitoa luoda inhimillinen yhteys tajuttomaan potilaaseen, muistihäiriöiseen ihmiseen, sairastuneeseen lapseen ja hänen vanhempaisiin ja aggressiivisesti käyttäytyvään ihmiseen. Yhteyden ilmenemismuotoja ovat kosketus, eleet, ilmeet, sanat, puhe, hoitotoimenpiteet, hoivaaminen, huolehtiminen ja välittäminen, jotka vaikuttavat oleellisesti kaikessa kohtaamisessa. Varsinkin sanat ovat ilmaisukeino, joka kuvastaa ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat eettisen hoitamisen keskeisiä taitoja. Hoitajan itsetuntemus sekä negatiivisten tunteiden, väsymyksen ja kyllästymisen avoin ja rehellinen tarkastelu mahdollistavat toisen ihmisen kohtaamisen. Ihminen oppii itsestään toisen ihmisen kautta ja kanssa. Potilaan ja hoitajan tulisi kunnioittaa toistensa subjektiutta. Tämä tarkoittaa, että hoitaja ja potilas ovat tasavertaiset ja että kumpikin toimii yksilönä yhteisössä. Luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen perustuu rehellisyyteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja avoimuuteen. Keskeistä on pyrkimys toisen näkökulman ymmärtämiseen ja oikeaan tulkintaan. Vuorovaikutus on keino etsiä yhteyttä toiseen ihmiseen arvostamalla häntä tasavertaisena ihmisenä.

Hoitosuhteen merkittävin hoidollinen kommunikaatiomenetelmä on **kuunteleminen**. Se on aktiivinen tapahtuma, jossa hoitajalta edellytetään valppautta ja potilaan kokonaisvaltaista huomioimista. Hoitaja rohkaisee potilasta ilmaise-



Kuva 3.1 Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat hyvän hoitajan taitoja.

maan tuntemuksiaan ja mielikuviaan. **Avoimessa kuuntelussa** pyritään kuulemaan, mitä potilas sanoo, lisäämättä siihen mitään ja poistamatta siitä mitään. Tämä vaatii hoitajalta, ettei hän päästä omia tunteitaan valloilleen, vaikka tuntisi sääliä tai kokisi elämäntilanteestaan johtuvia syyllisyydentunteita. Omat tunteet täyttävät helposti mielen ja saattavat estää kuulemasta, mitä potilas kertoo. **Aktiivisessa kuuntelussa** hoitaja ymmärtää potilaan puheen ja näkee yhteyksiä asioissa, joissa potilas ei vielä niitä näe. Keskustelun aitous ja rehellisyys saavat aikaan potilaan voimavarojen löytymisen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Kuuntelua voi oppia.

3.3 Monimuotoisuuden ymmärtäminen hoitotyössä

Sairastumisen aiheuttamat muutokset

Ihmisen vuorovaikutustaidot voivat muuttua vaman sijainnin ja tyyppin mukaan. **Kielellinen ilmaisykyky** on tiiviissä yhteydessä psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen ja hyvinvointiin. Potilaan ääni voi muuttua monotoniseksi ja honottavaksi, puhe hidastua, puheen ymmärtäminen vaikeutua ja sanojen tuottaminen estyä. Omaiset ja läheiset ymmärtävät vaikeutunutta puhetta helpommin kuin vieraat ihmiset. Potilaan ymmärretyksi tulemistä voidaan hoitotyössä helpottaa, kun hänen aikaisemmat kokemuksensa omasta tilastaan ja hoidostaan ja hänen toiveensa huomioidaan. Hoitaja voi kohdata potilaan taitavasti ja ymmärtäväisesti ja antaa hänelle kannustavaa palautetta ja rohkaista ilmaisemaan itseään ymmärrettävällä tavalla, kuten puhumalla, kirjoittamalla, piirtämällä tai näyttämällä.

Puhekyvyn menettäminen ahdistaa sekä potilasta itseään että hänen läheisiään. Joissakin neurologisissa sairauksissa puhe- ja kommunikointivaikeudet alkavat melko pian sairastumisen jälkeen.

Ei-kielellinen eli **kehollinen ilmaisu** on olennainen osa viestintää. Viestintä koostuu sanallisesta viestinnästä (7 %), äänen käytön (äänen korkeuden, sävyn, painotuksen, intonaation ja puhenopeuden, huokausten, henkäysten) vaihteluista (38 %) ja eleistä (55 %). Joissakin sairauksissa, kuten aivohalvauksen jälkeen tai psyykkisissä häiriötiloissa, potilaan elekieli ei kuitenkaan ole normaalia.

Vieraskielinen potilas ja vuorovaikutus

Vieraasta kulttuurista lähtöisin olevan potilaan hoidon tarpeen selvittäminen tuo hoitajalle monia haasteita. Kansainvälistymisen seurauksena muun muassa kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja ihmishuhtedatitojen sekä muiden maiden kulttuurien ja terveysjärjestelmien tuntemisen tärkeys korostuu.

Kulttuurisensitiivisyys eli kulttuurinen herkkyys on ymmärrystä eri kulttuurista tulevien erityispiirteistä, kulttuurista, tavoista tai rooleista. Lähtökohtana kulttuurisensitiiviselle kohtaamiselle on omien asenteiden ja arvojen tarkastelu.

Sanallisen viestinnän keinot saattavat **vieraskielisillä potilailla** olla hyvin rajalliset, jolloin he joutuvat tietoisesti tai tiedostamattaan tehostamaan viestiään kehollisilla merkeillä tai oireilla. Hoitohenkilökunnan velvollisuus on hankkia **tulki** väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Sanat saattavat saada eri kulttuureissa eri merkityksiä, ja eleitä ja ilmeitäkin tulkitaan helposti väärin. Tulkin tulisi kääntää asiat aina sanatarkasti eikä toisen kulttuurin kieleen sopivaksi. Tulkilta saattaa saada arvo-

kasta tietoa siitä, mikä sana vuorovaikutusta ehkä jumiuttaa. Kun sanat eivät riitä, apuna voi käyttää muita menetelmiä, kuten piirtämistä ja valokuvia. Vaikka yhteinen kieli tuntuu usein päällimmäiseltä ongelmalta, esimerkiksi maahanmuuttajaa voi stressata eniten se, ettei hänellä ole vaikeissa elämäntilanteissa ja kohtaamisissa isäntämaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Ihmislle on luontaista käyttää myös kehoaan kokemustensa välittäjänä. Erilainen kulttuuritausta voi hankaloittaa viestintää, sillä kehollinen ilmaisu on kulttuuri- ja tapasidonnaista. Esimerkiksi kehon kautta ilmenevät ja ilmaistavat psyyken häiriöt näkyvät eri kulttuureissa eri tavalla. Joissain kulttuureissa perinne vaatii kasvojen säilyttämistä, ja tällaisissa kulttuureissa esimerkiksi mielen-terveyden häiriöitä pyritään peittelemään muilta. Suomessakin mielen-terveydenhäiriöt koetaan edelleen leimaaviksi ja niistä puhumisesta pidättäyd-tytään. Monissa alkuperäiskulttuureissa psyykkiset häiriötilat luokitellaan esimerkiksi päänsäryksi, lihaskivuksi, pahoinvoinniksi, ruokahaluttomuudeksi, unettomuudeksi, uupumukseksi tai kiihtymykseksi ja niiden hoidoksi määrätään esimerkiksi yrttiteetä, lepoa tai eristämistä.

3.4 Vuorovaikutusta auttavia menetelmiä

Puhetta korvaavia keinoja käyttämällä voidaan mahdollistaa potilaan ymmärretyksi tuleminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja päätöksentekoon osallistuminen. Puhetta korvaavia keinoja käytetään, kun potilaalla on häiriöitä puheviestinnässään. Potilaan puhe- ja kielihäiriön luonne vaikuttaa korvaavien kommunikaatiokeinojen valintaan. Häiriön määrittelee puheterapeutti. Lisäksi puheterapeutti ohjaa potilaan läheisiä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytössä.

Puhetta tukevaa kommunikointia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun potilas ei kykene kommunikoimaan puheen avulla tai hänen puheensa ei ole riittävän selvää, jotta viesti tulisi ymmärretyksi. Puheen tuottamista ja ymmärtämistä häiritseviä sairauksia ovat muun muassa kehitysvamma, autis-



Kulttuurisensitiivisyys on ominaisuus, jonka avulla voi havainnoida, aistia ja kokea kulttuuria sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Se on myös yksilön kokemusten ja havaintojen pohjal- le rakentunut tunnepitoinen suhde kulttuuriin sekä empatian tunne eri kulttuurien edustajia kohtaan. (Suomalainen asiasanas- to ja ontologiapalvelu.)

mi, afasia tai muu puheen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö sekä dysartria (puheli hasten heikkous, halvaantuminen tai tuntopuutokset). Potilaan omia mielipiteitä ja tunteuksia saadaan selville puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla.

Selkokieli on helposti ymmärrettävää kieltä, joka on muokattu rakenteeltaan ja sisällöltään mutkattomaksi. Samat selvyysvaatimukset pätevät myös selkokieliin kuviin. Potilas voi lukea selkokielistä tekstiä itse, tai sitä voidaan lukea hänelle. Selkokieltä voidaan käyttää henkilöille, joilla on puheviestinnän häiriö, ja esimerkiksi maahanmuuttajille, joiden on hankala viestiä valtaväestön kielellä.

Sanalistat toimivat puhetta korvaavana kommunikaatiokeinona, kun potilas ei kykene ilmaistamaan itseään puheen avulla tai hänen puheen ymmärtämisessään on vaikeuksia. Sanalistojen avulla potilas kykenee ymmärtämään kirjoitetun viestin ja ilmaisemaan sen välityksellä oman tahtonsa. Sanalistojen avulla voidaan tiedustella potilaan vointia, kiputunteuksia, ruokailutoiveita ja muita arkipäivän asioita. Potilaalle voidaan välittää ympäristössä tapahtuvia asioita **kuvilla**, joiden avulla potilas kertoo tarpeistaan ja ajatuksistaan. Kuvat voivat olla symbolisia tai esimerkiksi valokuvia tai kuvasarjoja, ja niiden tukena voidaan käyttää ilmeitä ja eleitä. **Nopea piirtämisen tekniikka** toimii kommunikaatiokeinona silloin, kun potilas ymmärtää kuvasymbolien viestittämän merkityksen. Asioista keskustellaan potilaan kanssa piirrettyjen symbolisten kuvien avulla. Potilaan kanssa voidaan kommunikoida myös **kirjoitettujen viestien** avulla. Niiden tulee olla lyhennettyinä yhtenäisiä puhutun viestin kanssa.

Esinekommunikaatio tarkoittaa keskustelua esineiden avulla. Potilaalle annetaan esine, joka liittyy tapahtumassa olevaan toimintaan. Kommunikaation apuvälineitä ovat kommunikointitaulut ja -levyt, joissa on esineitä, kuvia, merkkejä, kirjaimia, sanoja ja numeroita. Moni potilas käyttää tietokonetta tai älylaitetta kaiken viestinnän, kuten keskustelun, kuntoutumisen, vapaa-ajan ja työn, apuvälineenä. **Tukiviittomisella** tarkoitetaan viittomien käyttöä siten, että niillä tuetaan samanaikaista puhumista tai puheen tapailua ääneen. Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kan-

nalta keskeiset sanat, niin sanotut avainsanat. Tukiviittomissa käytetyt viittomat lainataan viittomakielestä. Tarvittaessa viittomia voidaan helpottaa yksilöllisesti. Tukiviittominen on kokonaisvaltaista viestintää, johon kuuluvat puhe, viittomat, ilmeikäs olemuskieli, osoittaminen ja äänensävyjen vaihtelut. Esimerkiksi kysyvällä ilmeellä on tärkeä merkitys kysymyslauseissa. Tukiviittomia voidaan käyttää myös muiden kommunikointikeinojen, kuten kuvien tai kirjoituksen, rinnalla.



Kommunikoinnista ja selkokielestä:

www.papunet.net

www.opike.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

www.aivoliitto.fi

www.viittomat.fi

www.tikoteekki.fi

www.cp-liitto.fi

3.5 Monikulttuurinen hoitotyö

Suomessa on nähtävissä voimistuva monikulttuurisuus. Erilaiset taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset ilmiöt lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vaikuttavat ammatillisiin tehtäviin ja siten edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista osaamista ja uudenlaisia valmiuksia. Monikulttuurisuus tarkoittaa myös laajenevia opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia ulkomailla.

Kulttuuri vaikuttaa keskeisesti ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan, ja kulttuuritaustan merkitys korostuu kansainvälisessä kanssakäymisessä, koska siinä omaa ja vierasta kulttuuria analysoidaan tavallista perusteellisemmin. Vaikka kulttuuri on laajalti tiedostamatonta, sillä on voimakas vaikutus sairauteen ja terveyteen. Terveydenhuollon ammattilaisten työskentelevien on siis tunnistettava ja arvostettava kulttuurisia uskomuksia ja tapoja ja otettava ne mahdollisuuksien mukaan huomioon käytännön hoitotyössä. On kuitenkin muistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on tiettyt säännöt ja normit, joita kaikkien on ikään, su-



Kulttuuriin liittyviä arvoja ja käsitteitä:

- Kulttuurin katsotaan sisältävän arvot, käsitykset, kielelliset ilmaisut, ajattelun muodot, käyttäytymisnormit ja kommunikaatiotyylit.
- Kulttuuri on kokonaisuus, joka määrittyy sosiaalisesta käyttäytymisestä, taiteesta, uskomuksista, arvoista, tavoista, maailmankatsomuksesta ja inhimillisestä elämästä yleensä.
- Kansallinen kulttuuri, johon ihminen syntyy, on yksi kulttuurisen identiteetin muodostumisen keskeinen perusta.
- Ihminen samaistuu siihen ajatusmaailmaan, joka esiintyy hänen omassa kulttuurissaan.
- Kulttuuriarvot viittaavat yksilön haluun tai parhaaksi nähtyyn toimintaan, joka on hyväksytty pitemmän ajan kuluessa.
- Kulttuuriin liittyviä käsitteitä ovat muun muassa asenne, arvot, uskomus, ideologia, kulttuurintuntemus, kulttuuriherkkyys, kulttuuri-imperialismi, kulttuurien erilaisuus ja kulttuurikompetenssi.

kupuoleen ja kulttuuriin katsomatta noudatettava. Esimerkiksi sairaalahygienia asettaa sekä hoitajan että potilaan pukeutumiseen liittyviä rajoituksia.

Kulttuurissa on useita eri kerrostumia, kuten kansallinen, etninen, uskonnollinen ja kielellinen taso sekä sukupuoleen, sukupolveen, sosiaaliseen luokkaan, työpaikkaan ja -organisaatioon liittyvä taso. Geerd Hofstede (2005) määrittelee kulttuurin opituksi "mielen kollektiiviseksi ohjelmoinniksi", joka erottaa yhteen ryhmään tai luokkaan kuuluvat ihmiset toisistaan. Hänen mukaansa kansalliset kulttuurit eroavat toisistaan muun muassa yhteisöllisyydessä ja yksilöllisyydessä, maskuliinisuudessa ja feminiinisyudessa sekä epävarmuuden välttämisessä.

Yhteisöllisessä kulttuurissa ketään ei jätetä yksin hänen sairastaessaan tai joutuessaan kriisiin. On itsestään selvää, että läheiset ovat läsnä. Perheeseen kuuluvat usein vanhemmat ja lähisukulaiset, joiden tärkeys ydinperheen rinnalla korostuu. Yhteisöllisen kulttuurin sisäistänyt ihminen tuntee olevansa riippuvainen ryhmästä ja sen tuesta ja on valmis elämään ryhmän normien mukaan. Hän on herkkä vaistoamaan, millaisia tarpeita toisilla on ja miten kulloinkin tulee käyttäytyä. Yhteisöllisen kulttuurin yhteisöissä uskonnolla on usein paljon tavallista syvempi ja yleisesti tunnistetumpi merkitys.

Epävarmuuden sietämiseen tai sen välttämiseen vaikuttavat kokemukset ja kulttuurinen oppiminen. Epävarmuus on tunne, joka aiheuttaa levottomuutta, mutta tunteella ei ole mitään konkreettista kohdetta. Epävarmuutta välttämissä yhteiskunnissa on enemmän sääntöjä ja ohjeita kuin yhteiskunnissa, joissa siedetään epävarmuutta. Joissakin kulttuureissa potilaat ovat tottuneet siihen, että lääkärit ja sairaanhoitajat ovat auktoriteetteja sairauden ja oireiden määrittelyssä. Potilaat luottavat terveydenhuollon henkilökuntaan kaikessa hoidossa ja kokevat, etteivät he voi ottaa itse vastuuta hoidostaan tai ehdottaa hoitovaihtoehtoja.

Suomea voidaan pitää epävarmuutta välttävänä yhteiskuntana, sillä Suomessa arvostetaan tiukkaa täsmällisyyttä esimerkiksi sovittujen tapaamiskojojen noudattamisessa. Täsmällisyyteen ei kuitenkaan suhtauduta samalla tavalla kaikissa kulttuureissa, joten esimerkiksi ajanvarausten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hämmennystä terveydenhuollossa. Potilasta saatetaankin joutua ohjaamaan siihen, että vastaanotoilla on oltava sovittuun aikaan.

Maskuliinisuus ja feminiinisyys -asteikko kuvaa sukupuoliroolien jakautumaa eri yhteiskunnissa. Hofsteden (2005) mukaan naiset arvostavat työssään enemmän sosiaalisia päämääriä, ihmissuhteita ja muiden auttamista. Miehet taas tavoittelevat menestystä, uralla etenemistä ja hyvää palkkaa. Maskuliinisissa kulttuureissa johtajuuteen kuuluvat vahvat ja autoritaariset päätökset, kun taas feminiiniseen kulttuuriin kuuluu demokraattisempi ja neuvottelevampi päätöksenteko.

➡ Reijonen, K. 2014. Monikulttuurisen hoitotyön kulmakivet. Opas hoitotyön ammattilaisille. Opin- näytetyö. Lahden AMK. Saatavilla osoitteesta www.theseus.fi

Ärting, M. 2010. Romanit terveystalveluiden käyttäjinä. Romanipotilas vuodeosastolla -opas. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämishjelma 2016–2019. Saamelaiskäräjät. Saatavilla osoitteesta <https://dokumentit.solinum.fi/samediggi>

Kulttuurikompetenssi

Kulttuurikompetenssilla tarkoitetaan kykyä ottaa huomioon ihmisten kulttuurista ja tulla toimeen eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Hoitotyössä kulttuurikompetenssi on ammattitaidon osatekijä, joka parantaa terveydenhuollon palvelujen tasoa ja hoitotyön laatua. **Kulttuurikokemus** ohjaa hoitajaa kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. **Kulttuurinen tahto** on puolestaan motivaatio, joka ajaa hoitajaa hakemaan enemmän tietoa kulttuureista ja saa hänet osoittamaan halua olla avoin ja joustava erilaisten ihmisten kanssa. Kulttuurikompetenssia tarvitaan erilaisten kulttuurien luomien **jännitteiden vähentämiseksi**, kun toimitaan eri alakulttuureita, uskontoja, kansallisuuksia ja etnistä alkuperää edustavien ihmisten parissa. Hoitajien tarve tietää erilaisista kulttuureista ja kyky toimia oikein vieraassa kulttuurista lähtöisin olevien asiakkaiden parissa lisääntyy jatkuvasti. Asiantuntevalta hoitajalta vaaditaan monien muiden taitojen ja valmiuksien lisäksi myös kulttuurikompetenssia.

➡ Kokko, R. 2008. Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Vaihto-opiskelun läpikäyneillä sairaanhoitajaopiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet selvittää kansainvälistymisen ja globalisaation haasteista. Erilaiset kulttuuriset arvot ja elämäntavat, kuten koulutustausta ja uskonnolliset ja filosofiset arvot, kohtaavat toisensa sairaanhoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa, joten sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys kulttuuria koskeissa asioissa on ajankohtaista ja tärkeää. Sairaanhoitajakoulutuksessa tulisi lisätä monikulttuurisen hoi-

totyön opetusta, vaihto-opiskeluun valmentamista ja opiskelijoiden ohjausta sekä vaihto-opiskelun aikana että sen jälkeen. Jos vaihto-opiskelukokeuksia ei käsitellä lainkaan, on vaarana, että opiskelijoille saattaa jäädä virheellisiä käsityksiä vieraan maan kulttuurista. Tutkimustulosten perusteella reflektio ja kokemusten jakaminen edistivät vaihto-opiskelukokemusten hyödyntämistä ja tukivat opiskelijoiden ammatillista kehitystä.



Kulttuurisen kompetenssin osa-alueet Gigerin ja Davidhizarin mukaan:

1. **Kulttuurinen tietoisuus** on eräänlainen herkistymisprosessi, jossa tarkastellaan omia uskomuksia ja ennakkokäsityksiä muista kulttuureista ja niiden edustajista. Hoitajan tulisi tunnistaa oman kulttuuristaustansa arvot, uskomukset ja käyttäytymismallit.
2. **Kulttuurinen tieto** on erilaisesta kulttuurista tulevan potilaan näkemyksen ymmärtämistä, erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtämistä ja tietoa ihmisten biologisista, fysiologisista ja psykologisista erilaisuuksista.
3. **Kulttuurinen taito** on taitoa suunnitella ja toteuttaa potilaan kulttuuriset tarpeet huomioivaa hoitotyötä ja taitoa käyttää tarpeenmäärittelymalleja.
4. **Kulttuurinen tahto** on aitoa kiinnostusta ja motivoituneisuutta erilaisten ja eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten hoitamiseen ja ominaisuus, johon liittyy intuitiivinen empatiakyky.
5. **Kulttuurinen kohtaaminen** sisältää ajatuksen eri kulttuureista lähtöisin olevien potilaiden vuorovaikutuksellisesta kohtamisesta ja kiinnostuksen hakeutua kulttuuriin kohtaamistilanteisiin.
6. **Kulttuurinen herkkyys** on erilaisuuden hyväksymisen taito, johon liittyvät empatiakyky ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Kulttuurikompetenssi on hoitajan itsetietoisuuden kehittymistä ja oman olemassaolon, tunteiden, ajatuksien ja toimintaympäristöjen tiedostamista siten, etteivät omat tunteet ja tausta haittaa toiseen kulttuuriin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Hoitaja osoittaa potilaalle, että hän on kiinnostunut tämän kulttuurista ja haluaa siitä lisätietoa. Hoitaja hyväksyy ja kunnioittaa erilaisuutta ja mukauttaa toimintansa kuhunkin monikulttuuriseen hoitotilanteeseen. Erilaisista maailmankuvista ja kulttuureista hankitaan tietoa oman tietämyksen ja maailmankuvan laajentamiseksi. Hoitajan on tärkeää ymmärtää kulttuurin mahdollinen rajoittava vaikutus potilaan valintoihin ja esimerkiksi uskonnon merkitys potilaan elämässä.

Kulttuurisen erilaisuuden kohtaaminen hoitotyössä

Ihmiskunnan historiaan ovat kuuluneet jo sen alkuaajoista lähtien erityyppiset muuttoliikkeet ja väestön liikehdintä asuinalueelta, maasta ja maanosista toiseen. Syyt ovat olleet hyvin moninaisia: muuttoliikkeet ovat johtuneet sekä pakkotilanteista, kuten sodista, väestön pakkosiirroista ja luonnonkatastrofeista, että vapaaehtoisesta siirtolaisuudesta elinolojen parantamiseksi.

Kun esimerkiksi pakolaiset siirtyvät maasta toiseen, heitä voivat haavoittaa menetykset, pitkittynyt suru tai traumaperäinen stressireaktio (kidutusoireyhtymä), pakomatkan traumat ja pakomatka prosessina. Merkityksellistä on, onko maahanmuuttaja yksin, perheensä kanssa vai ryhmässä. Sopeutumiseen vaikuttavat myös koulutustausta, odotukset ja kielitaito.

Maahanmuuton jälkeinen aika uudessa ympäristössä on usein hämmentävää. Merkityksellistä on se, saako maahanmuuttaja sosiaalista tukea ja millainen on hänen kulttuurinen identiteettinsä ja itsevarmuutensa. Muita maahanmuuttajan tilanteeseen vaikuttavia seikkoja ovat hänen sosiaaliset verkostonsa, mahdollinen rasismien kohtaaminen ja työllistyminen.

Omasta arvomaailmasta puhuminen aiheuttaa suomalaisissa toisinaan jonkinasteista vaivautuneisuutta. Eri puolilta maailmaa tulleet potilaat

antavat hoitotyöntekijöille aiheen tarkastella uudesta perspektiivistä omia asenteitaan esimerkiksi suhteessa uskonnolliseen vakaumukseen ja uskonnonharjoittamiseen. Vaikkei ihminen kokisi itseään uskonnollisesti vakaumukselliseksi, uskonto on osa jokaista kulttuuria ja vaikuttaa merkityksiä antamalla ja maailmankuvaa muovaamalla sen syväkerroksissa. On hyvä muistaa, että maahanmuuttajien joukossa on myös uskonnottomia ja uskonnosta vieraantuneita, jotka eivät aktiivisesti harjoita uskontoaan. Uskonto merkitsee heille lähinnä kulttuuri-identiteetin osaa.

Monilla maahanmuuttajilla uskonnolliset tai henkiset tarpeet korostuvat, sillä heillä on vahva muukalaisuuden kokemus. Oman arvomaailman täsmentymättömyys saattaa johtaa hengelliseen hämmennykseen ja orpouteen erityisesti sairaalaan joutumisen yhteydessä. Maahanmuuttaja saattaa kamppailla sairautensa keskellä yksin olemisen pelon, toimenpiteiden pelon, vierauden, epätietoisuuden, nöyryytyksen tunteen, ahdistuksen, ikävän, surun ja psykosomaattisten oireiden kanssa. Hän saattaa kokea ahdistusta myös siitä, että häntä hoitaa eri sukupuolta oleva hoitaja tai hän joutuu jakamaan potilashuoneen tuntemattomien kanssa.

Potilaan **hoitoon vaikuttavia kulttuurisidonnaisia** seikkoja ovat muun muassa potilaan käsitys siitä, miten ja mistä asiasta voi puhua ja kenelle, soveliaisuuskäsitykset, häpeän ja kunnian käsitykset, hoitoihin liittyvät käsitykset, suhtautuminen kärsimykseen, kipuun ja kuolemaan ja niihin reagoiminen. Jos henkilökunnalla ei ole potilaan kanssa yhteistä kieltä, on huolehdittava, että tulkit tai kulttuuritulkit ovat käytettävissä.

Moninaiset kulttuuriarvot ja elämäntavat kohtaavat toisensa sairaanhoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Vieraskielisen ihmisen kohtaaminen helpottuu, kun hänen kulttuuriaan tunnetaan jonkin verran. Kun selvitetään, mikä on hyväksyttävää tai sopimatonta käytöstä vieraassa kulttuurissa ja millaista käyttäytymistä suomalaisessa kulttuurissa suositaan, opitaan oman käyttäytymisen taustalla olevia kulttuuritekijöitä ja hahmotetaan toisen kulttuurin näkökulmasta tälle tyypillisiä käyttäytymisen selityksiä.

Länsimainen käsitys **kulttuuri-identiteetistä** korostaa identiteettien muuttumista, moniulotteisuutta ja monikerroksisuutta ja jopa vastakkaisuutta. Kulttuureissa, joissa muutokset ovat vanhastaan olleet hitaita, ihmisten identiteetit pysyvät samanlaisina. Elämä toistuu sukupolvesta toiseen lähes samankaltaisena. Jos hoitotyön asiakkaan kulttuuri-identiteetti on rakentunut hitaiden muutosten kulttuuriympäristössä, elämä länsimaisessa nopeiden muutosten yhteiskunnassa saattaa tuntua hänestä kaaokselta.

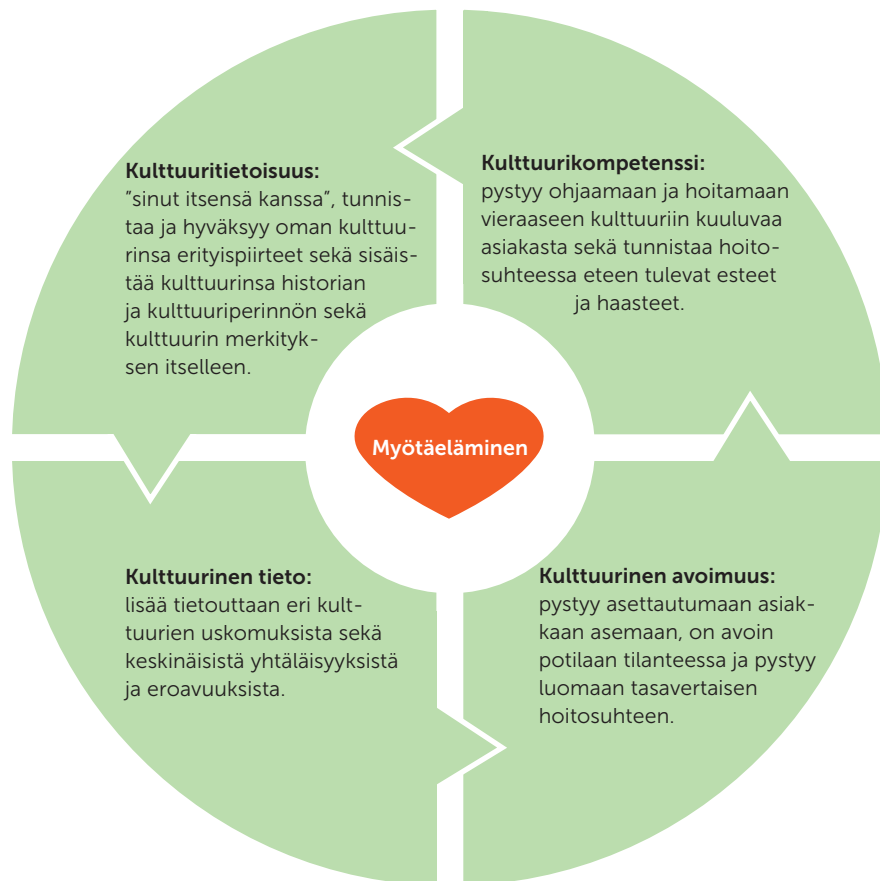
Kun pyritään ymmärtämään toista, kaikkein tärkeintä on, että kohtaamisen lähtökohtana on suvaitsevainen ja myötäelävä (compassion) asenne. Toisen ihmisen elämän pohtiminen myös hänen oman kulttuurinsa näkökulmasta ja sopeutu-

misprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen auttavat työssä (ks. kuva). **Irena Papadopouloksen mallissa** sairaanhoitajalla on seuraavat ominaisuudet: empatian taito, kyky kommunikoida, kyky toimia avoimesti, kyky herättää luottamusta, kyky kunnioittaa toisia ja kyky hyväksyä toiset ihmiset.

Papadopouloksen mukaan kulttuuriseen kompetenssiin kuuluvat sairaanhoitajan arviointi- ja diagnosointitaidot, kliiniset taidot sekä ennakoilu- ja syrjinnän kyseenalaistaminen.

Monikulttuurinen hoitotyö on hoitotyötä, joka on potilaalle sopivaa hänen omassa tai mahdollisimman paljon sitä muistuttavassa kulttuuriympäristössä.

Monikulttuurisen hoitotyön päämäärä on kehittää hoitotyön käytäntöjä ja henkilöstön kult-



Kuva 3.2 **Papadopoulos, Irena: Malli kulttuurikompetenssin ja myötäelämisen kehittymisestä terveydenhuoltoalan ammattilaisille** (vapaasti mukaeltu lähteestä Developing tools to promote culturally competent compassion, courage and intercultural communication in healthcare 2016. Journal of Compassionate Health Care).

tuurista herkkyyttä sekä edistää kulttuurista tasa-arvoa ja ihmisarvon kunnioitusta hoitotyössä. Monikulttuurinen hoitotyö on asiakkaan voimaantumista omaan terveyteensä liittyvässä päätöksenteossa.

Monikulttuurinen hoitotyö on kehitetty vastaamaan ihmisten ja ihmisryhmien inhimillisen hoidon tarpeeseen. Sen taustalla ovat yksilöiden, perheiden ja ryhmien kulttuuriarvot, uskomukset ja käytännöt, jotka pyritään tunnistamaan ja joita kunnioitetaan. Hoitajan tulee tuntea kulttuurin merkitys terveyden edistämiseksi ja hoitotyössä. Kun hän toimii eri kulttuureista lähtöisin olevien yksilöiden ja perheiden parissa, hänen tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden toteutumista hoitotyössä.

Kulttuurisesti ainutlaatuinen potilas

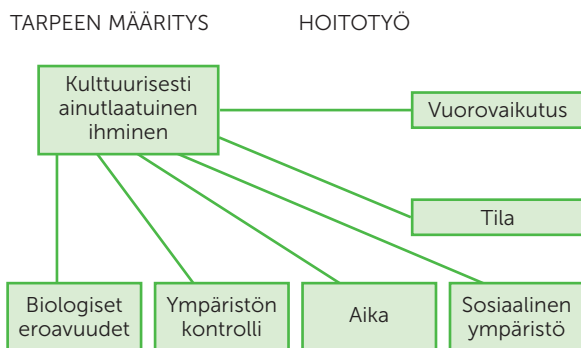
Gigerillä ja Davidhizarilla on transkulttuurisen hoitotyön malli. **Transkulttuurinen hoitotyö** määrittää mallissa kulttuurisesti päteväksi käytännön toiminnaksi, joka perustuu potilaskeskeisyyteen ja tutkimustietoon. Se perustuu näkemykseen, jonka mukaan kulttuuri vaikuttaa siihen, miten potilaaseen suhtaudutaan ja miten häntä hoidetaan. Mallin ydinajatus on, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen, kulttuurinen yksilö. Potilaan hoidon tarpeita tulee siten arvioida kulttuuristen taustatekijöiden mukaisesti. Arvioitavat kulttuuriset tausta-

tekijät ovat kommunikaatio, tila, sosiaalinen orientaatio, aika, ympäristön kontrolli ja biologiset variaatiot (ks. kuva 3.3).

Kun hoitotyössä määritellään potilaiden tarpeita, tulee huomioda, että jokainen potilas on ainutlaatuinen myös kulttuuriperusteisilta tarpeiltaan. Ihmisillä on tapana kuvata tuntemuksiaan monin tavoin. Jotkut puhuvat avoimesti läheisistään, kun taas joillekuille perheen sisäiset asiat ovat intiimejä, eikä niistä puhuminen ole sopivaa. Ihmiset tarvitsevat omaa tilaa niin kotonaan kuin hoitolaitoksessakin. Yhteisöissä kulttuureissa on tavallista, että toisilleen vieraat ihmiset voivat olla luontevasti vierekkäin esimerkiksi olkavarren mitan etäisyydellä toisistaan, kun taas suomalaisessa kulttuurissa intiimi alue on noin metri, joten hoitajan tulee huomioda, että jotkut potilaat haluavat etäisyyttä ja tilaa enemmän kuin toiset.

Ihmisillä saattaa etnisen taustan vuoksi olla biologisia eroja. Ne voivat liittyä esimerkiksi ihonväriin, ruumiinrakenteeseen ja lääkeaineiden vaikutukseen elimistössä. Ympäristön vaikutus ja kontrolli ihmisen elämään näkyvät elämänarvoissa, kuten siinä, miten kulttuurissa määritellään terveys ja sairaus ja mitä ympäristössä olevia tekijöitä pidetään terveyttä edistävinä tai haittaavina. Aikakäsityksellä tarkoitetaan sitä, miten aika määritellään. Aika voidaan ymmärtää menneeksi, nykyiseksi tai tulevaksi ajaksi. Ihminen toimii sen mukaan, miten hänen kulttuurissaan aika ymmärretään. Toisissa kulttuureissa ihmisen perustarpeet määrittelevät ajan, jolloin esimerkiksi ruokailuajat määräytyvät nälän tunteen mukaan. Myös täsmällisyyden käsittäminen liittyy aikakäsitykseen. Se, miten työ- ja vapaa-aika erotellaan toisistaan, riippuu kulttuurien arvoista ja normeista. Sosiaalinen yhteisö viittaa niihin tapoihin, joita perhe ja lähiyhteisö arvostavat ja noudattavat.

Hoitajan oma kulttuuritausta on hyvin merkittävä tekijä. Hän ei voi jättää sitä taakseen ja ymmärtää täysin potilaan kulttuuritaustaa. Hoitaja saattaa joutua siirtämään itselleen tärkeän asian, menetelmän, näkökulman tai arvon taka-alalle, jotta hän saisi saatetuksi potilaan asian tämän edun mukaiseen lopputulokseen.



Kuva 3.3 Potilaan kulttuuriperusteisten tarpeiden arviointi. (Mukailtu lähteestä Giger & Davidhizar 2002)

Erilaiset katsomukset ilmenevät sairaaloissa myös monikulttuuristuvan henkilökunnan näkemyksissä siitä, mikä on sopivaa ja mikä kiellettyä. Esimerkiksi Aasiasta ja Afrikasta kotoisin olevat hoitajat huomioivat potilaan osana taustayhteisöään useammin kuin yksilökulttuuria korostavat työntekijät. Kiireiseen ja teknistyneeseen hoitotyöhön tottuneet hoitajat voivat oppia heiltä, miten lämpimästi potilaita voidaan lähestyä, miten potilaista voidaan puhua ja miten potilaiden henkiset ja hengelliset tarpeet voidaan huomata.

Kaikilla ihmisillä ja ihmisryhmillä ilmenee sopeutumisvaikeuksia ja ongelmia vieraassa kulttuurissa. Sopeutumisen keskeisimpiä ongelmia ovat fyysiseen, sosiokulttuuriseen ja henkiseen sopeutumiseen sekä aikakäsitykseen liittyvät ongelmat. Fyysiseen sopeutumiseen kuuluvat ravitsemukseen, asumiseen, hintatasoon ja yhteiskunnan palveluihin tottuminen. Henkiseen sopeutumiseen

taas kuuluvat sopeutuminen rooliodotuksiin, käsityksiin oppimisesta ja toimimiseen vieraalla kielellä. Sosiokulttuurinen sopeutuminen on vaikeimpia alueita. Valtaväestön sosiaalisiin verkostoihin mukaan pääseminen voi olla jopa lähes mahdotonta, minkä vuoksi yksinäisyyden kokeminen vieraassa kulttuurissa on tavallista.

Potilaan tapojen, elämän ja arvojen kunnioitus ja hänen tahtonsa noudattaminen on peruslähtökohta, kun keskustellaan hänen hoidostaan. Hoitaja tarvitsee aina tietoa ja ymmärrystä potilaansa ja tätä ympäröivän yhteisön arvomaailmasta ja yhteisön tavoista. Jotta erilaisista oloista tuleva ja vierasta kieltä puhuva potilas voisi kääntyä terveydenhuollon puoleen, hän tarvitsee tietoa siitä, miten terveydenhuolto voi häntä auttaa. Yhteisymmärrys ja vuorovaikutustaito ovat olennainen osa potilaiden hoitoa niin valtaväestön kuin vähemmistöjen ja muiden kulttuurien edustajien parissa.

Ohjeita vieraasta kulttuurista lähtöisin olevan potilaan hoitamiseen:

- Ota ensisijaisesti huomioon potilaan omat toivomukset ja tarpeet.
- Muista, että vieraita uskontoja ja kulttuureja kohdattaessa on tärkeää välttää yleistyksiä.
- Käytä tulkkia aina tarvittaessa. Vältä omaisten käyttöä tulkin tehtävissä.
- Kysy, jos et tiedä. Uskonnollisista ja kulttuurisista tavoista voi kysyä asianosaiselta itseltään.
- Muista, että eri kulttuurien käsitykset elämästä ja kuolemasta, miehen ja naisen roolista ja sukupolvien välisistä suhteista vaihtelevat suuresti.
- Kuuntele ja suhtaudu kunnioittavasti erilaisiin maailmankatsomuksiin. Varaa aikaa tutustumiseen.
- Tunne oma kulttuurisi ja omat arvosi. Tavallisenä pitämäsi käytös voi olla vierasta toiselle.
- Muista, että eroja voi olla sielläkin, missä niitä ei heti havaitse. Erojen korostamisesta voi kuitenkin tulla vuorovaikutuksen este.
- Muista, että monelle ihmiselle uskonto on tärkeä myös arkielämässä ja käytännön asioissa. Maahanmuuttajilla uskonnon merkitys usein kasvaa.
- Muista, että perheen ja suvun merkitys korostuu vakavan sairauden aikana. Useissa kulttuureissa omaisilla on tiettyjä velvollisuuksia sairasta kohtaan.
- Muista, että pakolaiset ja uudet maahanmuuttajaryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia.
- Älä unohda vaitiolovelvollisuutta potilaan asioista neuvoteltaessa. Kerro hoitohenkilökunnan vaitiolovelvollisuudesta myös potilaalle.
- Kunnioita vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan rauhaa. Varaa rauhalliset tilat hiljentymiseen ja kuolevalle oma huone.
- Muista, että arvokkaaseen kuolemaan kuuluu myös vainajan kunnioittaminen. Ota huomioon vainajan ja omaisten tahto.

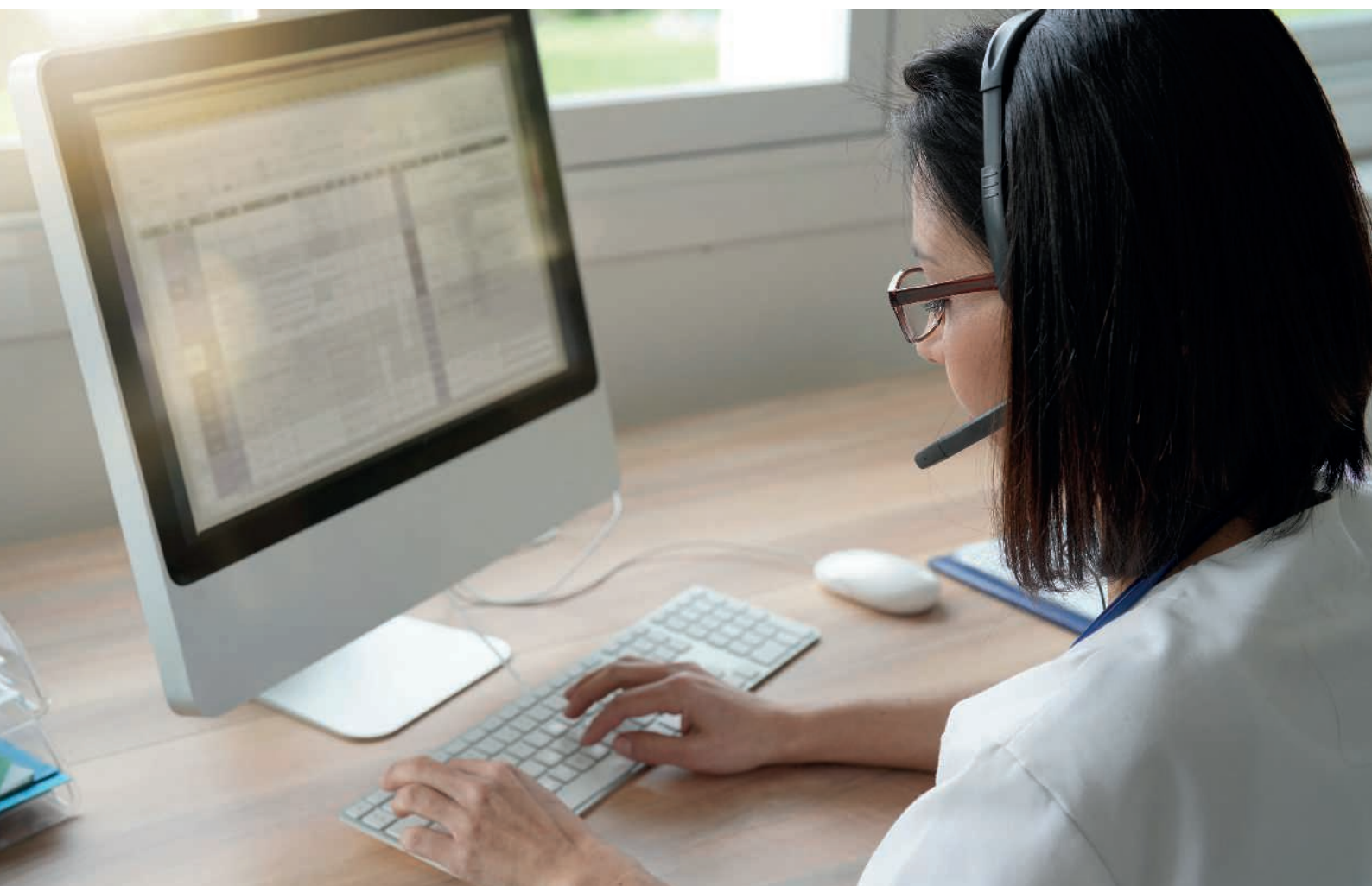
Oikeus hyvään hoitoon, ihmisen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus ovat hoitotyön periaatteita, joita jokaisen hoitajan on velvollisuus noudattaa myös monikulttuurisessa hoitotyössä. Suomalaiset eivät ole monikulttuurisuuskysymyksessä vain antava osapuoli ja palveluiden tarjoaja. Muista kulttuureista ja elinympäristöistä Suomeen tulevat ihmiset opettavat suomalaisille yhteisöllisyyttä ja tuovat yhteisöjen ja yhteiskunnan arvokeskusteluun uusia näkökulmia. Muualta tulevat voivat rikastuttaa terveydenhuollon työyhteisöä ja työvoimaa ja helpottaa eri kulttuureista lähtöisin olevien potilaiden ymmärtämistä, kohtaamista ja hoitamista. Toisenlaisuuden ja erilaisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset on hyvä tuntea ja tunnistaa.

4

Hoitotyön prosessi ja näyttöön perustuva dokumentointi

Tässä luvussa

- Kirjaamisen lainsäädäntö
- Raportointi
- Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön prosessi



Potilaslähtöinen ja asiakaskeskeinen **kirjaaminen** on hoitotyön osaamisen ydinaluetta, ja se vaatii hoitotyöntekijöiltä tiedollisia, taidollisia ja eettisiä valmiuksia. Hoitotyön kirjauksilla tarkoitetaan tallennettua tietoa, jolla oikeutetaan tai perustellaan potilaan saama hoito tai joka toimii todisteenä hoidon vaikuttavuudesta. Kirjaamisen tulee olla hoitotyön periaatteiden mukaista: kunnioittavaa, potilaslähtöistä, yksilöllistä, jatkuvaa ja turvallista. Hoitotyöntekijät ovat vastuussa potilaan tietojen asiallisesta ja totuudenmukaisesta kirjaamisesta, tietojen suojaamisesta, tiedon kulusta oikeille tahoille ja hoitomääräysten toimeenpanosta. Kirjaamisessa ilmaistaan aina tiedon lähde ja kirjaaminen varmennetaan nimellä, jolloin kirjaaja voidaan tarvittaessa jälkikäteen tunnistaa.

4.1 Kirjaamista ja tiedonhallintaa ohjaa lainsäädäntö

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annetut lait, säännökset ja ohjeistukset koskevat kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Potilaan ja terveydenhuollon asiakkaan yleiset oikeudet ilmaistaan muun muassa perustuslaissa, julkisuuslakiasetuksessa, EU-normistossa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Kirjaamisen seuraamuksista ohjeistavat muun muassa potilasvahinkolaki, hallintolaki ja rikoslaki.

Hoitotyön kirjaamista ohjeistavat muun muassa lainsäädäntö, asetukset, normistot, hoitajan eettiset velvoitteet, organisaation sisäiset kirjaamisohjeet ja yksikkökohtaiset ohjeet ja suositukset. Hoitotyön kirjaamiseen kuuluvat potilaaseen liittyvän tiedon luotettava, tehokas ja potilaslähtöinen tuottaminen, säilyttäminen ja jakaminen. Potilaan yksityisyys ja oikeusturva varmistetaan **tietosuojan** avulla. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee merkitä potilasasiakirjoihin keskeiset ja tarpeelliset tiedot potilaan hoidosta. Seuraavassa käsitellään kirjaamiseen ja dokumentointiin liittyvän lainsäädännön ydinkohtia. Jokaisella hoitotyöntekijällä ja hoitotyön opiskelijalla on velvollisuus **perehtyä lainsäädäntöön** tarkemmin.



Hoitotyön kirjaamista ohjaavaa lainsäädäntöä:

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), potilaslaki
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298 ja asetus laadun hallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (2011/341)
- Terveydenhuoltolaki (2010/1326)
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
- Asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta STM 2011
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), asiakaslaki
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Laki sähköisestä asioinnista viranomais-toiminnassa (13/2003)
- Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
- Arkistolaki (831/1994)
- Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
- Potilasvahinkolaki (585/1986)
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
- Mielenterveyslaki (1116/1990)
- Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
- Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)



Perehdy ajantasaiseen lainsäädäntöön:

www.finlex.fi, www.edilex.fi

1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli niin sanottu potilaslaki määrittelee **potilasasiakirjat** muun muassa potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetyiksi, laadituiksi tai saapuneiksi asiakirjoiksi tai teknisiksi tallenteiksi, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Terveystieteiden ammattihenkilön tulee kirjata potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun ja seurannan turvaamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Laissa todetaan muun muassa, että terveyden- ja sairaanhoitoa toteuttaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010)

Laki edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä. Laissa säädetään asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sitä sovelletaan niin julkisiin kuin yksityisiin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajiin. Asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleisiä vaatimuksia ovat muun muassa saatavuus ja käytettävyys. Asiakastietojen tulee säilyä eheinä ja muuttumattomina koko säilytysajan, ja jokaisen asiakkaan tiedoista tulee olla vain yksi tunnisteella yksilöity alkuperäiskappale. Aiheellisesta syystä otettu jäljennös merkitään jäljennökseksi. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä ja näiden käyttöoikeuksista.

3. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298)

Potilasasiakirjoja koskeva asetus sisältää säännökset potilasasiakirjojen laatimisesta, niihin merkittävistä tiedoista sekä asiakirjojen säilytysajoista ja -tavoista. Valtakunnallinen sähköinen potilastietojärjestelmä edellyttää esimerkiksi, että potilasasiakirjat on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Asetus turvaa sen, että potilasasiakirjoihin sisällytetään potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset, riittävät ja virheettömät tiedot ja että tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asetuksella edistetään potilaan laadukasta ja hyvää hoitoa, potilaan oikeusturvaa, potilaan yksityisyyden suojaa, potilassuhteen luottamuksellisuutta ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa.

Asetusta sovelletaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen ja niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseen. Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai -asiakirjat sekä lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat. Lisäksi potilasasiakirjoihin kuuluvat muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat.

Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain niin laajasti kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Terveystieteiden toimintayksikössä työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjojen tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti. Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä, kun he toimivat laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaisesti. Muutoin

terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyvät hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö.

Potilasasiakirjamerkintöjä koskevat periaatteet ja vaatimukset

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin potilasta itseään koskevia tietoja.

Jos potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn takia on hoidon kannalta tarpeellista kirjata jonkun muun henkilön itsensä tai omasta elämäntilanteestaan kertomia yksityiskohtaisia arkaluonteisia tietoja, ne kirjataan potilaan palvelutapahtuman asiakirjoihin kuuluvaan erilliseen asiakirjaan, jollei potilasmerkintöjen kokonaisuus huomioon ottaen ole aiheellista kirjata niitä muulla tavalla. Arkistointipalveluun tallennettavien sähköisten potilasasiakirjojen rakenteissa ja merkinnöissä tulee käyttää Terveystietokeskuksen ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia rakenteita ja merkintöjä sekä Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä tietoteknisiä määräyksiä.

Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä viivyttyksettä. Merkinnät tulee tehdä viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta tai kun palvelutapahtuma muutoin päättyy. **Lähetteet** tulee laatia ja toimittaa jatkohoitopaikkaan viipymättä. Lähetete tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää jatkohoitopaikkaan viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun sen tekemisen tarve on todettu. **Yhteenvedo** potilaalle annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen tulee potilaan suostumuksen mukaisesti ja viipymättä toimittaa potilaalle ja jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta on potilaan kanssa sovittu. Yh-

teenvedo tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää viiden vuorokauden kuluessa hoidon päätymisestä. Terveystietokeskuksen toimintayksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää jokaisesta potilaastaan ajan tasalla olevaa, aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta. Potilaskertomusta tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen eikä alkuperäistä sivua korvata valokopiolla tai muulla vastaavalla tavalla.



Potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot:

- potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
- terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi
- merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
- saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde
- alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

Potilasasiakirjoista tulee ilmetä myös seuraavat tiedot:

- potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteys henkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot
- potilaan äidinkieli tai asiantuntijakieli
- potilaan ammatti
- potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtapaturma tai ammattitauti
- vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö
- tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset.

Potilaskertomukseen merkitään keskeiset hoitotiedot potilaan jokaisesta palvelutapahtumasta. Palvelutapahtumia koskevista tiedoista tulee käydä tarvittavan laajasti ilmi seuraavat asiat tai osiot: tulosyy, esitiedot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, taudinmäärittäminen tai terveystilanne, johtopäätökset, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku ja loppulausunto.

Sairauden ja hoidon kulkua koskevista merkinnöistä tulee käydä riittävän laajasti ilmi diagnoosi ja valitun hoidon ja tehtyjen hoitoratkaisujen perusteet. Lisäksi merkinnöistä tulee käydä ilmi, miten hoito on toteutettu, onko hoidon aikana ilmennyt jotakin erityistä ja millaisia hoitoa koskevia ratkaisuja sen kuluessa on tehty. Hoitoon osallistuneet on tarvittaessa kyettävä selvittämään. Suoritetusta leikkauksesta ja muusta toimenpiteestä tulee laatia leikkaus- tai toimenpidekertomus, joka sisältää riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen toimenpiteestä ja sen aikana tehdyistä havainnoista. Kertomuksessa tulee esittää toimenpiteen aikana tehtyjen ratkaisujen perustelut. Tiedot potilaalle pysyvästi asetetuista proteeseista, implanteista, hampaiden täyttemateriaaleista ja muista materiaaleista tulee merkitä potilasasiakirjoihin siten, että ne ovat myöhemmin tunnistettavissa.

Kaikki annetut lääkemääräykset, lääkärinlausunnot, sairaustodistukset, työkyvyttömyystodistukset ja muut todistukset sekä kuntoutussuunnitelma tulee merkitä potilaskertomukseen niiden antamisajankohdan mukaisesti. Sähköisessä potilastietojärjestelmässä edellä mainitut merkinnät voidaan tehdä liittämällä ne kyseiseen palvelutapahtumaan. Jos potilaan itsemäärittämiskeutta rajoitetaan mielenterveyslain (1116/1990), päihdehuoltolain (41/1986), tartuntatautilain (583/1986) tai muun lain nojalla, siitä tulee tehdä potilasasiakirjoihin erillinen merkintä, josta käyvät ilmi toimenpiteen syy, luonne ja kesto, arvio sen vaikutuksesta potilaan hoitoon sekä toimenpiteen määränneen lääkärin ja toimenpiteen suorittajien nimet.

Potilaskertomukseen tehdään merkinnät **riskeistä, hoidon haitallisista vaikutuksista ja epäillyistä vahingoista**, kuten potilaan lääkeaineallergioista, materiaali-allergioista, yliherkkyyksistä ja

muista hoidossa huomioitavista seikoista. Potilaskertomukseen tulee merkitä tiedot todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta. Epäillyistä potilas-, laite- ja lääkevahingoista tulee tehdä potilaskertomukseen yksityiskohtaiset merkinnät vahingosta ja selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laite- ja lääkevahinkojen osalta tarvitaan myös kuvaus epäillyistä vahingon syystä. Lääkkeiden ja laitteiden tunnistetiedot tulee merkitä yksilöidysti. Merkinnät tulee tehdä heti sen jälkeen, kun vahinkoepäily on syntynyt.

Potilaskertomukseen tulee tehdä riittävän usein ja **aikajärjestyksessä** merkinnät potilaan tilan muutoksista, hänelle tehdyistä tutkimuksista ja annetusta hoidosta. Lisäksi kertomukseen tehdään hoitojaksokohtaisesti päivittäin merkinnät potilaan tilaan liittyvistä huomioista, hoitotoimista ja vastaavista seikoista. Lääkärin tulee tehdä sairaalahoidossa olevan pitkäaikaipotilaan potilasasiakirjoihin seurantayhteenveto vähintään kolmen kuukauden välein hoitotakson alkamisesta, olipa potilaan tilassa tapahtunut olennaisia muutoksia tai ei.

Hoitovastuussa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmäärittäksen tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta sekä muusta vastaavasta konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä tulee käydä ilmi konsultaation tai neuvottelun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet henkilöt ja tehty hoitoratkaisu ja niiden toteuttaminen. Potilasasiakirjoihin tulee tehdä tarvittavat merkinnät potilaalle annetusta ensihoidosta ja sairaankuljetukseen liittyvästä hoidosta ja seurannasta. Jos lääkäri osallistuu **ensihoidon tai sairaankuljetukseen** henkilökohtaisesti tai esimerkiksi puhelimitse tehdyn konsultaation perusteella, sen tulee käydä ilmi potilasasiakirjoista.

4. Terveydenhuoltolaki (2010/1326)

Terveydenhuoltolaissa todetaan **potilastietorekisteristä ja potilastietojen käsittelystä**, että sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja sen mukaan kuin potilaan hoito edellyttää. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Kielto-oikeuden mahdollistamiseksi potilaalle on annettava selvitys yhteisestä potilastietorekisteristä, tietojen käsittelystä ja hänen mahdollisuudestaan kieltää toimintayksiköiden välinen tietojen luovutus. Selvitys on annettava ennen ensimmäistä toimintayksiköiden välistä tietojen luovutusta. Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto potilaalle annetusta selvityksestä ja hänen tekemistään luovutuskielloista.

5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/ 1994)

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrätään muun muassa, että terveydenhuollon ammattihenkilön ja kunkin terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat lakien säätämällä tavalla. Hoitotyön ja kirjaamiseen tulee perustua näyttöön eli hoitotyön kirjaamisessa tulee näkyä, minkälaiseen tietoon päätökset perustuvat ja mitä hoitotyön keinoilla on saatu aikaan. Kirjaamisen tavoitteena on myös, että potilaat saavat asiakirjoistaan luotettavaa tietoa terveyteen liittyvistä vaihtoehdoista.

- ➔ Häyrinen, K. 2011. Kliininen tieto hoitoprosessissa. Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Tutkimuksessa suositetaan potilaan hoitoon osallistuville, että he sitoutuisivat suositusten mukaisiin kirjaamiskäytäntöihin ja osallistuisivat kirjaamiseen liittyviin koulutuksiin.

4.2 Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Valtakunnallisesti yhtenäinen rakenteinen kirjaaminen ja sähköinen potilaskertomus ovat olleet Suomessa tavoitteena jo pitkään. Hoitotietojen systemaattisessa kirjaamisessa potilaan hoito kuvataan sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä hoidollisen päätöksenteon vaiheiden mukaisesti. Potilaasta tulee laatia aikajärjestyksessä etenevä potilaskertomus. Ydintiedot ovat keskeisiä potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja.

Systemaattisen kirjaamisen mallissa hoitotyön kirjaaminen jäsennetään **hoitoprosessin** mukaan, eli prosessin vaiheet ovat rakenteisen kirjaamisen perusta. Kirjaamisessa käytetään hoitotyön ydintietoja ja hoitoprosessin eri vaiheet kirjataan systemaattisesti Finnish Care Classification (FinCC) luokituskokonaisuuden avulla. Hoitotyön ydintiedot ovat **hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitotyön yhteenveto ja hoitoisuus**.



Potilaskertomuksessa ydintietoja ovat

- potilaan tunnistetiedot
- hoidon antajan tunnistetiedot
- hoitojakson ja tapahtuman tunnistetiedot
- ongelmat ja diagnoosit
- terveyteen vaikuttavat tekijät
- fysiologiset mittaukset
- hoitotyön ydintiedot
- toimintakyky
- lääkehoito
- tutkimukset
- toimenpiteet
- apuvälineet
- elinluovutustestamentti
- hoitotahto
- suostumus potilastietojen luovutukseen
- hoitotyön yhteenveto
- jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot
- lausunnot.

Suomalainen hoidon tarveluokitus ja Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus koostuvat molemmat 17 samannimisestä komponentista eli hoitotyön sisältöalueesta. Komponentit sisältävät vaihtuvan määrän pää- ja alaluokkia.



FinCC sisältää:

Suomalaisen hoitotyön tarveluokituksen (SHTaL)

Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL)

Suomalaisen hoitotyön tuloluokituksen (SHTuL).

FinCC-luokitusten komponentit:

- aktiviteetti
- erittäminen
- selviytyminen
- nestetasapaino
- terveyskäyttäytyminen
- hoidon ja jatkohoidon koordinointi
- lääkehoito
- ravitseminen
- hengitys
- verenkierto
- aineenvaihdunta
- turvallisuus
- päivittäiset toiminnot
- psyykkinen tasapaino
- aisti- ja neurologiset toiminnot
- kudoseheys
- elämäntapa.

4.3 Kirjaamisen perusta: hoitotyön prosessi

Prosessilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jonka tuloksena saadaan haluttu tuotos. Prosessin eri vaiheisiin liittyy päätöksiä, jotka vaikuttavat prosessin seuraavien vaiheiden valintaan ja suoritukseen tai

mahdollisesti jopa prosessin keskeyttämiseen. Hoitotyön prosessi on mukautettu tieteellinen menetelmä tai malli, joka tarjoaa hoitotyölle tietyn järjestyksen ja suunnan. Se on ammatillisen käytännön ydin ja työväline. Prosessi tarjoaa myös keinot hoitajien tekemän hoitotyön laadun arviointiin ja selventää vastuuta potilaasta ja hänen hoidostaan. Hoitotyön prosessi on hoitajan työväline ja menetelmä, joka auttaa päätöksenteossa, seu-



Hoitotyön prosessin vaiheet:

- 1. Hoidon tarve:** Selvitetään, mitä hoidon tarpeita tai ongelmia potilaalla on. Asetetaan potilaan hoidon tarpeet tärkeysjärjestykseen. Täydennetään tietoja koko hoitojakson ajan.
- 2. Hoidon tavoitteet:** Selvitetään, mitä potilas odottaa tai haluaa tapahtuvan ja mitä hänen tilassaan odotetaan tapahtuvan. Asetetaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen.
- 3. Suunnitellut toiminnot:** Selvitetään, mitä hoitotyön erilaisia auttamismenetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan, miten potilas haluaa toimittavan ja mitä ohjeita hoitotyön suositukset antavat.
- 4. Hoidon toteutus:** Käytetään suunniteltuja hoitotyön toimintoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitetään potilaan vointi yksityiskohtaisesti.
- 5. Hoidon arviointi:** Selvitetään, onko tavoitteet saavutettu, mitä muutoksia potilaan tilassa tapahtui, millaiset ovat potilaan kokemukset hoidosta ja millaisia uusia tarpeita ja voimavaroja potilaalla on.

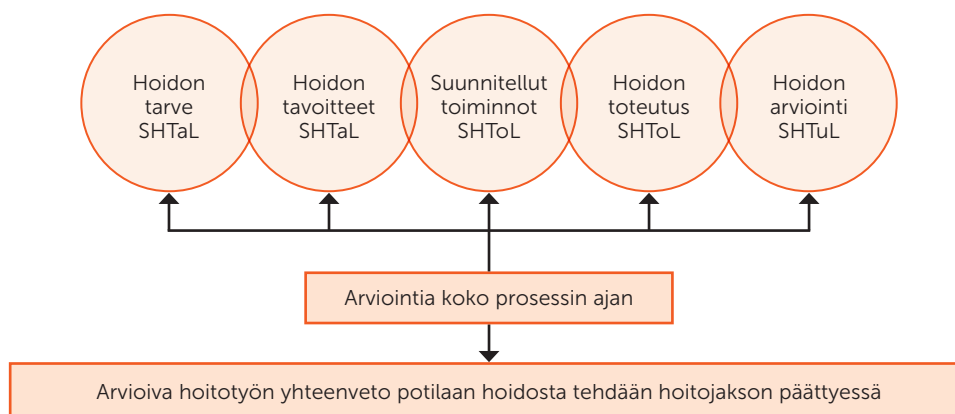
Arvioita tehdään prosessin jokaisessa vaiheessa. Arvioiva hoitotyön yhteenveto tehdään potilaan hoidosta hoitojakson päättyessä.

rausten ennustamisessa ja arvioinnissa. Hoitoprosessi tulee suunnitella potilaan näkökulmasta, ja hoitotapahtuman aikana syntyvän informaation tulee olla jaettavissa muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoidollisen päätöksenteon eli hoitotyön prosessin vaiheet ovat hoidon tarpeen määrittäminen, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus

ja hoidon arviointi. Hoitotyössä kirjataan olennaisimmat potilaan hoitotyöhön liittyvät tiedot ja päätökset. Koko hoitotyön prosessi dokumentoidaan kirjallisesti, jotta potilasta koskeva tieto saadaan kaikille hänen hoitoonsa osallistuville.

Hyvä kirjaaminen on onnistuneen hoidon apuväline. Kirjallinen **hoitosuunnitelma** on hoidon ja

Kuva 4.1 Hoitotyön prosessi



Taulukko 4.1 Kansallisen hoitotyön kirjaamisen malli

Rakenteistaminen	Hoito- prosessin eri vaiheet	Tulotilanne		Hoidon suunnittelu			Hoidon toteutus	Hoidon arviointi	
	Hoitotyön prosessin vaiheet	Tietojen keruu ja analy- sointi *	Hoidon tarpeiden määrittys ja priorisointi	Tavoit- teiden asetta- minen	Suunnitellut toiminnot tavoitteiden saavuttamiseksi	Hoitotyön toiminnot / toteutus	Hoidon tulokset	Hoitotyön yhteen- veto	
	SHTaL ja SHTuL (Hoidon tar- veluokitus ja hoidon tuloksen tila -luokitus)	–	SHTaL ja varmuus- aste (ja mittari esim. VAS, GAF)	SHTaL	–	–	SHTaL ja SHTuL (ja mittari VAS, GAF)	Koostetaan hoitojakson kannalta keskeisistä hoitotyön ydin- tiedoista (luokitus + vapaa- teksti)	
	SHToL ja SHTuL (Hoitotyön toimintoluo- kitus ja hoi- don tuloksen tila -luokitus)	–	–	–	SHToL	SHToL ja mittari (esim. VAS, GAF)	SHToL ja SHTuL (ja mittari VAS, GAF) **		
	Hoitotyön ydintiedot	Ydin- tietoja *	Hoidon tarve			Hoitotyön toiminnot	Hoidon tulos	Hoitotyön yhteen veto	Hoitoi- suus **

* Ydintiedoista saadaan osa hoitotyön tarvitsemista tiedoista kuten lähtötiedot, riskitiedot, hoidon syy, lääkehoito, lääketieteellinen diagnoosi, tutkimukset, toimenpiteet, toimintakyky ja apuvälineet.

** Hoitoisuusmittaus tehdään prosessin kohdassa arviointi ja käytetään mittareita: OPC (Oulu Patient Classification) tai OPCq (Rafaela). (STM 2009).

sen kehittämisen apuväline, minkä vuoksi sen on oltava aina ajan tasalla. Hoitosuunnitelman avulla kaikki työryhmän jäsenet saavat tiedot siitä, mihin potilaan hoidossa pyritään. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida potilaan oikeus osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Hoitoa koskevat päätökset pyritään tekemään potilaan läsnä ollessa, mutta aina se ei ole mahdollista (esim. tajuton potilas). Hoitosuunnitelmaan tulee myös merkitä potilaan hoitotahto ja suostumus asiakirjojen tilaamiseen tai luovuttamiseen.

Hoitotyön kirjaamisessa potilaan oikeuksien kunnioittaminen merkitsee sitä, että potilaalla on oikeus tehdä omia ratkaisuja ja olla selvillä siitä, mitä hänestä kirjoitetaan. Potilaan hoidon kannalta on tärkeää saada kirjatuksi potilaalle tärkeitä kokemuksia ja toiveita siitä, miten hän haluaa tulla hoidetuksi. Huolellisella ja selkeällä kirjaamisella voidaan taata hoitosuunnitelman toteutumisen käytännön hoitotyössä. Huolellisesti laaditut potilasasiakirjat, kuten kirjallinen hoitosuunnitelma, ovat tärkeä luottamukselliseen hoitosuhteeseen kuuluva osatekijä, ja niillä on suuri merkitys potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön oikeusturvan kannalta.

Hoitotyön prosessi on syklinen ja dynaaminen, ja se voi päättyä missä tahansa vaiheessa, jos ongelmaan löydetään ratkaisu. Prosessi ilmenee kaikissa potilaan, perheen tai yhteisön terveyteen liittyvissä ongelmissa. Hoitotyön prosessi ei kohdistu pelkästään fyysisiin tarpeisiin vastaamiseen vaan myös sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Arvioita tehdään prosessin jokaisessa vaiheessa. Arvioiva hoitotyön yhteenveto tehdään potilaan hoidosta hoitajakson päättyessä.

Hoidon tarve (SHTaL)

Hoidon tarve -vaiheessa moniammatillinen työryhmä laatii kuvauksen potilaan terveydentilaan liittyvistä, jo ilmenneistä tai mahdollisesti tulevaisuudessa esiin tulevista ongelmista, joita voidaan poistaa tai lievittää hoitotoimintojen avulla. Hoidon tarve kartoitetaan keräämällä ja analysoimalla tietoja potilaasta haastattelun, havainnoinnin ja mittauksen avulla ja erilaiset tarpeet asetetaan tärkeysjärjestykseen. Mukana toiminnassa

ovat kaikki ne terveydenhuoltoalan ammattiryhmät, joiden erikoistietämystä tarvitaan kyseisen potilaan hoidossa, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalihoitaja, jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti ja psykologi. Potilaskertomukseen kirjataan kaikki hoidon kannalta olennainen tieto, eli on tärkeää tietää myös se, mitä tietoa on kerättävä. Potilaan tietoja kerätään ja analysoidaan jatkuvasti hoitoprosessin edetessä. Tietolähteenä voidaan käyttää myös potilaan omaisia, aikaisempaa potilaskertomusta tai potilasta sairaalaan saattanutta tahoa, esimerkiksi ensihoitajia.

Potilaan ongelmat voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. **Fyysisiä ongelmia** ovat esimerkiksi kipu, hengitysvaikeus, sydänoireet, huihaus, pahoinvointi, sekavuus ja tajunnan häiriöt. **Psyykkisiä ongelmia** taas ovat esimerkiksi pelkotilat ja **sosiaalisia ongelmia** esimerkiksi yksinäisyys ja eristäytyminen. Fyysiset ongelmat ovat useimmiten helpommin tunnistettavissa kuin psyykkiset ongelmat. Havaittavat ongelmat voivat olla subjektiivisia tai objektiivisia. Subjektiivisella ongelmalla



Potilaasta saadaan tietoja seuraavista lähteistä:

- tulohaastattelu
- omaiset ja läheiset
- ensihoidon henkilöstö
- aikaisemmat potilaskertomukset
- ydintiedot
- peruselintoiminnot (esim. hengitys, tajunta, verenkierto)
- riskitiedot
- lääkehoito
- kivut
- allergiat
- lääketieteellinen diagnoosi
- tutkimukset
- toimintakyky
- apuvälineet
- mittaukset (esim. verenpaine, syke, lämpö, paino, verikokeet, happisaturaatio).

tarkoitetaan potilaan henkilökohtaista tuntemusta tai kokemusta, ja yleensä potilas kykenee kuvailemaan sen itse. Silloin, kun ongelman havaitsee hoitaja, on puolestaan kyse objektiivisesta ongelmas-
ta. Potilaan ongelmat ovat joko aktuaalisia tai po-
tentiaalisia. Aktuaaliset ongelmat ovat havaittavis-
sa ja mitattavissa, kun taas potentiaaliset ongelmat
ovat sellaisia, jotka voivat ilmetä tulevaisuudessa ja
jotka uhkaavat potilaan terveydentilaa. Potentiaali-
set ongelmat tulee tiedostaa ja niitä tulee ehkäistä.

Hoidon tavoitteet (SHTaL)

Hoidon tavoitteet asetetaan suhteessa potilaan
hoidon tarpeeseen ja siihen, minkälaisia muutok-
sia potilaan tilassa odotetaan tapahtuvan tai mitä
potilas itse odottaa. Tavoitteet asetetaan tunnistet-
tujen ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi
tietyn ajan kuluessa. On muistettava, etteivät ta-
voitteet kuvaa hoitajan toimintaa tai toimenpitei-
tä vaan niiden tulee olla **potilaskeskeisiä**. Tavoit-
teet ovat **aikaan sidoksissa** olevia, **hoitotyön kei-
noin saavutettavissa** olevia ja **dokumentoituja**.

Potilaan hoitoa varten asetetaan **päättavoite** eli
kokonaistavoite. Päättavoite ilmaisee potilaan til-
lan, johon hoidolla ja hoitotyöllä pyritään. Pääta-
voite asetetaan hoidon alkuvaiheessa, jos potilaan
tila sen sallii. Muussa tapauksessa se asetetaan sil-
loin, kun se on potilaan tilan kannalta mahdolli-
sta. **Osatavoitteita** eli välitavoitteita voi olla yksi
tai useampi. Tavoitteiden pitää olla konkreettisia,
koska silloin niitä voidaan arvioida.

Suunnitellut toiminnot (SHToL)

Hoitotyön auttamismenetelmillä tarkoitetaan kes-
keisiä hoitotyön toimintoja, joiden tarkoituksena
on auttaa potilasta edistämään terveyttään tai tu-
lemaan toimeen sairautensa ja sen aiheuttamien
rajoitusten kanssa tai auttaa ihmistä kuoleman lä-
hestyessä. Auttamismenetelmät vaihtelevat muun
muassa potilaan terveydentilan, toimintakyvyn,
arvojen, elämäntilanteen ja elinympäristön mu-
kaan. Jotkin auttamismenetelmät ovat hyvin konk-
reettisia ja helposti kirjattavissa (esim. potilaan sy-
dämensykkeen mittaaminen kerran päivässä), kun



Potilaan hoitotyön tavoitteet muotoil- laan seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Asetettava tavoite on potilaskeskeinen, eli se esitetään potilaan odotettuna käyttäytymisenä eikä hoitajan näkökulmasta.
- Tavoite kuvaa täsmällisesti sitä, miten po-
tilas selviytyy itsenäisesti tai autettuna. Ta-
voitteena voi olla myös potilaan tilan pysy-
minen ennallaan.
- Tavoite alkaa toimintaa kuvaavalla verbil-
lä, jolla ilmaistaan potilaan tekemistä tai
potilaan kognitiivista toimintaa, esimer-
kiksi ”Potilas tekee... Potilas tuntee... Poti-
las ymmärtää...”. Tavoitteen saavuttaminen
voi vaatia terveystottumusten muuttamis-
ta, apuvälineiden käytön oppimista tai uu-
den tiedon hankkimista. Esimerkki tällai-
sesta tavoitteesta on ”Potilas oppii käyttä-
mään insuliinikynää itsenäisesti”.
- Tavoitteen tulee olla realistinen ja suhtees-
sa potilaan voimavaroihin, elämäntilantee-
seen ja persoonallisuuteen, eikä se saa pe-
rustua toiveisiin. Liian matala tavoite ei
kannusta potilasta yrittämään tarpeeksi,
ja toisaalta taas epärealistinen, liian kor-
kea tavoite saattaa luoda potilaalle uskoa,
että hän pystyy enempiin kuin hänellä on
voimavaroja.
- Tavoite ilmaistaan lyhyesti esimerkiksi seu-
raavasti: ”Potilas osaa tehdä haavasidoksen
itse kotona ja saa nukutuksi ainakin kah-
deksan tuntia öisin.”

taas joitakin menetelmiä on vaikea ilmaista sanalli-
sesti (esim. potilaan kanssa keskusteleminen). Hoi-
totyön toiminnot eli hoitotyön auttamismenetel-
mät valitaan tavoitteiden mukaan niin, että ne ovat
tarkoituksenmukaisia. Hoitajan on siis huomioita-
va, mitä potilas haluaa ja miten hän haluaa toimit-
tavan. Auttamismenetelmien valinnassa otetaan
huomioon hoitotyön periaatteet ja potilaan itse-
hoitovalmiudet, esimerkiksi potilaan fyysinen tai

psyykkinen kyky hoitaa haavaansa. Myös henkilökunnan määrä ja hoitovälineiden saatavuus vaikuttavat keinojen valintaan.

Hoidon toteutus (SHToL)

Hoitotyön toteutus tarkoittaa suunniteltujen hoitotyön toimintojen toimeenpanoa ja toteutumista. Hoitotyön toiminnoissa noudatetaan hoitotyön periaatteita, kuten omatoimisuutta, ammatillisuutta, jatkuvuutta, yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Hoitohenkilöstö tekee potilaan puolesta vain sen, mihin potilas jostain syystä ei itse kykene. Kun potilasta tuetaan ja ohjataan omaa hoitoaan koskevilla ratkaisuisilla, hänen vastuunsa asiasta kasvaa. Tukemalla potilaan omia voimavaroja edistetään hänen selviytymistään mahdollisimman itsenäisesti. Hoitotoimissa korostuvat hoitohenkilöstön teoreettinen tieto ja kädentaitojen hallinta. Hoidon toteuttaja voi olla hoitaja, potilas tai hänen omaisensa, yksin tai yhdessä.

Toteutuneet hoitotyön toiminnot kirjataan potilaskertomukseen menneessä aikamuodossa, koska kirjaamishetkellä toiminto on jo tehty potilaalle. Kirjaaminen on luonteeltaan potilaslähtöistä, arvioivaa ja tarkkaa. Kirjaukseen on hyvä liittää myös potilaan omia ajatuksia hoidon toteutumisesta, esimerkiksi se, miten potilas koki annetun lääkkeen vaikutuksen.

Hoidon arviointi (SHTuL)

Hoidon tulosten arvioinnissa kuvataan, miten potilaan hoidon tarpeeseen on vastattu, saavutettiin tavoitteet, mitä muutoksia potilaan tilassa on tapahtunut ja miten potilas on itse kokenut hoitonsa. Tavoitteiden tulosten arvioinnissa mietitään, oliko tavoitteet asetettu liian korkeiksi, liian mataliksi vai juuri sopiviksi ja olivatko ne potilaan tilanteeseen sopivia ja realistisia. Tarvittaessa ryhdytään miettimään uusia hoidon tarpeita, hoidon tavoitteita ja hoitotyön toimintoja. Arviointi on uuden tarpeenmäärityksen alku, ja prosessi jatkuu, kunnes kaikki tavoitteet on saavutettu.

On myös arvioitava hoidon vaikuttavuutta potilaan tavoitteisiin ja sitä, kokeeko potilas, että hä-



Hendersonin määrittelemät 14 perustarvetta:

1. hengittää normaalisti
2. syödä ja juoda riittävästi
3. erittää normaalisti
4. liikkua ja säilyttää hyvä asento
5. nukkua ja levätä
6. valita sopivat vaatteet – pukeutua ja riisuutua
7. säilyttää ruumiinlämpö normaalina säätelämällä vaateetusta ja muuntelemalla ympäristöä
8. pitää ruumis puhtaana ja hyvin hoidettuna ja suojella ihoa
9. välttää ympäristön vaaroja ja olla vahingoittamatta toisia
10. kommunikoida muiden kanssa ilmaisemalla tunteitaan, tarpeitaan, pelkojaan ja mielipiteitään
11. harjoittaa hartautta uskontonsa mukaan
12. työskennellä tavalla, josta seuraa tyydytyksen tunne
13. leikkiä ja osallistua erilaiseen virkistystoimintaan
14. oppia ja saada selville uutta ja tyydyttää erilaista tiedonhalua, joka johtaa normaaliin kehitykseen ja terveyteen, sekä käyttää saatavilla olevia terveystalvueluita.

nen ongelmansa on poistunut tai lievittynyt. Nopeasti vaihtuvissa tilanteissa arviointi suoritetaan nopeasti ja lyhyin väliajoin. Muissa tapauksissa arvioita voidaan tehdä harvemmin, esimerkiksi viikon tai kuukauden välein. Arviointia varten hoitava henkilöstö kerää tietoa, joka liittyy potilaan tavoitteisiin, ja sitä saadaan kyselemällä, havainnoimalla ja mittaamalla. Kerättyä tietoa verrataan tavoitteisiin ja tulosten perusteella tehdään päätelmät siitä, onko potilaan tilassa tapahtunut muutoksia ja minkälaisia ne ovat.

Hoitotyön yhteenvedo tehdään silloin, kun hoitajakso on päättynyt. Yhteenvedossa arvioidaan potilaan silloista tilaa ja sitä verrataan potilaan sairaalaan tulovaiheen tilaan. Yhteenvedoon kirjataan

potilaan saama hoito ja kaikki hoidossa tapahtuneet keskeiset asiat. Hoitava henkilöstö määrittelee kokonaisvaltaisesti potilaan hoitotyön tarpeen huomioiden potilaan ja hänen perheensä näkemykset potilaan hoidon tarpeesta. Suomalaisessa hoitotyössä hoitaja kokoaa subjektiivista ja objektiivista tietoa, ja apuna käytetään FinCC-luokitusta. Muissa Euroopan maissa, kuten Isossa-Britanniasa, käytetään hoitotyön viitekehyksenä esimerkiksi Nancy Roperin elämisen mallia. Lisäksi kansainvälisesti käytössä ovat esimerkiksi Virginia Hendersonin hoitotieteellinen teoria ja Marjory Gordonin toiminnallisen terveyden malli.

➔ Tutustu lisää hoitotyön prosessiin:
www.nursingprocess.org

Liljamo, P. ym. 2012. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas.

4.4 Hoitoisuus ja hoitoisuusluokitukset

Hoitoisuus on yksi kansallisesti määritellyistä ydintiedoista, ja se määritellään eri potilasryhmien tarvitseman hoidon määrän ja vaativuuden perusteella laadun arvioimiseksi, henkilöstön mitoittamiseksi tai hoitotyön kustannusten selvittämiseksi. Potilaan hoitoisuus arvioidaan hoitoisuusluokituksen avulla. **Hoitoisuusluokituksessa** potilaat ryhmitellään luokkiin hoidon tarpeen ja sitä vastaavien hoitotyön toimintojen mukaan. Hoitoisuus ilmaistaan numeerisesti ja sanallisesti, ja sen arviointi on osa hoitoprosessia. Potilaiden hoitoisuus voi vaihdella erittäin paljon jopa saman diagnoosin yhteydessä, minkä vuoksi tarvitaan tietojärjestelmä, jolla kyetään erottelamaan potilaat hoitoisuutensa perusteella eri luokkiin. Potilaskertomusjärjestelmissä käytetään erilaisia hoitoisuuden luokitusjärjestelmiä. Terveystieteiden tutkimuskeskuksessa on kehitetty erilaisia hoitoisuusmittareita, esimerkiksi NETA-, Rai- ja OPC-mittari, hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA, PAONCIL-vertailumittari, poliklinikoiden hoitoisuusluokitusmittari POLIHOIQ ja psykiatrisen hoitotyön PPC-mittari.

OPC-hoitoisuusmittari perustuu alun perin kanadalaiseen HS-SG-hoitoisuusluokitukseen. OPC-

hoitoisuusmittaria on kehitetty Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa. Hoitoisuusluokitus edellyttää hoitotyöntekijöiltä luotettavaa systemaattista kirjaamista. Hoitoisuusluokitusmittarit ovat tulossa osaksi jokapäiväistä potilaan hoidon kirjaamis- ja arviointikäytäntöä.

Hoitotyön kirjaaminen perustuu todennettuun tietoon eli näyttöön. **Näyttöön perustuvassa hoitotyössä** hoitaja tekee kliinisen päätöksen, joka perustuu tutkittuun tietoon, hyväksi havaittuihin toimintakäytäntöihin, potilaan kokemuksiin ja hoitotyön resursseihin. Näyttö (evidence) tarkoittaa todeksi osoitettua, luotettavaa ja perusteltavissa olevaa. Päätöksentekoa edeltää perehtyminen tutkimuksista saatavaan tietoon, potilaan näkemykseen, hoitajan kokemuksiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Käytännössä hoitajalla on ongelmanratkaisutilanne, jonka selvittämiseen tarvitaan runsaasti tietoa. Hoitaja yhdistää saatua ja olemassa olevaa tietoa, kun hän harkitsee päätöstä ja valitsee sopivia hoitomenetelmiä. Harkinta on tiedon tunnistamista, arviointia ja tiivistämistä. Tiedon arvioimisessa punnitaan sen toteutettavuutta, tarkoituksenmukaisuutta, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta hoidon lopputulokseen. Tutkimustieto on hoitajalle ja potilaalle käyttökelpoisinta silloin, kun se on valmiiksi luotettavaksi arvioitua ja useista eri tutkimuksista tiivistettyä. Hoitaja tarvitsee tietoa potilaan yksilöllisestä tilanteesta ja toiveista sekä hoitoon liittyvistä oloista ja palvelujärjestelmän mahdollisuuksista.

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa, terveyden edistämisessä, terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Yksittäisessä hoitotilanteessa hoitajalla on käytössään helposti hyödynnettävää tutkittua tietoa, potilaalta saatua tietoa, toimintaympäristöön liittyvää tietoa ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Niiden avulla hän suunnittelee ja toteuttaa omalla asiantuntemuksellaan potilaalle yksilöllisen hoidon yhdessä potilaan ja hoitoon osallistuvan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen vaikuttaviksi tunnistettujen menetelmien ja hoitokäytäntöjen avulla.

Näyttöön perustuvassa toiminnassa hoitajan oma toiminta pystytään perustelemaan. Kun toiminta perustuu näyttöön, käytössä on tietoa, joka osoittaa toiminnan oikeaksi, varmaksi ja yleistettäväksi, jolloin toiminta on mahdollisimman totuudenmukaista ja siihen voi luottaa. Tällaisen toiminnan tavoitteena on antaa potilaalle ja hänen läheisilleen parasta mahdollista hoitoa. **Potilaalta saatu tieto** on tietoa hänen elämäntilanteestaan, terveydenhoidostaan ja sairaudestaan. Hoitaja saa tietoa potilaalta ja hänen läheisiltään sekä potilaalle tehdyistä tutkimuksista. Potilaan kokemukset ovat keskeinen osa näyttöön perustuvaa hoitotyötä, koska hoitotyön tulee tukea potilaan ja omaisen voimavaroja ja jaksamista. **Toimintaympäristöstä saatavalla tiedolla** tarkoitetaan mahdollisuuksia, jotka palvelujärjestelmä tarjoaa potilaan hoitoon. Hoitajalla tulee olla tietoa arvoista, jotka ohjaavat toimintayksikön toimintaa, ja hoitoon käytettävissä olevista voimavaroista, kuten käytettävissä olevasta henkilöstöstä ja hoitovälineistä.

Esimerkkejä tiedonlähteistä:

Suomalaiset suositukset
Hoitotyön Tutkimussäätiö: www.hotus.fi
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim:
www.kaypahoito.fi
Terveysportti: ajantasaiset hoitosuosituks
www.terveysportti.fi
Artikkeliviitetietokannat
MEDLINE: www.ncbi.nlm.nih.gov
CINAHL: <http://ebscohost.com/cinahl>
Tietokannat
COCHRANE-kirjasto: kansainvälinen
moniammatillinen tietokanta www.cochrane.org
Hoitotieteelliset ammattilehdet
Tutkiva hoitotyö
Hoitotiede

Tutkimuksista saatu tieto on parhaiten hyödynnettävissä käyttöön silloin, kun se on jo valmiiksi arvioitu ja tiivistetty käytäntöä ohjaavaan muotoon, esimerkiksi hyviksi käytänteiksi ja hoitosuosituksiksi tai luotettavien ulkopuolisten asiantuntijoiden yksimieliseksi näkemykseksi. Jotta hoitaja voisi käyttää ja soveltaa tutkimustietoa, hänen tulee arvostaa tutkittua tietoa ja pitää sitä käyttökelpoisena ja kehitettävänä. Tulevien sairaanhoi-

tajien tulisi koulutuksensa aikana saada valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotoimintaan. Laurin ja Salanterän (2002) tutkimustulosten pohjalta hoitotyön päätöksenteko tapahtuu neljän päätöksentekomallin – analyyttis-systemaattisen, analyyttis-intuiitiivisen, intuitiivis-analyyttisen ja intuitiivis-tulkitsevan mallin – mukaan. Näyttöön perustuvassa hoitotyön päätöksenteossa korostuu hoitajan kyky reflektoida osaamistaan käytännön tilanteissa teoreettisen tiedon avulla. Siihen, miten hoitaja yhdistää tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon hoitotilanteissa, vaikuttaa hänen oma tietojenkäsittelytaitonsa.

Hoitajien väliset keskustelut lisäävät työyhteisön osaamista ja luovat haasteita etsiä oman osaamisalueen perusteita päätöksien tueksi. Ne ovat välttämättömiä tiedon soveltamisen ja käyttööntottamisen näkökulmasta. Keskustelut ovat myös erittäin hyvä tapa siirtää kokeneiden hoitajien tietämystä yksikön yhteiseen tietopäaomaan. Hoitotyön toimintaa ohjaavat systemaattisesti kehitetyt **Käypä hoito -suositukset**, jotka auttavat hoitajia ja potilaita tekemään päätöksiä parhaan mahdollisen avun ja hoidon antamiseksi. Käypä hoito -suositukset ovat terveydenhuollon asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemlia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Suosituksissa kuvataan esimerkiksi terveysongelmien ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon seurannan ja kuntoutuksen erilaisia vaihtoehtoja ja niiden käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta.

4.5 Hoitotyön raportointi

Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisen keskeisenä hoitotyön keinona on raportointi. Raportointi toteutetaan hoitotyössä potilaslähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti. Raportoinnilla turvataan potilaan hoidon jatkuvuus, kun hoitohenkilökunnan työvuorot vaihtuvat tai potilas siirtyy hoitoyksiköstä toiseen. Raportin pohjana ovat potilasasiakirjat ja hoitosuunnitelma.

Kirjallinen eli hiljainen raportointi on kirjallista tiedonvälitystä. Kun hoitotyöntekijät tulevat

työvuoroonsa, he lukevat heidän vastuullaan olevien potilaiden tiedot sähköisestä potilaskertomuksesta. Tällöin korostuu erityisesti hoitotyöntekijöiden tarkka, huolellinen ja vastuullinen kirjaaminen. Kirjaamisen tulee olla selkeää ja loogista. Hoitaja voi tarvittaessa täydentää kirjallista raporttia suullisella raportilla edellisen työvuoron hoitajalta ennen tämän työvuoron päättymistä, jos esimerkiksi jonkun potilaan vointi tai hoito vaatii lisätietoa. Hoitajalla on myös eettinen velvollisuus täsmentää ja täydentää kirjallisessa raportoinnissa annettuja tietoja, jotta potilaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito turvataan. Kirjallisen raportoinnin on todettu säästävän hoitajien aikaa ja tehostavan potilastietojen laadukasta kirjaamista.

Hoitotyössä pidetään eri yksiköissä tarpeen mukaan **suullisia tiedotustilaisuuksia eli raportteja** rauhallisessa suljetussa tilassa. Raportteja ovat muun muassa aamuraportti, lääkärinkierto-, päivä-, ilta- ja yöraportti. Usein hoitotyöntekijä tiedottaa suullisella raportilla potilaiden hoitoon ja vointiin liittyviä asioita seuraavalle työvuorolle ennen oman työvuoronsa päättymistä ja samalla siirtää vastuun potilaiden hoidosta seuraavan työvuoron hoitajille. Raportin vastaanottavat hoitajat tekevät muistiinpanoja niistä tiedoista, joita he tarvitsevat potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi huoneen numero, potilaan vuodepaikka, nimi, ikä, diagnoosi, perussairaudet, mahdolliset allergiat, lääkärin määräykset, tehdyt ja suunnitteilla olevat hoitotoimenpiteet (suunnitteilla oleva leikkaus), potilaan vointi, huomioon otettavat tai hoidossa tarkkailtavat asiat (esim. allergiat, ruokavalio ja psyykkinen tasapaino) ja lääkehoito. Suullinen raportointi vie paljon aikaa, mutta se myös mahdollistaa keskustelun potilaan hoidosta. Lisäksi hoitotyöntekijöillä on suullisessa raportointitilaisuudessa mahdollisuus kollegiaaliseen keskusteluun potilaan hoidosta, hoitoprosessista, hoitotoimenpiteistä, hoito-ongelmista, lääkähoidosta, moniammatillisesta yhteistyöstä, potilaan ohjauksesta ja läheisten ja perheen tukemisesta. Raportointitilaisuuksissa voidaan myös tiedottaa yleisistä asioista ja opiskelijaohjauksesta, ja sillä on niin ikään sosiaalinen merkitys työyhteisössä. Raportoinnin yhteydessä kokeneempi

hoitaja voi myös opettaa uudelle työntekijälle potilaan hoitoon ja osaston käytäntöön liittyviä asioita.

Potilaanvierusraportissa raportointi tapahtuu potilaan vierellä, jolloin raportin vastaanottajat saavat välittömän kuvan potilaan voinnista. Tämä raportointitapa on hyvin potilaskeskeinen, ja sen yhteydessä voidaan kysyä potilaan vointia ja tuntemuksia. Potilaanvierusraporttia varten pyydetään potilaan suostumus ja tilanteessa käytetään sellaista kieltä, jota myös potilas ymmärtää. Tämän tyyppinen raportti mahdollistaa hyvin potilaan osallistumisen hoitoon ja päätöksentekoon, ja sen yhteydessä hänelle voidaan antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Suullisen tai kirjallisen raportin jälkeen työvuoroon tulleet hoitajat käyvät yleensä tapaamassa potilaita, jotta he saavat potilaskeskeisen ja kokonaisvaltaisen kuvan näiden voinnista ja hoidosta. Eryteisesti lapsi- tai vanhuspotilaat, huonokuntoiset, vakavasti perussairaat, kehitysvammaiset ja tajuttomat potilaat vaativat ajantasaista, tarkkaa ja vastuullista kirjaamista ja raportointia. Raportointitilanteessa raporttia antavalla hoitajalla ja raporttia vastaanottavalla hoitajalla on suuri vastuu, koska raportoinnin yhteydessä myös vastuu potilaan hoidosta siirtyy. Kirjaamisessa käytetään erilaisia lyhenteitä ja merkintöjä. Merkinnot voivat vaihdella hoitoyksiköittäin, joten hoitajan tulee aina varmistaa kirjaamisen merkinnot siitä hoitoyksiköstä, jossa hän työskentelee.

➔ THL. Kanta 2014. Valtakunnallinen potilastiedon arkisto. Saatavilla osoitteessa www.kanta.fi.

Lehtovirta, J. & Vuokko, R. (toim.) Terveystieteiden rakenteiden kirjaamisen opas. Osa 1. THL 1/2014.

Kortteisto, T. 2014. Neuvova potilaskertomus. Käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon. Väitöskirja.

Valta, M. 2013. Sähköisen potilastietojärjestelmän sosiatekninen käyttöönotto. Seitsemän vuoden seurantatutkimus odotuksista omaksumiseen. Väitöskirja.

Vuokko, R., Suhonen, J., Hyppönen, K. & Porrasmaa, J. 2014. Potilastiedon suostumuksenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan. THL.

5

Terveyskäyttäytyminen

Tässä luvussa

- Terveyteen vaikuttavat elintavat
- Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
- Sitoutuminen elintapamuutoksiin
- Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
- Terveydenhuoltojärjestelmän porrastus



5.1 Terveysteen vaikuttavat elintavat

Suomalaisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt kahdeksan vuoden verran viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Monet sairaudet ovat vähentyneet. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, hammassairauksien, tartuntatautien ja joidenkin syöpäsairauksien esiintyvyys on pienentynyt. Viimeisten vuosikymmenten aikana myös itsemurhien määrä on vähentynyt. Suomalaisten terveydessä on kuitenkin monessa suhteessa vielä parannettavaa, ja terveyttä edistävä neuvonta on yksi keskeinen tehtävä kaikilla terveydenhuollossa työskentelevillä. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen kuuluu olennaisena osana terveydenhuoltohenkilöstön työhön. Tärkeää on ottaa terveet elämäntavat puheeksi potilaan kanssa jo pelkästään siksi, että sairastuessaan ihminen usein kiinnostuu terveydestä ja sen edistämisestä.

 Terveysteen edistämisen tukeminen. Laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto. www.stm.fi

Vuonna 2017 suomalaisten miesten ennakoitu elinajanodote oli 78,7 vuotta ja naisten 84,2 vuotta. Miesten ja naisten elinajan ero (5,5 vuotta) on Suomessa kansainvälisesti katsottuna suuri (Suomi on sijalla 21, kun se vuonna 2002 oli sijalla 38). Väestöryhmäerot ovat ilmeisiä myös monissa sairauksien riskitekijöissä. Esimerkiksi päivittäin tupakointia on ylimmän koulutusryhmän miehistä 18 prosenttia mutta alimman koulutusryhmän miehistä peräti 38 prosenttia. Tupakointi ja alkoholin käyttö ovatkin eniten terveyseroja lisääviä tekijöitä Suomessa. Myös epäterveellinen ruokavalio, lihavuus ja vähäinen liikunta vaikuttavat terveyseroihin.

Väestöryhmien välisten terveyserojen syyt ovat monitasoisia, ja ne kytkeytyvät ammatti- ja koulutusryhmien erilaisiin elinoloihin ja työoloihin, erillaiseen fyysiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen ja sukupolvienkin yli ulottuviin kulttuurisidonnaisiin käyttäytymismalleihin. Terveystien



Suomalaisten terveyskäyttäytymiseen liittyviä painopistealueita:

- Noin puolet 30-vuotiaista suomalaisista sairastaa jotain pitkäaikaissairautta. Pitkäaikaissairaudet voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja ennenaikaisia kuolemia.
- Yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeiden syyt ovat mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä hermoston ja verenkiertoelinten sairaudet. Mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleisin työkyvyttömyyden syy vuodesta 2000 lähtien.
- Väestö vanhenee, ja iäkkäiden kaatumistapaturmia sattuu paljon.
- Muistisairauksien määrä on lisääntynyt.
- Diabetes, astma ja allergiat ovat yleistyneet.
- Lisääntynyt päihteiden käyttö uhkaa suomalaisten terveyttä, sillä se aiheuttaa lukuisia uhkia kansalaisten terveydelle.
- Naisten tupakointi on lisääntynyt, minkä seurauksena tupakointiin liittyvät syöpäsairaudet ovat lisääntyneet naisten keskuudessa.
- Joidenkin syöpien, esimerkiksi mahasyöpien, määrä on laskenut, mutta haimasyöpään sairastuneiden määrä on noussut.
- Eri väestöryhmien välillä on Suomessa suuria terveyseroja, jotka johtuvat sosioekonomisista tekijöistä. Useimmat pitkäaikaissairaudet ovat yleisempiä matalassa sosioekonomisessa asemassa olevilla.
- Koulutustasolla on vieläkin vaikutusta elinajanodotteeseen, vaikka ero on hieman kaventunut tällä vuosikymmenellä. Korkea-asteen koulutuksen saaneet miehet elävät keskimäärin 7 ja naiset keskimäärin 5 vuotta pidempään kuin enintään perusasteen koulutuksen saaneet.
- Fyysisen aktiivisuuden tiedetään vähentävän riskiä sairastua useisiin elintapasairauksiin. Liikunta myös parantaa elämänlaatua, koulumenestystä ja vanhusten kotona selviytymistä.

kaventamiseen voidaan vaikuttaa yhteiskuntapolitiikan toimin. Esimerkiksi alkoholin käyttöä ja sen mukanaan tuomia haittoja on mahdollista ohjata politiikan keinoin esimerkiksi hinta- ja veropolitiikalla ja valvontaa tehostamalla sekä kehittämällä nuorten vapaa-ajan toimintaa. Myös yleinen terveydenhuoltojärjestelmä ja työterveyshuolto voivat ehkäistä terveyserojen syntyä. Terveyserojen kaventamiseen tarvitaan monien tahojen pitkäjänteistä yhteistyötä. Hoitajien merkitys väestön terveydentilan edistäjinä on tärkeä.

➔ Arvioita siitä, kuinka suuri osa tärkeistä kansanterveysongelmista poistuisi, jos ongelman yleisyys väestössä olisi sama kuin korkeasti koulutetuilla: www.thl.fi/pitkääikaissairastavuus

Viime vuosina on lasten ja nuorten elintavoissa tapahtunut myönteistä kehitystä, sillä esimerkiksi nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi on vähentynyt. Kuitenkin ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on edelleen suuri. Huomattava osa lapsista ja nuorista nukkuu arkinen liian vähän. Myös vähän liikkuvien määrä on myönteisestä kehityksestä huolimatta korkea.

➔ Vuonna 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset (lapset, nuoret ja perheet) löydät seuraavilta sivuilta: <https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia>
Tilastotietoa muun muassa terveyden indikaattoreista: <https://findikaattori.fi>

Ravitsemus

Ravitsemustottumuksilla tarkoitetaan tapoja valita ja kuluttaa erilaisia ruoka-aineita. Ravitsemustottumusten selvittäminen on yksi hoitajien perustehtävistä. Potilaiden ravitsemustottumukset saattavat poiketa runsaasti ravitsemussuosituksista. Poikkeavat ravitsemustottumukset saattavat olla syy sairauksiin tai seurausta erilaisista sairauksista, kuten nielemisvaikeuksista. Ravitsemusneuvonta ja -ohjaus edellyttävät yksilöllisten ravitsemustottumusten selvittämistä. Ohjaus ja neuvonta on tarkoituksenmukaista kohdentaa niille poti-

laan ravitsemuksen osa-alueille, jotka poikkeavat ravitsemussuosituksista.

Ravitsemustottumuksiin liittyviä osa-alueita ovat muun muassa päivittäisen ruokavalion koostumus ja monipuolisuus, ruokailuajat ja niiden säännöllisyys, ruokaan ja ruokailuun liittyvät tottumukset, käytössä olevat ruokavaliot, ruoka-aineallergiat ja painonhallintatavat, kuten laihduttaminen, ja ravintoaineiden saanti.

Ravitsemussuositusten tavoitteisiin päästään oikeanlaisilla ruokavalinnoilla. Suositukset tavoittelevat keskeisten kansantautien riskien pienentämistä ja takaavat elimistölle välttämättömien ravintoaineiden saannin. Jokapäiväiset valinnat ratkaisevat ruokavalion terveellisyyden. Ruoilla, joita käytetään harvoin, on vähän merkitystä. Hyvä ruoka on maukasta ja monipuolista, ja sen vitamiini- ja kivennäisainetiheys on suuri. Ruokavalion tulisi sisältää täysjyvävalmisteita, kasviksia, hedelmiä, marjoja, perunaa, rasvattomia maitovalmisteita, kalaa, vähärasvaista lihaa, kananmunia, kasviöljyä ja kasviöljyä sisältäviä levitteitä.

➔ Ravitsemussuosituksia hoitotyöhön:
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi
www.diabetes.fi
www.rty.fi
www.sydanliitto.fi

Aikuisen ihmisen **energiantarve** tarkoittaa energiamäärää, joka pitää kehon painon, koostumuksen ja aktiivisuuden sellaisena, että se pitää yllä hyvää terveyttä. Ihminen tarvitsee energiaa perusaineenvaihduntaan, lämmöntuottoon ja liikumiseen. Perusaineenvaihdunnalla tarkoitetaan välttämättömien elintoimintojen vaatimaa energiaa. Tähän kuluvaan energiamäärään vaikuttavat muun muassa ihmisen lihasmassa, ikä, sukupuoli, perintötekijät, hormonit ja fyysinen kunto. Tarvittava energiamäärä on siis varsin yksilöllinen. Ihmisen energiatarvetta ja -saantia ja ravinnon tuottamaa energiaa mitataan jouleina (J). Joulen rinnalla käytetään edelleen kilokaloria (kcal). Kilokalorit muutetaan kilojouleiksi kertomalla ne luvulla 4,2. Jos energiansaanti ja -tarve ovat epätasapainossa, seurauksena on joko lihominen tai

laihtuminen. Laihtuminen voi johtaa alipainoon ja jopa kataboliaan, jossa keho käyttää kudosten proteiineja energianlähteenä (ks. tarkemmin luvusta 11).

Liikunta

Liikuntatottumusten selvittäminen on terveydenhuoltohenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä väestön terveyden edistämiseksi. Uusimpien tutkimusten mukaan (Liitu 2016 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018) suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa jotain liikuntaa, mutta riittävästi liikkuvia on vain kolmasosa lapsista ja nuorista. Suosituimpia liikuntalajeja ovat jalkapallo, juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu ja salibandy. Aktiivisemmin liikkuvat 10–14-vuotiaat. Lähes puolet lapsista ja nuorista on mukana urheiluseurojen toiminnassa. Suosituimmat urheiluseuroissa harrastettavat lajit ovat jalkapallon jälkeen voimistelu, jääkiekko, salibandy ja yleisurheilu. Lasten ja nuorten osalta liikunnan harrastaminen ei kerro koko totuutta lasten terveyttä edistävästä liikkumisesta. Lasten tulee liikkua joka päivä kaksi tuntia. Liikuntaharrastus on osa lasten liikumiskokonaisuutta, eikä se yksistään riitä täyttämään lapsen liikuntasuosituksen. Aikuisväestön (19–65-vuotiaat) keskuudessa suosituin liikuntamuoto on kävely ja seuraavaksi suosituimpia ovat pyöräily, hiihto, uinti, kuntosaliharjoittelu, juoksu, sauvakävely ja salibandy. Talviurheilulajit ovat aina suosittuja sekä aikuisten että lasten keskuudessa. Myös hyötyliikuntaa ja vesiliikuntaa harrastetaan paljon.

Liitu 2016 -tutkimus osoitti, että kolmasosa (34 %) lapsista ja nuorista saavutti liikuntasuosituksen eli liikkui reippaasti tai rasittavasti vähintään 60 minuuttia jokaisena mittauspäivänä. Nuoremmat ikäryhmät saavuttivat suosituksen useammin kuin vanhemmat ikäryhmät, ja kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä pojat saavuttivat suosituksen useammin kuin tytöt. Reippaan ja rasittavan liikumisen määrä vähentyi nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Pojat liikkuiivat reippaasti ja rasittavasti keskimäärin enemmän kuin tytöt. Tytöt puolestaan liikkuiivat kevyesti jonkin verran

poikia enemmän. Tutkimuksessa oli tarkastelussa 9–15-vuotiaat lapset ja nuoret.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemasta tutkimusraportista Husu ym. (2018) käy ilmi, että vain joka kymmenes nuorimies harrastaa kestävyysliikuntaa suositusten mukaisesti. Parhaiten kestävyysliikuntasuosituksia noudattavat 60–69-vuotiaat. Tämän tutkimuksen mukaan 60-vuotiaiden parempi menestys kestävyysliikuntasuosituksiin yltämisessä johtuu todennäköisesti hyötyliikunnasta. Kaikki liikunta on hyvästä, mutta reipaskaan suositusten mukainen liikunta ei riitä, jos muuten on hyvin paljon paikallaan. Kestävyysliikuntasuosituksen mukaan aikuisen pitäisi liikkua viikoittain vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia reippaasti tai 1 tunti 15 minuuttia rasittavalla tasolla parantaakseen kestävyyskuntoa. Aikuisista 40–49-vuotiaista naisista vain 20 prosenttia liikkuu kestävyys-suositusten mukaisesti.

Suomalaiset aikuiset viettävät valtaosan valveil-laoloajastaan paikallaan, istuen tai makuulla, ja liikumiseen käytetään alle tunti päivässä. Terveyskuntotestien tulokset ovat keskimäärin parempia miehillä kuin naisilla, samoin nuorilla ikäluokilla verrattuna vanhempiin. Aikuisten liikkumisessa ja paikallaanoloissa ei näytä tutkimusten mukaan tapahtuneen kovin suuria muutoksia kuuden viime vuoden aikana. Lapset ja nuoret puolestaan ovat paikallaan istuen tai makuulla keskimäärin puolet valveillaoloajastaan ja liikkuvat vähintään reippaasti vajaan 2 tuntia päivässä. Paikallaanolon aika lisääntyy iän myötä, ja arkipäivinä liikutaan enemmän kuin viikonloppuisin. Vähän liikkuvilla lapsilla merkittävä osa liikkumisesta arkisin tapahtuu koulupäivän aikana. (Liitu 2016).

➔ Husu, P., Sievänen, H., Tokola, K., Suni, J., Vähä-Ypyä, H., Mänttari, A. & Vasankari, T. 2018. Suomalaisen objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018:30.

LIITU 2016: Kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi. Terveiden ylläpitämiseksi aikuisten tulisi suositusten mukaan harjoittaa perus- tai arkiliikuntaa joka päivä ja täydentää sitä muutaman kerran viikossa tapahtuvalla kuormittavammalla kuntoliikunnalla. Liikuntaa tulisi harras-

taa vähintään 30 minuuttia kerrallaan ja vähintään 3 kertaa viikossa. Lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia joka päivä, ja liikunnan tulisi sisältää myös vauhdikkaita osia. Saatavilla osoitteesta www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet-2/2016-tiedotteet/liitu-2016-kolmasosa-suomalaislapsista-ja-nuorista-liikkuu-riittavasti liikuterveemmäksi.com

Valtion liikuntaneuvosto: www.liikuntaneuvosto.fi/

Ikääntyneiden ohjatun terveystoiminnan laatusuosittukset: www.stm.fi

Tietoa terveystoiminnasta: www.ukkinstituutti.fi

Liikuntapiirakka: www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka

TULE-sairauksien riskitekijät ja niiden ehkäisy: www.suomentule.fi/toiminta/tule-kuntoon-seniori-luennot/luentomateriaali/tuki-ja-liikuntaelinongelmat-ja-sairaudet/

Päihteiden käyttö

Päihteisiin kuuluvat alkoholi, tupakka, huumausaineet ja väärin käytetyt lääkkeet. Päihteiden käyttötottumusten selvittäminen on hoitajan perustettava. Päihteiden käyttö on merkittävä terveydentilaan vaikuttava tekijä. **Tupakka** on voimakasta riippuvuutta aiheuttava laillinen päihde. Tupakan myynti ja käyttö on sallittu, joskin monin rajoituksin, sillä sen käytölle on asetettu ikäraja, sen mainonta on kielletty ja tupakkatuotteisiin on liitetty pakolliset terveystarvikkeet. Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyynnissä on kielletty. Tupakka luokitellaan keskushermostoa stimuloivaksi ja rauhoittavaksi aineeksi. Tupakkariippuvuus on moniulotteinen riippuvuusoireyhtymä, jossa kemiallinen nikotiiniriippuvuus yhdistyy psyykkiseen ja sosiaaliseen riippuvuuteen sekä tapariippuvuuteen.

Tupakkariippuvuuteen on tarjolla vieroitusta eri menetelmin, nikotiinikorvaushoitoa ja muuta lääkehoitoa. Terveyskeskukset on veloitettu tarjoamaan alueillaan tupakkariippuvuuden hoitopalveluja. Tupakointi aiheuttaa Suomessa 5 000–6 000 kuolemantapausta vuosittain, ja se on maailmanlaajuisesti suurin estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja. Lisäksi se aiheuttaa suuren määrän kroonisia sairauksia ja työkyvyttömyyttä.

Tupakointitottumuksia selvitettäessä asiallinen tieto tupakoinnin haitoista ja ohjaus erilaisten tupakoinnin lopettamista tukevien hoitomuotojen piiriin on hoitajan perustehtävä inhimillisen kärsimyksen ja kansantaloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Valtaosa tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin, ja halun vahvistaminen on osa hoitajan päivittäistä työtä. Käypä hoito -suositukseen Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus on koottu valtakunnalliset tupakoinnin lopettamisen käytännöt. Valtaosa lopettamisista tapahtuu omin neuvoin, mutta myös vieroitusryhmiä, korvaushoitoa ja lääkehoitoa käytetään.

 Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus: www.kaypahoito.fi

Alkoholijuomien käyttö on maailmanlaajuisesti erittäin yleistä, ja sitä tavataan kaikenlaisissa kulttuureissa. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta käyttää alkoholia nautintoaineena ja päihteenä. Myönteiset vaikutukset saavutetaan muutamalla alkoholiannoksella, eikä kohtuukäytöstä ole yleensä haittaa. Alkoholin säännöllinen käyttö kuitenkin lisää terveysriskejä. Riskit syntyvät lähinnä hitaista ja iän myötä lisääntyvistä muutoksista elimistössä. Alkoholinkäyttöä selvitettäessä puhutaan annoksista. Suomessa alkoholiannoksella tarkoitetaan

Taulukko 5.1 Annosesimerkkejä

0,5 l:n pullo tai tuoppi keskiolettua tai siideriä	1,5 annosta
0,75 l:n pullo mietoa viiniä	6 annosta
3 l:n hanapakkauksen mietoa viiniä	24 annosta
0,5 l:n pullo väkevää viinaa	13 annosta

Taulukko 5.2 Alkoholin käytön riskirajat annosten mukaan

	Kertakäytön enimmäismäärä	Viikkoannosten enimmäismäärä
Naiset	5	16
Miehet	7	24
Yli 65-vuotiaat	2	7

määrää, joka sisältää 12 grammaa 100-prosenttista alkoholia. Yksi annos on esimerkiksi 12 cl viiniä (viinilasi), keskiolut- tai siideripullo (0,33 l), 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa.

Kun viikkoannos on naisilla yli 16 ja miehillä yli 24 annosta, alkoholisairauksien riski on tutkimusten mukaan varmasti suurentunut. Täysin turvallista alkoholin käytön rajaa ei kuitenkaan voida määrittellä, vaan sairastumisriski voi suurentua pienemmistäkin viikkoannosmääristä. Alkoholi on Suomessa työikäisen väestön yleisin kuolinsyy. Suurin osa väestöstä käyttää alkoholia kohtuullisesti, mutta suurkuluttajia on paljon, 300 000–500 000, ja suurin osa heistä on mukana työelämässä.

Terveydenhuollon työntekijät ovat keskeisiä toimijoita alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. Alkoholin käytön selvittäminen on usein vaikeaa. Ihmiset eivät yleensä osaa arvioida omaa alkoholin kulutustaan realistisesti, vaan he arvioivat sen usein liian vähäiseksi. Hoitajan osaamisella ja omilla asenteilla on tärkeä merkitys alkoholin käytön selvittämisessä ja asian puheeksi ottamisessa. Potilaat eivät juuri koskaan koe alkoholin käytöstä keskustelemista hankalaksi, mutta osa hoitajista ei uskalla, kehtaa tai osaa ottaa asiaa puheeksi. Usein alkoholista kysytään vain niiltä, joilla jo selvästi on alkoholin käyttöön liittyviä näkyviä ongelmia. Alkoholin käyttöä olisi kartoitettava paljon useammin, sillä lähes jokainen suomalainen on potentiaalinen riskikäyttäjä ainakin jossain vaiheessa elämäänsä.

Alkoholin käytön selvittämiseen on kehitetty monenlaisia apuvälineitä. Riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on tunnetuin, eniten tutkittu ja eniten käytössä oleva seulontaväline. Se on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä testi, jonka kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, tavallisesti käytettyyn alkoholimäärään, humalajuomiseen ja alkoholin haittoihin. Se on nopea ja luotettava mittari, ja siitä saatavan henkilökohtaisen palautteen voi antaa potilaalle heti. Juomisen riskejä arvioidaan AUDIT-testin palautteessa pisteinä. Testin tavoitteena on löytää ihmiset, joiden juomisen aiheuttama riski sairastua sisäelinsairauksiin

on suurentunut. AUDIT-C käsittää AUDIT-testin kolme ensimmäistä kysymystä, ja se on todettu nopeaksi ja käteväksi tavaksi selvittää riskijuomista.

Tietoa päihteistä ja päihdetesteistä:

www.paihdelinkki.fi

Aikuisten päihdetesti: www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa-paihteista/Pages/aikuisten-paihteidenkayttotesti.aspx

Toinen apuväline alkoholin käytön selvittämiseen on niin kutsuttu Apukortti, joka helpottaa hoitajaa muistamaan alkoholiin liittyviä keskustelunaiheita. Apukortti on kaksipuolinen ja laminoitu hoitajan apuväline, jossa selvitetään, mikä on alkoholiannos, ja kerrotaan AUDIT-testin pisteiden rajat, alkoholin kerta- ja viikkokulutuksen rajat naisilla, miehillä ja iäkkäillä sekä liiallisen käytön aiheuttamat terveys- ja sosiaaliset haitat. Kortissa luetaan myös alkoholin käytön vähentämisen hyötyjä ja haittoja. Usein potilaan tietämys alkoholiannosta, riskirajoista ja käytön vaikutuksista eri sairauksiin on vähäistä. Alkoholin käytön puheeksi ottaminen alkaa alkoholin käytön kartoituksella. Parhaiten se selviää kysymällä tai käyttämällä AUDIT-testiä. Kartoitus tulee tehdä neutraalisessa ilmapiirissä, ja potilaalla on lupa kieltäytyä siitä. Keskustelussa tulee luoda avoin ilmapiiri, ja on tärkeää tuoda esille, ettei alkoholin käytöstä saatu tietoa vaikuta potilaan hoitoon.



Alkoholin käytöstä on erittäin tärkeä kysyä

- potilassuhteen alussa
- terveysneuvonnan yhteydessä
- raskauden alkuvaiheessa
- masennus-, erektiohäiriö-, verenpaine- ja uniongelmapotilailta
- terveystarkastusten yhteydessä
- sairauslomien hakemisen yhteydessä
- tapaturmien yhteydessä
- reseptien uusimisen yhteydessä.

Alkoholin ongelmakäyttö voi vaurioittaa elimistöä pahoin, ja siihen liittyy useita sairauksia ja terveysongelmia. Runsaan alkoholinkäytön lopettamisesta tai vähentämisestä voi seurata juoppohulluus (delirium tremens). Se on oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluvat lihasvapina, motorinen levottomuus, kouristukset, autonomisen hermoston voimakas ärsytystila, keskittymis-, ajatus-, havainto-, muisti- ja orientaatiohäiriöt, uni- ja valverytmin häiriöt ja pelottavat ja ahdistavat näkö- ja kuuloharhat. Pahimmillaan juoppohulluus johtaa kuolemaan.

🔄 Käypä hoito -suosituksessa Alkoholiongelmaisen hoito kerrotaan muun muassa alkoholiriippuvuuden lääkehoidosta: www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028

Yleisesti ottaen **huumausaineiden** käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat pysyneet viime vuosina melko vakaalla tasolla. Viimeisimmän väestökyselyn (2014) mukaan kannabista joskus elämänsä aikana on kokeillut 19 prosenttia 15–69-vuotiaista suomalaisista. Kokeilut painottuvat pääosin nuorempiin ikäluokkiin: 14 prosenttia 15–34-vuotiaista on viimeisen 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt kannabista. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2015) mukaan laittomia huumeita on ainakin kerran elämässään kokeillut kahdeksan prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista, 12 prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja 22 prosenttia ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.

🔄 Varjonen, V. Huumetilanne Suomessa 2014. THL. Saatavilla osoitteesta www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAP01_2015_web%20%281%29.pdf.
Valtakunnallinen kouluterveyskysely (2015): thl.fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet

Kannabis luokitellaan huumausaineeksi, koska sen käyttö jättää jälkensä elimistöön ja se voi aiheuttaa rattijuopumustuomion päiviä tai jopa viikkoja käytön jälkeen. Kannabistuotteita ovat marihuana ja hasis. Kannabista käytetään polttamalla sitä joko

sellaisenaan tai tupakkaan sekoitettuna tai nauttimalla sitä ruokaan tai juomaan sekoitettuna. Kannabista ensisijaisena päihteenään käyttävien osuus päihdehuollon palvelujen käyttäjistä on suuri.

Kannabiksen käytön yhteydessä aistikokemukset korostuvat. Kokemattomille käyttäjille tai suu-rista annoksista aiheutuu ahdistus- ja paniikkikohtauksia, masentuneisuutta tai sekavuustiloja, jotka yleensä menevät ohi päihtymyksen lakatessa. Toisinaan saattaa esiintyä sydämen ”hakkaamista” ja hikoilua. Krooninen ja runsas kannabiksen käyttö lisää sen sietokykyä, ja säännöllinen ja päivittäinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen, joka on valtaosin psyykkistä. Mahdolliset vieroitusoireet ovat lieviä. Cannabis vahvistaa alkoholin ja joidenkin muiden päihteiden vaikutuksia, mikä saattaa altistaa päihderiippuvuuksille ja tapaturmille.

Amfetamiini ja sen johdokset luokitellaan erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Sen käyttöön liittyy voimakkaan riippuvuuden riski, ja sen vieroitusoireita ovat ahdistuneisuus, ärtyisyys, masennus ja uupumus. Pitkäaikainen käyttö johtaa sekavuuteen, harhaluuloihin, aistiharhoihin ja mahdollisiin ohimeneviin amfetamiinipsykooseihin. Amfetamiinista vieroitus saattaa vaatia kuukausien laitoshoidoa.

Ekstaasi luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sitä käytetään lähinnä pillereinä, kapseleina ja pulvereina. Ekstaasi on neurotoksinen, ja sen aiheuttamat aivovauriot ovat korjaamattomia. Vaurioiden ilmenevyys ja vakavuus eivät riipu suoraan käytön määrästä. Ekstaasin käyttäjillä esiintyy myös lyhytmuistin häiriöitä. Suomessa ekstaasin käytöstä johtuneet kuolemat ovat liittyneet ekstaasin ja masennuslääkkeiden yhteiskäyttöön.

Heroiini ja opiaatit luokitellaan erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi. Opiaatit ovat oopium-unikosta saatavia aineita, joista tunnetuin on heroiini. Heroiinia käytetään syömällä, polttamalla, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Opioidiriippuvuuden hoidossa käytettävä buprenorfiini (Temgesic, Subutex, Suboxone) on laillinen lääke, mutta se on myös yleisimmin päihteenä käytettävä katukauppaan levinnyt opiaatti Suomessa. He-

roiinien ja opiaattien aiheuttama vaikea riippuvuus ja käyttäjien syrjäytyminen ovat haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle. Heroiini on kaikista päihdyttävistä kipulääkkeistä voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttava, ja opiaatit aiheuttavat kaikista päihteistä voimakkaimmat vieroitusoireet ja aineen himon. Toleranssi kehittyy nopeasti, jolloin annostus kasvaa moninkertaiseksi. Heroiinista tai opiaateista riippuvainen käyttäjä ei välttämättä etsi eikä koe päihtymystä vaan tarvitsee ainetta saavuttaakseen normaalin olon ja pitääkseen vieroitusoireet loitolla. Tyypillisiä vieroitusoireita ovat pahoinvointi, oksentelu, sekavuus, levottomuus, apatia, ruokahaluttomuus sekä ihon kutina ja polttelu. Heroiinin käytön yliannoksesta seuraa syvä kooma, joka voi edetä kuolemaan asti. Heroiinin vieroitushoitoa järjestetään sekä avo- että laitoshoidona. Vieroitukseen on tehokasta lääkehoitoa ja myös lääkkeettömiä menetelmiä. Toipuminen edellyttää pitkäaikaista psykososiaalista hoitoa. Tapauksissa, joissa vieroittautuminen riippuvuudesta epäonnistuu toistuvasti, on mahdollista saada korvaus- ja ylläpitohoitoa.

Kokaiini on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se on valkoista jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Kokabase ja crack ovat poltettavaa kokaiinia. Kokaiini aiheuttaa voimakasta psyykkistä riippuvuutta, ja sen käytön yhteydessä esiintyy äkkikuolemia, sydämen toimintahäiriöitä, sydänkohtauksia, rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Kokaiinin nuuskaaminen voi johtaa hajuainstin menettämiseen, nenän verenvuotoon, krooniseen tulehdukseen tai nenän väliseinän tuhoutumiseen. Kokaiinin syöminen taas voi aiheuttaa suolistokuolion. Aliravitsemus on käyttäjillä tavallista, koska kokaiini vähentää ruokahalua. Psyykkistä kokaiiniriippuvuutta voidaan hoitaa joko avo- tai laitoshoidossa.

LSD on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se on lysergihappodietyyliamidia (LSD-25), joka on väritön, hajuton, mauton ja vesiliukoinen synteettinen valmiste. Sitä käytetään tabletteina, kapseleina, jauheena, liuksena ja sokeripaloihin tai papereihin imeytettynä. LSD aiheuttaa näköhallusinaatioita, aistikokemusten

muuttumista, kuten tunnetta yhteydestä tai sulautumisesta ympäristöön. Se aiheuttaa myös somaattisia oireita, kuten verenpaineen kohoamista, sydämen sykkeen tihenemistä, nopeaa ja syvää hengitystä, pahoinvointia, oksentelua ja ruokahaluttomuutta. Tavallisia ovat myös paniikki-, pelko- ja ahdistuskokemukset, joihin liittyy mielenterveyden menettämisen, hallinnan kadottamisen tai kuoleman pelkoja.

➔ Tutustu Käypä-hoito-suositukseen: Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositukset. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/

Sutinen, T. 2010. Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan sitä, että lääkettä käytetään tahallaan muuhun kuin lääkinälliseen tarkoitukseen ja siitä on terveydellistä haittaa. Lääkkeitä saatetaan käyttää tahallisesti väärin huumaus- tai päihtymystarkoituksessa ja myös urheilusuoritusten parantamiseen. Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja keskushermoston kautta vaikuttavat kipu- ja yskänlääkkeet. Usein näitä lääkkeitä käytetään yhdessä päihteiden, tavallisimmin alkoholin, kanssa, jolloin puhutaan sekakäytöstä. Sekakäytön tarkoituksena on lisätä päihtymystilaa. Sekakäytön seurauksena alkoholi vaikuttaa erittäin voimakkaasti ja aiheuttaa usein muistinmenetyksen ja johtaa käytöshäiriöihin sekä aivotoiminnan ja elintoimintojen heikkenemiseen. Sekakäyttö voi johtaa myös tajuttomuuteen tai pahimmillaan kuolemanvaaraan.

5.2 Terveyttä edistävä ohjaus

Terveyttä edistävä ohjaus on yksi terveydenhuoltohenkilöstön keskeisistä tehtävistä. Yksilöllistä terveysneuvontaa voidaan antaa muun muassa terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessä. Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa on asetettu seuraavat ikäryhmäkohtaiset tavoitteet:



Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet:

1. Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.
2. Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16–18-vuotiaista alle 15 prosenttia tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.
3. Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus vähenee kolmanneksen 1990-luvun lopun tasosta.
4. Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olot kehittyvät siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.

Kaikille yhteiset tavoitteet:

6. Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000.
7. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen ja koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
8. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.

(Terveys 2015 -kansanterveysohjelma)

Työ- ja elinoloihin ja elintapoihin tulisi vaikuttaa niin, että ne edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Erityistä huomiota tulee kohdistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen. Ihmisten elämäntavat ovat hankalasti muutettavissa, sillä ihmiset ovat usein riippuvaisia omista tavoistaan. Hoitohenkilökunnalla tulee olla hyvät tiedot ja taidot terveisiin elämäntapoihin tukemisessa ja ohjaamisessa. Nykyisin puhutaan terveystietämyksen sijasta terveysneuvonnasta.

Vastuu hoitoon sitoutumisesta on viime kädessä potilaalla itsellään, mutta hoitohenkilökunnalla on ammatillinen vastuu tukea ja motivoida potilasta päätöksenteossa ja itsensä hoitamisessa. Pitkäaikaissairaana näkökulmasta hoitoon sitoutumisesta on kysymys hoito-ohjeiden noudattamisen ohella myös laajemmin terveyttä tukevista ja sairauden pahenemista ehkäisevistä elämäntavoista. Pitkäaikaissairaiden hoito on haaste terveydenhuoltohenkilöstölle, sillä hoitoon sitoutumisella on myös kansantaloudellinen merkitys. Hoitamaton tai huonosti hoidettu pitkäaikaissairaus lisää potilaan hoitokäyntejä ja -päiviä sairaalassa ja aiheuttaa lisäsairauksia, jotka puolestaan taas lisäävät hoitokuluja.



Hakkarainen, P. 2017. Type 1 diabetes and work. Publication of the university of Eastern Finland. Dissertations in health sciences 437. Pysyvä linkki julkaisuun <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2642-5>

Tyypin 1 diabeetikoilla on monia työn ja diabeteksen yhdistämiseen liittyviä haasteita. Tutkimus osoitti, että lähes joka kolmas tyypin 1 diabetesta sairastavista palkansaajista oli salannut diabeteksen työtovereiltaan ja joka viides lähiesimieheltään. Sairauden salaaminen voi johtaa hoidon laiminlyöntiin työpäivän aikana. Salaamisen syitä olivat pelko heikoksi leimautumisesta, työsyrrinnästä, ei-toivotusta huomiosta, yksityisyyden menettämisestä ja siitä, että henkilön ajatellaan tavoittelevan etuja sairautellaan. Sen sijaan niillä, jotka kertoivat työyhteisössä avoimesti diabeteksestaan ja sen vaikutuksesta työskentelyyn, työpaikan ihmisuhteet, sosiaalinen tuki ja diabeteksen omahoito mahdollisuudet työaikana olivat paremmat.



Olli, S. 2008. Diabetes elämänkumppanina – nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumista kuvaava substansiivinen teoria. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

5.3 Julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, ja julkisen vallan tehtävänä on huolehtia väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta, ja sen tehtävänä on muun muassa valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja seurata ja ohjata lainsäädännön toteutusta. Ministeriö myös valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman, jonka valtioneuvosto hyväksyy. **Aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveysosasto)** taas vastaavat alueensa terveyden- ja sosiaalihuollon alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Ne toteuttavat erilaisia kehittämis- ja koulutusohjelmia ja käsittelevät myös mahdolliset terveydenhuoltohenkilöstöä koskevat valitukset.

Kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä. Ne voivat muodostaa keskenään kuntayhtymiä tai tuottaa palvelut yksin. Kunta voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut monella eri tavalla. Se voi muun muassa ostaa terveyspalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla palvelujen tarvitsija voi itse hankkia tarvitsemansa palvelun. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankitut palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Kunnan velvollisuutena on kehittää sosiaalisia oloja ja poistaa sosiaalisia epäkohtia. Sosiaalihuoltolaissa luetellaan sosiaalipalvelut ja -tehtävät, joista kunnan on huolehdittava. Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä ovat sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen ja ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Kuntien järjestämät **sosiaalipalvelut** koostuvat sosiaalityöstä, sosiaalipäivystyksestä, kotipalvelusta, omaishoidon tuesta, asumispalveluista, laitoshoidosta, perhehoidosta, kuntoutuksesta, lasten ja perheiden palveluista, ikääntyneiden palveluista, vammaispalveluista ja päihdetyöstä.

Kunta tai kuntayhtymä ylläpitää **terveyskeskusta**. Terveyskeskuksissa ovat saatavilla **perusterveydenhuollon palvelut**. Pienissä kunnissa on terveysasemat, joilla ei ole ympärivuorokautista päivystystä, jolloin sairastuneet ohjataan päivystysaikana lähimpään päivystävään yksikköön.

Tietoa sosiaalipalveluista:

www.finlex.fi (Sosiaalihuoltolaki 710/1982)

www.thl.fi

www.sosiaaliportti.fi

Terveyskeskuspalvelut ovat pääasiassa yleislääkäritasoisia. Julkinen terveydenhuolto on porrastettu siten, että sairastuneet hakeutuvat ensin terveyskeskukseen sairauden arviointia ja hoitoa varten. Terveyskeskuksessa toimii sekä päivystys- että ajanvarausvastaanotto. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hakeutuvat päivystysvastaanotolle. Päivystysvastaanotolta ajan saa yleensä samaksi päiväksi, mutta vuoroaan voi silti joutua odottamaan, koska kiireelliset tapaukset hoidetaan ensin. Ajanvaraus-



Kansanterveyslain mukaan terveyskeskuksen tehtävänä on

- huolehtia terveysneuvonnasta ja sairauksia ehkäisevästä työstä
- järjestää asukkaiden yleiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset
- järjestää neuvolatoiminta, esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolat
- järjestää koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto
- järjestää hammashuolto
- järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito
- järjestää kotisairaanhoitoa
- järjestää kuntoutuspalveluja
- järjestää sellaiset mielenterveyspalvelut, joita on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksissa
- järjestää sairaankuljetus.

vastaanotolle varataan aika puhelimitse, ja kiireetömissä tapauksissa hoitotakuu määrittelee vastaanotolle pääsyn kolmen vuorokauden sisällä. Sairastunut henkilö ohjataan perusterveydenhuollossa lääkärille, joka arvioi potilaan tilan ja ohjaa hänet tarvittaessa erilaisiin perusterveydenhuollossa tehtäviin tutkimuksiin tai antaa hänelle lähteen **erikoissairaanhoidon**.

Terveyskeskuksen henkilökunta koostuu tarpeen mukaan muun muassa lääkäreistä, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, bioanalytikoista, röntgenhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista, ravitsemusterapeuteista, psykoterapeuteista, psykologeista, kuntoutusohjaajista ja jalkojenhoitajista. Useimmissa terveyskeskuksissa on myös vuodeosasto eli terveyskeskussairaala tavallisia sairauksia sairastavien ja pitkäaikaissairaiden hoitoa varten.

Kunnat vastaavat asukkaidensa **erikoissairaanhoidon järjestämisestä**. Erikoissairaanhoidon

toia varten maa on jaettu **sairaanhoitopiireihin**, ja jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriä ylläpitävään kuntayhtymään. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on keskussairaala, ja näistä sairaaloista viisi on erityistason hoitoa tarjoavia yliopistosairaita. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan erikoislääkäreiden johtamaa osaa terveydenhuollosta. Erikoissairaanhoidon kuuluvat sairauksien tutkiminen ja hoito sekä sairauksia ehkäisevät ja kuntouttavat toiminnot. **Suomessa uudistetaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen.** Uudistuksen etenemistä voi seurata osoitteesta www.stm.fi/sote-uudistus ja siitä kerrotaan lisää jäljempänä tässä luvussa.

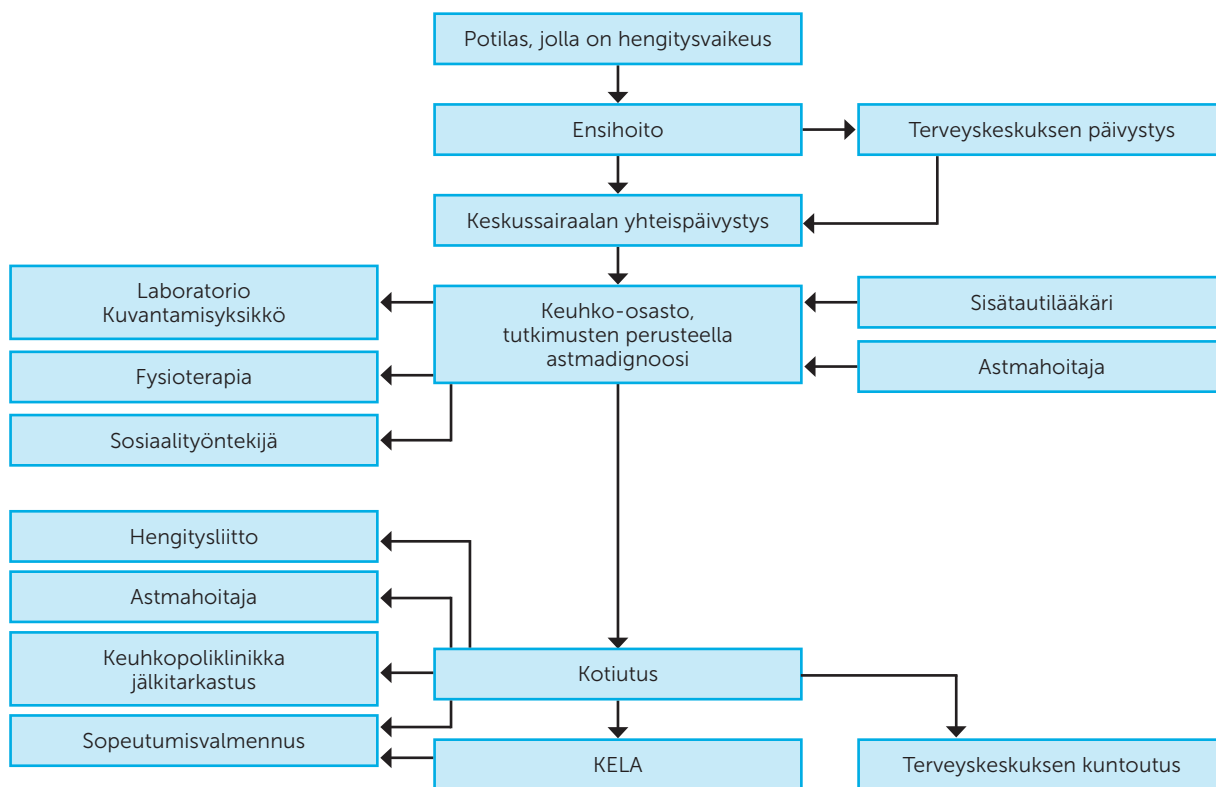
➔ Lisätietoa sairaanhoitopiireistä:

www.kunnat.net

Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoidonlaki:

www.finlex.fi

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326



Kuva 5.1 Hengitysvaikeuksissa päivystykseen hakeutuneen potilaan hoitopolku. Potilaalla diagnosoitiin astma.

Potilaan hoitopolku määrittää työjakoa eri asiantuntijoiden välillä ja kuvaa potilaan kulkua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän piirissä. Kuvassa 5.1 esitetään hengitysvaikeuksien vuoksi hoitoon hakeutuneen henkilön hoitopolku.

Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain myötä kansalaisten vapaus hoitopaikan ja hoitohenkilöstön valinnassa lisääntyi. Lisäksi potilaan merkitys oman hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu entisestään. Tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja voi nykyään saada myös omasta terveyskeskuksesta. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Laki vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla varmistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys.

➔ Best Practice -JBI-suositus: Hoitoketjujen vaikutavuus aikuisten ja lasten terveydenhuollossa.
www.hotus.fi

5.4 Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja kolmas sektori

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluja. Hankintalain perusteella kunta voi järjestää osan kuntalaisten terveyspalveluista yksityisten palveluntuottajien avulla. Yksityinen terveydenhuolto perustuu tavallisesti erikoislääkärin vastaanottotoimintaan ja yksityisiin sairaaloihin. Esimerkkejä yksityisistä palveluista ovat vanhusten palveluasumista tarjoavat yksiköt, mielen-terveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetut yksiköt sekä kehitysvammaisille tarkoitetut yksiköt. Lisäksi yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa terveydenhuoltoon liittyviä palveluita, kuten sairaankuljetuspalveluita ja yksityisiä avoterveydenhuollon palveluita (esim. neuvolapalveluita, kotisairaanhoidoa ja työterveyshuoltoa).

Yksityisten terveyspalveluiden maksajana voi toimia joko kunta tai potilas. Jos kunta hoitaa lääkimmäisen palvelutehtävänsä yksityisen terveydenhuollon avulla, palvelut ovat potilaalle samanhintaisia kuin julkiset palvelut. Jos taas yksityistä terveydenhuoltoa tarjotaan potilaalle kunnan palvelujen lisäksi, palvelut ovat potilaalle tavallisesti kalliimpia kuin julkisen sektorin palvelut.

Väestön ikärakenteen muuttumisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa edelleen. Jotta tarpeeseen pystytään vastaamaan, tarvitaan myös yksityisiä palveluita. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat ikääntyneiden palveluasuminen, ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito ja lasten päivähoito. Yleisimpiä yksityisiä terveyspalveluja ovat fysioterapia, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta ja työterveyshuolto.

Kolmas sektori eli vapaaehtoissektori on yksityisen ja julkisen terveydenhuollon ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteenä on voittoa tavoittelematon toiminta. Vapaaehtoissektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Useat järjestöt toimivat palvelutuotannon lisäksi jäsenistönsä edunvalvojina, vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa sekä asiantuntijatehtävissä. Osa järjestöjen henkilöstöstä on koulutettuja ammattilaisia, ja osaksi toiminta on vapaaehtoistyöntekijöiden varassa. Järjestöt saavat huomattavan osuuden rahoituksestaan julkisista varoista ja rahapeliyhtiö Veikkaukselta (aiemmin Ray). Veikkaus Oy on suomalainen peliyhtiö, joka hankkii yksinoikeuden turvin raha-automaattitoiminnalla varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Se antaa huomattavaa tukea erilaisille järjestöille.

Yksityisesti tuotettujen palvelujen tarve kasvaa edelleen. On odotettavissa, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilaaja-tuottajamalliin perustuva palvelujen järjestämistapa yleistyy. Myös palvelusetelin käytön laajentamisella halu-

taan edistää monipuolisten palvelumarkkinoiden syntymistä.

Sosiaalihuollon palvelujen antaminen on ympärivuorokautisten palvelujen osalta luvanvaraista. Muista kuin ympärivuorokautisista yksityisistä sosiaalipalveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Myös terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista ja edellyttää aluehallintoviraston tai Valviran lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

→ Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996, laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 ja asetus yksityisestä terveydenhuollosta 744/1990: www.finlex.fi

Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu

Suomessa on käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, niin sanottu sote-uudistus, joka on vielä tämän kirjan painoon mennessä luonnos- ja lausuntokierrosvaiheessa (9.11.2018). Sote-uudistukseen kuuluu myös osana Valinnanvapauslaki, joka tällä hetkellä on luonnosvaiheessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto tulee uudistumaan. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveysterveyst, mutta uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä tulee siirtymään 18 uudelle maakunnalle. Kun sote-uudistus astuu voimaan, laajenee samalla asiakkaan mahdollisuus valita, mistä hän sosiaali- ja terveysterveystpalvelunsa hakee.

Terveyskeskuksen sijaan esimerkiksi flunssan voi käydä hoidattamassa yleislääkärin vastaanotolla niin sanotussa sote-keskuksessa. Jokainen saa itse valita, missä sote-keskuksessa asioi. Keskuksia voivat ylläpitää maakuntien lisäksi yksityiset yritykset. Valinnanvapaus lisääntyy, mutta se ei silti ole rajatonta. Asiakas voi saada julkisilla eli maakunnan rahoilla vain sellaisia palveluja, joita maakunnat rahoittavat. Palveluntuottajan voi valita ai-

noastaan maakuntien hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Halutessaan palveluja voi hakea oman kunnan tai maakunnan ulkopuolelta. Asiakasmaksuista ei ole vielä tehty päätöksiä, sillä maakunta saa määritellä ne itse.

Sote-uudistuksen pääpaino on peruspalveluissa ja niiden tehostamisessa. Tavoitteena on siirtää painopistettä niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun nopeammin ja vähemmällä käynnillä. Kun peruspalveluja vahvistetaan, kalliiden erikoispalvelujen kuormitus vähenee ja asiakas saa apua jo varhaisessa vaiheessa. Palveluja tuotetaan tulevaisuudessa uudella tavalla. Lähipalvelua tulevaisuudessa ovat esimerkiksi liikkuvat ja sähköiset palvelut. Palveluja suunnitellaan viettävän myös kotiin ja sinne, missä ihmiset liikkuvat. Digitalisaation merkitys korostuu, ja julkisten palveluntuottajien rinnalle tulee myös muita palvelujen tarjoajia. Asiakkaan valinnanvapaus ei koske erityis- palveluja, kuten esimerkiksi turvakotipalveluja, vaan ne tuotetaan tulevien maakuntien palvelukeskuksissa. Yksityisille ja kolmannen sektorin palveluntuottajille määritellään kriteerit ja velvoitteet. Palveluntuottajana toimiminen edellyttää sopimusta maakuntien kanssa.

→ Sote-mietintöluonnos 7.11.2018: <https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Sote-mietinto-luonnokset-perustuslakivaliokuntaan.aspx>

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt historiallisen laajaa hallinnollista sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta erittäin merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista tiiviisti huhtikuusta 2018 alkaen ja kuullut suuren joukon asiantuntijoita. Työ on pohjautunut mittavaan asiakirja-aineistoon.

5.5 Terveysten edistämisen ammattilaiset

Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä toimii monia eri ammattilaisia erilaisilla ammattinimikkeillä. Lisäksi sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on monia eri toimintayksiköitä, jotka ovat merkittäviä potilaan hoitokokonaisuudessa. Hoitajan tehtävänä on koordinoita potilaan hoitoa niin, että kaik-

kia eri ammattiryhmiä ja toimintayksiköitä hyödynnetään oikea-aikaisesti potilaan hoitokokonaisuudessa. Hoitajan on tiedettävä eri ammattiryhmien ja toimintayksiköiden osaamisalueet, jotta hän voi kertoa ammattilaisista potilaalle ja ehdottaa heidän palvelujensa käyttöä. Potilaan hoitaminen on aina moniammatillista yhteistyötä, ja potilaan hoitoon liittyvien ammattien sisällön tuntemus on yhteistyön sujumisen edellytys. Toisten ammattitaidon kunnioitus ja kuunteleminen ovat myös hyvän hoidon perusedellytyksiä.

Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitajat toimivat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, avoterveydenhuollon tai yksityisen työnantajan palveluksessa. Työpaikka voi olla esimerkiksi sairaaloiden vuodeosastolla, poliklinikassa tai leikkausosastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- tai hoitokodissa tai lääkäriasemalla. Työ on pääosin vuorotyötä. Sairaanhoitajan työ edellyttää perehtyneisyyttä hoitotyöhön liittyvään uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Hoitotyön tutkimusta kutsutaan hoitotieteeksi. Sairaanhoitajan koulutus on myös **kätilöillä, terveydenhoitajilla ja ensihoitajilla**.

Asiantuntijasairaanhoitajat ovat perehtyneet tietynlaisiin terveysongelmiin ja niiden hoitoon. Asiantuntijasairaanhoitajia ovat esimerkiksi diabeteshoitajat, avannehoitajat ja haavahoitajat. Heillä on laajaa osaamista oman alueensa hoitotyöstä.

Lähihoitaja on toisen asteen oppilaitoksesta valmistuva sosiaali- ja terveystalon ammattilainen. Lähihoitajan koulutuksessa on useita suuntautumisvaihtoehtoja, ja koulutus antaa nykyään yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden. Yleisimpiä koulutusohjelmavaihtoehtoja ovat lasten ja nuorten hoito ja kasvatusta, sairaanhoito ja huolenpito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö ja vammaistyö, kun taas hieman harvinaisempia ovat asiakaspalvelu ja tiedonhallinta, suu- ja hammashoito, kuntoutus sekä ensihoito.

Lääkäri on viime kädessä vastuussa potilaan kokonaisuhoitosta palvelutapahtuman aikana. Hoitaja puolestaan hoitaa potilasta lääkärin määräysten mukaisesti. Hoitaja myös tiedottaa potilaan vointiin liittyvistä havainnoistaan lääkärille ja keskustelee tämän kanssa eri hoitovaihtoehtoista. Li-

säksi hoitaja avustaa lääkäriä toimenpiteissä ja tutkimuksissa. Lääkäri ja hoitaja muodostavat potilaan hoitotiimin, jonka tulisi toimia saumattomasti parhaan mahdollisen hoitotuloksen aikaansaamiseksi.

Terveydenhuollossa **sosiaalityöntekijä** tai **sosiaalihoitaja** osallistuu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Itsenäisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Toimintaterapeutti toteuttaa kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan pitämään yllä ja parantamaan toimintakykyään. Toimintaterapeutin asiakkaina voivat olla esimerkiksi vammautuneet, kehitysvammaiset, neurologisia sairauksia sairastavat, mielenterveysongelmaiset, oppimisvaikeuksista kärsivät ja liikuntaelinsairauksista kärsivät. **Fysioterapeutti** on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä



Sosiaalityöntekijä auttaa ja ohjaa muun muassa

- sairausvakuutuksen etuuksien hakemisessa (esim. sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset ja hoitotuet)
- selviytymistä tukevien palveluiden saamisessa (esim. kotipalvelu, vammaispalvelu ja päihdepalvelut)
- kuntoutuspalveluiden löytämisessä (esim. uudelleen koulutus, ensitieto- ja sopeutumisvalmennus)
- eläketurva-asioissa ja muiden sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien hakemisessa (esim. vakuutukset, toimeentulotuki ja omaishoidon tuki)
- potilasjärjestöihin ja niiden toimintaan opastamisessa.

ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. **Kuntoutusohjaaja** on kuntoutus- ja sosiaalipalvelujärjestelmän asiantuntija, joka ohjaa, neuvoa ja tukee sairastunutta tai vammautunutta ja tämän läheisiä selviytymään muuttuneessa elämäntilanteessa.

Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat aikuisten ja lasten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Laillistetut **ravitsemusterapeutit** ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Ravitsemusterapeutin ohjausta ja neuvontaa tarvitaan ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa aikuisten lihavuus, keliakia, kohonnut verenpaine, lasten ja nuorten syömishäiriöt, lasten lihavuus, lasten ruoka-allergiat ja osteoporoosi. **Psykoterapeutti** antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi oppia ymmärtämään paremmin itseään ja muita ja päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta, esimerkiksi psykoanalyttistä psykoterapiaa tai kognitiivista terapiaa.

Psykologi tekee muun muassa tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä, ja suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Psykologi auttaa muun muassa lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä. Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neuropsykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian ala. Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden tyyppiä ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Aivoperäisiä häiriöitä ovat muun muassa puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä tai tapaturmasta tai sairaudesta johtuvia. **Akuuttityöryhmä** on psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon työryhmä. Akuuttityöryhmän tehtävänä ovat psyykkisten kriisitilanteiden selvittely, tehostetun psykiatrisen avohoidon toteuttaminen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tarvitta-

essa psykiatrisen sairaalahoidon tai muun hoidon järjestäminen.

Röntgenhoitaja on radiografiatyön ja säteilyn käytön asiantuntija. Röntgenhoitaja tekee röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä suunnittelee ja antaa sädehoitoja. **Bioanalyttikko** (aikaisemmin laboratoriohoitaja) on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii kliinisessä laboratoriotyössä. Bioanalyttikot ottavat näytteitä, ohjaavat potilaita ja henkilökuntaa laboratoriotutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä, tekevät laboratoriotutkimuksia, huolehtivat tutkimusten luotettavuudesta ja laadunvarmistuksesta ja osallistuvat tutkimusten ja toiminnan kehittämiseen sekä opiskelijoiden ohjaukseen.

Kotiutus- tai SAS-hoitaja (SAS = selvitä, arvioi, sijoita) osallistuu SAS-työryhmän toimintaan, jossa tehdään päätökset vanhusten pitkäaikaisten palveluasumisen ja laitospaikkojen myöntämisestä. SAS-toiminnan tarkoituksena on asiakkaan sijoittaminen hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan vastaavaan paikkaan. Siinä vaiheessa, kun kotona selviäminen ei ole enää mahdollista, järjestetään palvelutarpeen arvioinnin edellyttämä hoitopaikka joko tehostetun palveluasumisen yksiköstä tai hoivakodista. Hoidon tarve arvioidaan palveluohjausryhmässä kiireellisyysjärjestyksessä. Toiminnasta vastaa työryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi vanhustenhuollon ylilääkäri, SAS-tiimin palveluohjaajat sekä vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Tarpeen mukaan työryhmässä on myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kotiutushoitajan tai SAS-hoitajan tehtäviin kuuluu potilaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden palveluohjaus ja lyhytaikaispaikkojen varaaminen vanhustenhuollon laitoksiin tai palvelukoteihin.

Jalkojenhoitaja ja jalkaterapeutti ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on ammattikorkeakoulututkinto. He ovat alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen ja ongelmien asiantuntijoita. Jalkojenhoitajan ja jalkaterapeutin ammattinimikkeet on nimikesuojattu.

Tulkkipalvelua saa henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Hoi-

tajan on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan **tulkki** esimerkiksi kuuroille, vammautuneille tai maahanmuuttajille, niin että he voivat osallistua omalla äidinkielellään hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon. **Sairaalateologi** on Suomen evankelisluterilaisen kirkon työntekijä, pappi tai lehtori, joka toimii sairaaloissa ja laitoksissa yhteistyössä henkilökunnan ja seurakuntien muiden työntekijöiden kanssa. Sairaalapappi voi antaa kuolevalle ehtoollisen tai sairaan voitelun, ja hän voi siunata vainajan hautaan. Sairaalasielunhoito on sielunhoito-, neuvottelu- ja koulutustyötä, jonka tarkoituksena on sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen.

5.6 Sairaaloiden toimintayksiköt

Jotta paikoin monimutkainen terveydenhuoltojärjestelmä toimisi sujuvasti, sairaalat ovat organisointuneet hallinnollisesti.

Osastoilla toimii hoitotyössä lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Tavallisesti lähihoitaja työskentelee sairaanhoitajan tai lähihoitajan työparina. Ammatinimikkeensä mukaisesti lähihoitajat työskentelevät nimenomaan potilaan lähihoidossa. Sairaanhoitajakin työskentelee potilaan lähihoidossa, mutta hänellä on myös suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä. Lisäksi sairaanhoitajan työnkuva on laajempi ja hänen tehtäviinsä kuuluu tavallisesti sellaisia tehtäviä, joita lähihoitajan työnkuvaan ei kuulu (esim. potilaan kokonaisvaltainen lääkehoito). Osastojen hoitotyön lähiesimiestehtävissä työskentelee osastonhoitaja, ja joissain paikoissa osastonhoitajan apuna hallinnollisissa tehtävissä on apulaisosastonhoitaja. Osastonhoitajalla on terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto, kuten sairaanhoitajan tutkinto, mutta hänellä on myös muuta hallinnollista koulutusta. Osastonhoitaja työskentelee osastolla ja vastaa hoitotyön laadusta.

Sairaalassa osastot ovat jakaantuneet osastoryppäisiin, joita kutsutaan usein tulosityksiköiksi. Tulosityksikön hoitotyön johdossa on ylihoitaja, joka

vastaa osastoryppään hoitotyön johtamisesta. Ylihoitajien lisäksi sairaaloissa on myös johtavia ylihoitajia tai hallintoylihoitajia, joiden tehtävänä on hoitotyön strateginen johtaminen sairaalassa.

Sairaaloissa on laitoksen koon ja erikoistumisen mukaan useita yksiköitä. Pikaista hoitoa tarvitsevat saapuvat **päivystyspoliklinikkaan** tai **yhteispäivystykseen**. Erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkaan tullaan yleensä terveyskeskuslääkärin läheteellä. Kun potilas tulee päivystyspoliklinikkaan, hänet arvioivat triagehoitaja ja lääkäri, joiden tehtävänä on arvioida hoidon tarpeen kiireellisyys. Arvion perusteella potilas ohjataan hoitoon joko terveyskeskus- tai erikoissairaanhoidon päivystykseen. Päivystyspoliklinikassa toimii myös päivystysosasto tai valvontayksikkö.

Ajanvarauspoliklinikka on sairaalan yhteydessä toimiva lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto, jonne potilas saa ajan lääkärin läheteellä. Ajanvarauspoliklinikat on yleensä jaoteltu erikoisalan mukaan esimerkiksi ortopedian, hematologian ja silmätautien poliklinikkoihin. Sairaaloissa voi myös olla tiettyihin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen, erikoistuneita poliklinikoita.

Näkökeskus on sairaalan yksikkö, joka on tarkoitettu näkövammaisille. Näkökeskukseen hakeudutaan lääkärin läheteellä. **Kuuloasema** taas vastaa kuulontutkimukseen ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista, kuten yksilöllisten korvakappaleiden valmistuksesta, kuulon apuvälineiden huollosta ja testauksesta, kuulokojeiden ja apuvälineiden kokeilemisesta ja ohjauksen antamisesta. Lisäksi kuuloaseman kautta järjestetään kotiin tulevien apuvälineiden asennukset.

Sairaalan **vuodeosastoilla** hoidetaan potilaita, jotka jäävät sairaalaan yhdeksi tai useammaksi yöksi hoidettaviksi tai tarkkailtaviksi. Vuodeosastoille voidaan ottaa potilaita esimerkiksi päivystyspoliklinikan kautta, hoitotoimenpiteiden jälkeen tai toisista sairaaloista. Suurissa sairaaloissa vuodeosastot on jaettu usein erikoisalojen mukaan esimerkiksi sisätautien, keuhkotautien ja kirurgiseen vuodeosastoon sekä lastentautien osastoon. Lääketieteen erikoisalat voidaan myös jakaa suuriin erikoisaloihin, kuten kirurgiaan ja sisätauteihin, ja edelleen suppeisiin erikoisaloihin, kuten gastroen-

terologiaan, endokrinologiaan, käsikirurgiaan, kardiologiaan, lasten neurologiaan ja kliiniseen mikrobiologiaan. Näiden alojen potilaita hoitavia osastoja saatetaan kutsua klinikoiksi tai vastuuyksiköiksi.

Leikkaus- ja anestesiaosasto sisältää yleensä leikkaussaleja ja heräämön. Jos potilaalle tehdään leikkaus, joka vaatii sairaalatarkkailua tai hoitoa, hän siirtyy heräämöstä vuodeosastolle. Leikkaussaleissa tehdään myös päiväkirurgisia toimenpiteitä, jolloin potilas pääsee kotiin jo samana päivänä. Leikkausosastolla työskentelee eri alojen lääkäreitä (esim. anestesia- ja kirurgeja, gynekologeja, silmä- ja korvaeläimiä) ja sairaanhoitajia. **Teho-osastolla ja tehostetun valvonnan yksikössä** hoidetaan tehohoitoa ja vaativaa valvontaa tarvitsevia. Osastosta vastaa anestesia- ja kirurgi. Synnytysosasto hoitaa synnytykset ja niihin liittyvät tilat. Synnytysosastolla työskentelee lääkäreitä, kättilöitä ja sairaanhoitajia.

Sairaalan tarvitsemista laboratoriotutkimuksista huolehtii **laboratorioyksikkö**. Kliinisen kemian laboratorio ottaa muun muassa verikokeita ja huolehtii verikeskustoiminnasta. Patologian laboratorio taas tutkii kudosis- ja solunäytteitä ja saattaa myös huolehtia ruumiinavauksista. Mikrobiologian yksikkö puolestaan tekee bakteerija virustutkimuksia ja -viljelyitä, ja kliinisen fysiologian yksikössä tehdään muun muassa keuhko- ja sydäntutkimuksia. Sairaalan yhteydessä toimii myös **kuvantamisyksikkö**, joka ottaa sairaalan tarvitsemat röntgen- ja muut kuvantamistutkimukset. Yksikössä työskentelee radiologeja ja röntgenhoitajia. Kuvantamisyksikössä tehtäviä tutkimuksia ovat muun muassa natiiviröntgen- ja tietokonetomografiatutkimukset, magneettikuvaukset, ultraäänitutkimukset, mammografiat ja toimenpideradiologia.

Välinehuoltokeskuksessa huolletaan sairaaloissa potilaiden tutkimiseen ja hoitoon tarvittavia laitteita ja välineitä. Välinehuoltokeskuksessa toimii asiantunteva välineiden huoltoon koulutautunut henkilökunta (ks. luku Aseptiikka hoitotyössä). **Apuvälineyksikkö** vastaa vaikeavammaisten tarvitsemien vaativan erikoistason apuvälinepalvelujen tuottamisesta. Apuvälineyksikön palveluihin kuuluvat muun muassa apuväli-

netarpeen ja apuvälineen käyttömahdollisuuksien arviointi, apuvälineiden sovitukset, käytön opetus, luovutus ja seuranta, apuvälineiden huolto ja korjaus sekä apuvälineineuvonta. Tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, kuten kävelykepin, kyynärsauvat ja hygieniavälineet, voi saada lyhytaikaiseen lainaan ilman etukäteen tehtävää arviointia. Apuvälineitä lainataan maksettua kotona asuville. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan apuvälineiden hankinnasta vastaa kyseinen laitos.

Sairaalakoulu sijaitsee usein sairaalan yhteydessä tai sen läheisyydessä. Sairaalahoidossa olevilla lapsilla on lain mukaan oikeus koulunkäyntiin ja opetuksen saamiseen. Koulujaksot voivat vaihdella muutamasta päivästä jopa kolmeen vuoteen. Sairaalakouluissa opetetaan neurologisesti, psyykkisesti tai somaattisesti sairaita lapsia. Lisäksi sairaaloissa on useita tukipalveluyksiköitä, jotka mahdollistavat sairaalan toiminnan. Niihin kuuluvat esimerkiksi ruokapalvelukeskus, tekninen keskus, siivouskeskus ja logistiikkakeskus.

Tutustu terveyskäyttämistä käsitteleviin lähteisiin:

UCL Department of Epidemiology and Public Health:

[/www.ucl.ac.uk/hbrc](http://www.ucl.ac.uk/hbrc)

The impact of health and behaviors on educational outcomes in high-income countries: a review of the evidence:

www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/

Four specific health behaviors contribute to a longer life: <https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm>

American Journal of Health Behavior:

<http://www.ajbh.org/>

Helldán, A. & Helakorpi, S. 2014. Suomalaisen aikuisväestön terveystietoisuus ja terveys, kevät 2014 Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2014.

www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN_ISBN_978-952-302-447-2.pdf?sequence

